ЛОР-справочник

Разборы клинических рекомендаций

13 рекомендаций Минздрава РФ · сборка от 22.10.2026 · каждый пункт сверен с текстом КР

Оглавление

Аллергический ринит 4
J30.1, J30.2, J30.3, J30.4

1. Главное 5
2. Клиника и классификация 5
3. Диагностика 6
4. Лечение 7
5. Дети, беременность, кормление грудью 11
6. Контроль лечения 11
7. Наблюдение, профилактика, госпитализация 12
8. Источник и актуальность 12

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин 13
J31.1, J35.1, J35.2, J35.3, J35.8

1. Главное 14
2. Клиника и классификация 14
3. Диагностика 15
4. Лечение 17
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 19
6. Источник и актуальность 20

Наружные отиты 22
H60.0, H60.1, H60.2, H60.3, H60.4, H60.5, H60.8, H60.9, H61.0, H61.8, H61.9, H62.0, H62.1, H62.3, H62.4, H62.8

1. Главное 23
2. Клиника и классификация 23
3. Диагностика 24
4. Лечение 24
5. Профилактика и госпитализация 26
6. Источник и актуальность 26

Носовое кровотечение 27
R04.0

1. Главное 28
2. Клиника и классификация 28
3. Диагностика 29
4. Лечение 30
5. Профилактика и госпитализация 32
6. Источник и актуальность 32

Острый ларингит 34
J04.0, J04.2

1. Главное 35
2. Клиника и классификация 35
3. Диагностика 36
4. Лечение 38
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 42
6. Источник и актуальность 42

Острый синусит **44**
J01
1. Главное 45
2. Клиника и классификация 45
3. Диагностика 46
4. Лечение 47
5. Госпитализация и осложнения 50
6. Источник и актуальность 50

Острый тонзиллит и фарингит **52**
J02, J02.0, J02.8, J02.9, J03, J03.0, J03.8, J03.9
1. Главное 53
2. Клиника и классификация 53
3. Диагностика 54
4. Лечение 55
5. Профилактика, госпитализация, осложнения 58
6. Источник и актуальность 59

Отит средний острый **60**
H65.0, H65.1, H66.0
1. Главное 61
2. Клиника и классификация 61
3. Диагностика 62
4. Лечение 63
5. После острого периода и госпитализация 66
6. Источник и актуальность 66

Паратонзиллярный абсцесс **67**
J36, J39.0, J39.1
1. Главное 68
2. Клиника и классификация 68
3. Диагностика 69
4. Лечение 70
5. Профилактика, госпитализация, осложнения 71
6. Источник и актуальность 71

Травма носа **73**
S00.3, S01.2, S02.2
1. Главное 74
2. Клиника и классификация 74

3. Диагностика 76
4. Лечение 77
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 82
6. Источник и актуальность 82

Хронический синусит **84**
J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J34.1

1. Главное 85
2. Клиника и классификация 85
3. Диагностика 88
4. Лечение 89
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 92
6. Источник и актуальность 93

Хронический средний отит **95**
H65.2, H65.3, H65.4, H66.1, H66.2, H66.3, H72.0, H90.0, H90.1, H90.2, H90.6, H90.7, H90.8

1. Главное 96
2. Клиника и классификация 96
3. Диагностика 97
4. Лечение 100
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 104
6. Источник и актуальность 104

Хронический тонзиллит **106**
J31.2, J35.0, J35.8, J35.9

1. Главное 107
2. Клиника и классификация 107
3. Диагностика 108
4. Лечение 109
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 111
6. Источник и актуальность 111

Клинические рекомендации

Аллергический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.1** — Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений **J30.2** — Другие сезонные аллергические риниты **J30.3** — Другие аллергические риниты **J30.4** — Аллергический ринит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 11.07.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/261_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Диагноз ставят, когда хотя бы два из четырёх симптомов (заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу) беспокоят ежедневно не меньше часа, прослеживается связь с аллергеном и аллергообследование положительное.
- Лечение подбирают по ступеням. На первой назначают один препарат: антигистаминный внутрь или в нос, кромоглициевую кислоту или монтелукаст. На второй предпочтителен назальный глюкокортикостероид. На третьей к нему добавляют один-два препарата из первой ступени, а четвёртая — омализумаб, который назначает только специалист.
- Назальные глюкокортикостероиды действуют сильнее антигистаминных препаратов внутрь и кромоглициевой кислоты, особенно при выраженной заложенности.
- Сосудосуживающие капли назначают только при обострении с выраженной заложенностью и только коротким курсом, на 3–7 дней.
- Контроль оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» на первом приёме и через 2–4 недели лечения.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Аллергический ринит — IgE-опосредованное воспаление слизистой оболочки носа, которое развивается под действием аллергенов. Хотя бы два симптома — заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в полости носа — проявляются ежедневно в течение часа и дольше.

2.2 Классификация

По причине выделяют сезонный, круглогодичный (бытовой) и профессиональный ринит. По течению — интермиттирующий, когда симптомы беспокоят меньше 4 дней в неделю или меньше 4 недель в году, и персистирующий, когда больше 4 дней в неделю и больше 4 недель в году.

При лёгком течении симптомы не мешают сну и дневным делам. При среднетяжёлом мешают работе, учёбе, спорту и нарушают сон. При тяжёлом без лечения пациент не может нормально работать, учиться и спать. Кроме того, различают обострение и ремиссию.

В диагнозе указывают аллергены, к которым выявлена повышенная чувствительность.

Отдельно выделяют локальный аллергический ринит. Симптомы типичные и чётко связаны с аллергеном, но кожные пробы и специфические IgE в крови отрицательны. Специфические IgE в носовом секрете в России не определяют, а назальные провокационные тесты положительны.

2.3 Жалобы

Основные жалобы — заложенность носа с дыханием ртом, сопением, храпом и изменением голоса; водянистые выделения; чихание, часто приступами по утрам; зуд, реже жжение в носу, иногда зуд нёба и глотки. Пациенты трут кончик носа ладонью («аллергический салют»), из-за чего появляется поперечная складка на носу. На поздних стадиях снижается обоняние.

Жалобы и анамнез собирают у каждого пациента с подозрением на аллергический ринит. При круглогодичной форме ведущий симптом — заложенность носа со слизистыми выделениями, при сезонной — приступы чихания, зуд и ринорея. Важно расспросить о связи симптомов с аллергеном и об аллергических болезнях у пациента и кровных родственников.

Из-за обильных выделений и нарушения проходимости слуховых труб бывают раздражение и отёк кожи над верхней губой и у крыльев носа, носовые кровотечения после сморкания, боль в горле и покашливание, боль и треск в ушах при глотании, снижение слуха.

При сезонном рините часто встречается оральный аллергический синдром — перекрёстная непереносимость свежих фруктов, овощей, орехов и семян. Проявления разные: от зуда во рту до анафилаксии.

2.4 Осмотр

Всем пациентам осматривают верхние дыхательные пути, проводят общий осмотр и аускультацию, чтобы не пропустить бронхиальную астму, конъюнктивит и атопический дерматит. Характерны затруднённое носовое дыхание, приоткрытый рот, тёмные круги под глазами, мацерация кожи над верхней губой, отёчность лица.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят, когда есть характерные жалобы (два симптома из четырёх, ежедневно не меньше часа), анамнез указывает на связь с аллергеном или на другие аллергические болезни и аллергообследование положительно.

Пациента ведут вместе оториноларинголог и аллерголог-иммунолог. Оториноларинголог проводит риноскопию и эндоскопию, дифференциальную диагностику, выявляет осложнения и анатомические нарушения и определяет показания к операции. Аллерголог-иммунолог ставит кожные и провокационные тесты, оценивает их, исключает астму и решает вопрос об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

3.1 ЛОР-осмотр

Переднюю риноскопию проводят всем. Обычно видны отёк носовых раковин и много водянистого секрета. Слизистая ярко-красная при обострении сезонного ринита и цианотичная или серая при круглогодичном, бывает «мраморной» (симптом Воячека), могут быть полипы.

Эндоскопию полости носа, носоглотки и пазух проводят, если стандартное лечение не помогает или ринит осложнённый. Проба с сосудосуживающим средством показывает, обратима ли обструкция.

Контроль симптомов оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» на первом приёме и через 2–4 недели лечения. Подробнее — в разделе «Контроль лечения».

3.2 Аллергообследование

Если противопоказаний нет, ставят кожные пробы (prick-тесты или скарификационные), чтобы подтвердить аллергическую природу ринита, найти причинные аллергены и решить вопрос об АСИТ.

Пробы ставят в аллергологическом кабинете. На результат влияют возраст младше 5 и старше 60 лет, приём системных глюкокортикоидов, антигистаминных и психотропных препаратов, дермографизм (ложноположительный результат) и недавняя острая аллергическая реакция (ложноотрицательный).

Специфические IgE в крови определяют, если кожные пробы противопоказаны или невозможны, их результат сомнителен или расходится с анамнезом.

По методу ImmunoCAP результат считается положительным при значении больше 0,70 kU/l.

Общий IgE для диагностики не назначают: он неинформативен.

3.3 Анализы

Развёрнутый общий анализ крови назначают при выраженных симптомах в обострении или перед АСИТ. Смотрят эозинофилы; лейкоцитоз со сдвигом влево — повод искать инфекцию, прежде всего острый риносинусит.

При выраженных симптомах в обострении можно сделать цитологию смывов из носа. Для аллергического ринита характерна эозинофилия носового секрета — 10% и больше.

Общий IgE определяют только перед назначением омализумаба (с 12 лет, при тяжёлом течении), потому что по нему рассчитывают дозу.

3.4 Лучевая и функциональная диагностика

Рентгенографию пазух делают при симптомах риносинусита (гнойные выделения, боль в проекции пазух, головная боль, температура) или при лейкоцитозе со сдвигом влево.

КТ пазух нужна, если лечение не помогает, обструкция выраженная и длительная, держится аносмия или аллергообследование отрицательное. Прежде всего её делают при подозрении на полипозный риносинусит.

Спирометрию с бронхолитиком проводят при кашле, свистящем дыхании и одышке, а также перед АСИТ, чтобы выявить скрытый бронхоспазм.

Перед инъекционной АСИТ записывают ЭКГ.

3.5 Дифференциальная диагностика

Аллергический ринит отличают от инфекционного ринита, аномалий внутриносовых структур, аденоидов у детей и полипозного риносинусита. Его отличают и от неаллергических ринитов: эозинофильного, лекарственного (НПВП, альфа- и бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, резерпин, долгий приём деконгестантов), гормонального (беременность, пубертат, менструальный цикл, контрацептивы, акромегалия, гипотиреоз), профессионального, атрофического ринита пожилых, пищевого и алкогольного, идиопатического. Кроме того, исключают первичную цилиарную дискинезию и муковисцидоз.

---

4. Лечение

Цель лечения — полный контроль симптомов. Если контакт с аллергеном, табачным дымом или другими раздражителями продолжается, можно добиться лишь уменьшения симптомов.

4.1 Ступени лечения

На любой ступени исключают контакт с аллергеном, при показаниях оперируют сопутствующую патологию и рассматривают АСИТ.

Ступень	Назначения
1-я ступень	Один препарат: антигистаминный внутрь без седативного эффекта, антигистаминный спрей в нос, кромоглициевая кислота в нос или монтелукаст.
2-я ступень	Один препарат, предпочтительно назальный глюкокортикостероид; можно антигистаминный внутрь или в нос либо монтелукаст.
3-я ступень	Назальный глюкокортикостероид вместе с одним или несколькими препаратами: антигистаминным внутрь или в нос, монтелукастом.
4-я ступень	Омализумаб при тяжёлом течении, с 12 лет. Назначает только специалист.
Для быстрой помощи	Сосудосуживающие капли коротким курсом или глюкокортикоиды внутрь.

> Прежде чем переходить на ступень выше, перепроверьте диагноз, приверженность лечению, сопутствующие болезни и анатомические аномалии.

4.2 Антигистаминные препараты внутрь

Антигистаминные препараты без седативного эффекта назначают всем пациентам: они уменьшают зуд, чихание, ринорею и заложенность. Цетиризин в больших дозах вызывает сонливость чаще остальных.

Седативные антигистаминные первого поколения не назначают: они вызывают сонливость, нарушают сон и могут приводить к апноэ во сне.

Препарат	Доза
Дезлоратадин	Взрослым и детям с 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 2,5 мг, детям 1–5 лет — 1,25 мг, детям 6–12 месяцев — 1 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки.
Лоратадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–12 лет при весе до 30 кг — 5 мг, больше 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки.
Фексофенадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 120 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 30 мг 2 раза в сутки.
Цетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5–10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–6 лет — 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз в сутки, детям 1–2 лет — 2,5 мг 2 раза в сутки, детям 6–12 месяцев — 2,5 мг 1 раз в сутки.
Эбастин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10–20 мг 1 раз в сутки. Есть форма для рассасывания под языком.
Рупатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Биластин	Взрослым и детям старше 12 лет — 20 мг 1 раз в сутки.

4.3 Назальные глюкокортикостероиды

Их назначают при среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно при выраженной заложенности. Они сильнее антигистаминных препаратов внутрь и кромоглициевой кислоты и помогают также при глазных симптомах. Возможны сухость, носовые кровотечения, редко перфорация перегородки, поэтому пациента нужно научить правильно вводить спрей.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Мометазон	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза; при необходимости до 4 доз. Детям 2–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Флутиказона фуроат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (55 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза. Детям 2–12 лет — 1 доза (27,5 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости 2 дозы.
Флутиказона пропионат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза. Детям 4–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Будесонид	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, для поддержки — 200 мкг в сутки. Не дольше 3 месяцев.
Беклометазон	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, это максимальная доза; для поддержки — 1 доза 2 раза в сутки.

4.4 Антигистаминные спреи и комбинации

Антигистаминные спреи быстро уменьшают симптомы, в течение 30 минут. Их назначают отдельно или вместе с другими препаратами; возможна сухость слизистой.

Если нужны и антигистаминный, и гормональный спрей, удобнее назначить один комбинированный.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза (0,14 мг) 2 раза в сутки, с 12 лет при необходимости 2 дозы. Не дольше 6 месяцев.
Левокабастин	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы 2 раза в сутки, при выраженных симптомах 3–4 раза. Если за 3 дня эффекта нет, препарат отменяют.
Азеластин и флутиказон	Взрослым и детям старше 12 лет — 1 доза (137 мкг азеластина и 50 мкг флутиказона) 2 раза в сутки.
Азеластин и мометазон	Взрослым с 18 лет — 1 доза (140 мкг азеластина и 50 мкг мометазона) 2 раза в сутки, курс 2 недели.
Мометазон и олопатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы 2 раза в сутки (в КР указано 50 мкг мометазона и 1200 мкг олопатадина). Детям 6–11 лет только при сезонном рините — 1 доза (25 и 600 мкг) 2 раза в сутки.

4.5 Монелукаст и кромоглициевая кислота

Монелукаст можно назначать при любой тяжести, отдельно или вместе с другими препаратами, но он слабее назальных глюкокортикостероидов.

Если у пациента ещё и бронхиальная астма, монелукаст помогает контролировать обе болезни. Курс — от 1 до 3 месяцев и дольше; по инструкции ограничений по длительности нет.

Если нужны и антигистаминный препарат внутрь, и монелукаст, можно назначить комбинированную таблетку левоцетиризина с монелукастом.

Кромоглициевую кислоту в нос назначают при лёгком течении. Она безопасна, но слабее антигистаминных препаратов, монелукаста и назальных глюкокортикостероидов.

Препарат	Доза
Монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 10 мг 1 раз в сутки, детям 6–15 лет — 5 мг, детям 2–6 лет — 4 мг (жевательная таблетка) 1 раз в сутки.
Левоцетиризин и монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 1 таблетка (5 мг и 10 мг) 1 раз в сутки.
Кромоглициевая кислота, спрей	Взрослым и детям старше 5 лет — 1 доза в каждый носовой ход 4 раза в сутки, при необходимости до 6 раз. Когда наступит эффект, можно применять только при контакте с аллергеном. Курс 4 недели.

4.6 Сосудосуживающие препараты

При обострении с выраженной заложенностью их назначают коротким курсом, на 3–7 дней.

Длительные курсы не назначают: после 10 дней развиваются привыкание, отёк слизистой и медикаментозный ринит.

Если нужны и антигистаминный, и сосудосуживающий препарат в нос, можно назначить комбинацию диметиндена с фенилэфрином, не дольше 7 дней.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Оксиметазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы 0,05% раствора 2–3 раза в сутки. Детям 1–6 лет — 1–2 капли 0,025%, детям от 5 недель до года — 1–2 капли 0,01%, до 4 недель — 1 капля 0,01% 2–3 раза в сутки. Курс 3–4 дня.
Ксилометазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза 0,1% раствора 1–3 раза в сутки, детям 2–6 лет — 1 доза 0,05% 1–2 раза в сутки. Не дольше 5–7 дней.
Диметинден и фенилэфрин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы спрея или 3–4 капли 3–4 раза в сутки. Детям 1–6 лет — только капли, по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

4.7 Тяжёлое течение

При тяжёлом обострении или если третья ступень не помогает, можно назначить короткий курс глюкокортикоидов внутрь.

Это четвёртая линия или лечение тяжёлого обострения. Вводить растворы и депо-формы глюкокортикоидов в носовые раковины недопустимо: это грозит тяжёлыми осложнениями вплоть до слепоты. Дозу преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона подбирают индивидуально; преднизолон в таблетках противопоказан детям до 3 лет.

Депо-формы глюкокортикоидов не назначают: побочные эффекты развиваются быстро, вплоть до надпочечниковой недостаточности.

Омализумаб рассматривают с 12 лет при тяжёлом персистирующем течении или тяжёлом обострении, если третья ступень не помогает.

Его вводят подкожно раз в 2 или 4 недели, доза от 75 до 600 мг — по таблице дозирования. При сезонном рините начинают хотя бы за неделю до начала пыления и продолжают до его окончания.

4.8 Без лекарств

Всем пациентам рекомендуют по возможности избегать контакта с аллергеном. Даже частичное ограничение облегчает течение и снижает потребность в лекарствах.

Всем рекомендованы изотонические солевые растворы для носа, в том числе на основе морской воды.

Перед введением назального глюкокортикостероида нос промывают: так препарат лучше контактирует со слизистой, а сухость и кровотечения возникают реже.

4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия

АСИТ рассматривают у всех пациентов в ремиссии, в том числе медикаментозной. Она уменьшает симптомы и потребность в лекарствах, предупреждает развитие астмы и расширение спектра аллергенов.

Показания, противопоказания и выбор аллергена определяет аллерголог-иммунолог, он же назначает АСИТ.

4.10 Хирургическое лечение

Операцию проводят только при сопутствующей патологии; показания определяет оториноларинголог по данным эндоскопии и рентгенологического обследования. Плановые операции в сезон пыления причинных аллергенов не проводят.

4.11 Нетрадиционные методы

Гомеопатию, фитотерапию, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха и физиотерапию не рекомендуют: доказательств их пользы нет.

Иглоукалывание можно рассмотреть в составе комплексного лечения.

5. Дети, беременность, кормление грудью

5.1 С какого возраста можно детям

Мометазон и флутиказона фуроат разрешены с 2 лет, флутиказона пропионат — с 4 лет, беклометазон и будесонид — с 6 лет.

Цетиризин и дезлоратадин разрешены с 6 месяцев, лоратадин — с 2 лет. Антигистаминные первого поколения (хлоропирамин, диметинден) разрешены с 1 месяца, но, когда ребёнок дорастёт до нужного возраста, предпочтение отдают препаратам без седативного эффекта.

Монтелукаст в дозе 4 мг разрешён с 2 лет, в дозе 5 мг — с 6 лет.

АСИТ по инструкциям к препаратам проводят с 5 лет.

Назальные глюкокортикостероиды назначают детям в минимальной эффективной дозе, а при длительном применении следят за ростом.

Лучше ограничить препараты с высокой биодоступностью — будесонид (30–40%) и беклометазон (40–50%). У дексаметазона биодоступность больше 80%; это важно помнить, потому что он входит во многие комбинированные капли.

5.2 Беременность и кормление грудью

У беременных нужно помнить о рините беременных: заложенность носа без признаков инфекции и аллергии, которая полностью проходит в течение 2 недель после родов. Выявленная сенсибилизация говорит в пользу аллергического ринита.

Кожные пробы во время беременности и кормления не ставят; вместо них определяют специфические IgE в крови.

Предпочтение отдают ограничению контакта с аллергеном и промыванию носа. Лекарства назначают, если этого недостаточно, взвешивая риск для матери и ребёнка.

Доказательств риска для человека нет у лоратадина, цетиризина и будесонида (категория B по классификации FDA).

В первом триместре лекарства по возможности не назначают, если в них нет жизненной необходимости.

При кормлении грудью лучше ограничиться местными средствами с минимальной биодоступностью: все системные препараты проникают в молоко.

6. Контроль лечения

Визуальная аналоговая шкала — линия длиной 10 см, на которой пациент отмечает, насколько его беспокоят симптомы. Если отметка от 0 до 50 мм, ринит контролируется, если 50 мм и больше — не контролируется.

У подростков и взрослых при отметке 5 см и больше начинают с антигистаминных препаратов на 2–4 недели. Если ринит стал контролируемым, лечение продолжают по потребности и рассматривают АСИТ. Если нет, добавляют назальный глюкокортикостероид или монтелукаст ещё на 2–4 недели. Если и тогда контроля нет, пересматривают диагноз, ищут сопутствующую патологию, рассматривают АСИТ и хирургическое лечение.

Ринит считается контролируемым, если за последние 4 недели не было симптомов, не нарушались сон и дневная активность, а тест «дыхание с закрытым ртом» нормальный. Любое отклонение, в том числе более частая потребность в препаратах быстрой помощи, означает потерю контроля, и тогда можно переходить на ступень выше.

Для теста пациента просят закрыть рот и 30 секунд дышать только носом.

Для дневника симптомов (шкала TNSS) пациент каждый день оценивает чихание, водянистые выделения, заложенность и зуд от 0 до 3 баллов, сумма — от 0 до 12. Врач считает среднее за 7 дней. Дневник ведут в обострение и для оценки эффекта АСИТ.

Отдельно оценивают лекарства: только антигистаминные — 1 балл, назальные глюкокортикостероиды — 2, системные глюкокортикоиды — 3.

7. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Каждому пациенту или его представителям объясняют суть болезни, составляют индивидуальный план лечения и учат управлять болезнью самостоятельно.

Пациенты находятся на диспансерном наблюдении у аллерголога-иммунолога или оториноларинголога: взрослые приходят не реже раза в год, дети — не реже двух раз в год. Наблюдение пожизненное или до стойкой ремиссии длительностью 3 года и больше.

АСИТ используют и для вторичной профилактики: она помогает предупредить астму, утяжеление ринита и расширение спектра сенсибилизации.

При пыльцевой сенсибилизации советуют ограничить перекрёстно-реагирующие продукты и растительные лекарства.

Лечат обычно амбулаторно. Госпитализируют при крайне тяжёлом или осложнённом течении, детей — при тяжёлом обострении с выраженной заложенностью, а также планово для ускоренного курса АСИТ. Выписывают, когда симптомы под контролем или курс АСИТ завершён.

8. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Аллергический ринит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 11.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2027 года
Код в рубрикаторе	261_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

8.1 Неточности в самом тексте КР

- Разовая доза кромоглициевой кислоты указана в КР как «2.8 мкг», суточная — как «22.4 мкг». Сверьте с инструкцией в ГРЛС.
- Подпись к алгоритму в приложении Г1 гласит «пациентов, получавших лечение ранее», а в оригинальном названии — «untreated patients», то есть не получавших лечения.
- В тексте доз мометазона и флутиказона фуроата повторяются обрывки фраз; на смысл доз это не влияет.

Клинические рекомендации

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.1** — Хронический назофарингит **J35.1** — Гипертрофия миндалин **J35.2** — Гипертрофия аденоидов **J35.3** — Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/662_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Сами по себе глоточная и нёбные миндалины у ребёнка — не патология. Обследование начинают из-за жалоб, клинических проявлений или сопутствующей болезни, на течение которой могут влиять аденоиды и миндалины.
- Гипертрофию нёбных миндалин диагностируют по жалобам, анамнезу и фарингоскопии с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин, а гипертрофию аденоидов — только с инструментальным подтверждением: эндоскопией носоглотки, рентгенографией носоглотки или КТ.
- Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей не проводят.
- При наличии показаний аденоиды и миндалины оперируют в плановом порядке; если показаний нет или есть абсолютные противопоказания, пациента динамически наблюдает оториноларинголог.
- Детей с гипертрофией аденоидов лечат консервативно только при признаках аденоидита. У детей младше 7–9 лет, если нет осложнений и заметного влияния на качество жизни, аденоидит не считают патологией и ограничиваются наблюдением.

2. Клиника и классификация

2.1 Определения

Гипертрофия аденоидов — увеличение глоточной миндалины со стойким затруднением носового дыхания и (или) другими осложнениями: обструктивными нарушениями сна, экссудативным средним отитом, деформацией лицевого скелета. Гипертрофия нёбных миндалин — увеличение одной или обеих нёбных миндалин; она может протекать бессимптомно или проявляться храпом, остановками дыхания во сне, нарушениями глотания и артикуляции, деформацией лицевого скелета.

Аденоидит — реактивные воспалительные изменения глоточной миндалины как органа местного иммунитета слизистых в ответ на антигены, попадающие на слизистую носа и глотки. У детей младше 7–9 лет без заметного влияния на качество жизни и без осложнений, например средних отитов, его не считают патологией.

Рецидивирующим острым синуситом называют 4 эпизода и больше за последний год. Рецидивирующий острый средний отит — 3 эпизода и больше за 6 месяцев или 4 и больше за 12 месяцев.

2.2 Причины

Наиболее вероятными причинами считают вирусную инфекцию, генетическую предрасположенность и влияние окружающей среды. Роль бактериальной инфекции, гастроэзофагеального рефлюкса и аллергии спорна. Обычно действует сразу несколько факторов, и выделить ведущий не удаётся.

Особое внимание уделяют вирусу герпеса IV типа: герпетическая инфекция — одна из частых причин выраженной гипертрофии глоточной миндалины со стойкой обструкцией носоглотки.

2.3 Классификация

Для аденоидов в России чаще всего используют классификацию А. Г. Лихачёва — по тому, какую часть сошника прикрывает ткань глоточной миндалины. При I степени она прикрывает не больше верхней трети сошника, при II — от 1/3 до 2/3, при III — больше 2/3.

Для нёбных миндалин чаще всего используют классификацию Б. С. Преображенского. Расстояние между вертикалью через середину язычка и линией по краю передней (нёбно-язычной) дужки делят на три части. При I степени миндалина занимает треть этого расстояния, при II — две трети, при III миндалины доходят до язычка и соприкасаются друг с другом.

2.4 Клиническая картина

Жалобы и симптомы чаще всего бывают при гипертрофии III степени. При I и II степени пациенты обычно, хотя и не всегда, ни на что не жалуются.

При гипертрофии нёбных миндалин родители обычно жалуются только на храп. В отличие от храпа при воспалении, он постоянный и часто не зависит от позы во сне. Иногда родители замечают и классические признаки синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС): дневную сонливость и снижение успеваемости. Значительно реже бывают изменения прикуса и лёгкая дисфония.

При гипертрофии аденоидов, в том числе в сочетании с увеличением нёбных миндалин, жалобы разнообразнее. Кроме нарушений дыхания во сне, беспокоят стойкое затруднение носового дыхания и его следствия — постоянно открытый рот, гипоназальность (закрытая гнусавость), сухость во рту. Нередко снижается слух из-за экссудативного среднего отита или в анамнезе есть повторные острые средние отиты. Даже при II степени ринологические симптомы — заложенность носа, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель — после простуды могут держаться до нескольких недель. У школьников с аденоидами часто бывают острые синуситы, в том числе рецидивирующие.

При аденоидите главная жалоба — кашель, обычно продуктивный, ночной и утренний: это проявление постназального синдрома, то есть стекания отделяемого по задней стенке глотки. Аденоидит бывает и при небольшой глоточной миндалине. При аденоидите на фоне гипертрофии аденоидов II–III степени обычно одновременно жалуются на заложенность носа и кашель.

Реактивные изменения глоточной миндалины после простуды или на фоне аллергического ринита у детей младше 7–9 лет физиологичны. Патологией их не считают, если нет осложнений (средних отитов, острого синусита) и симптомы — кашель или затруднённое носовое дыхание — не нарушают сон и дневную активность ребёнка.

Симптомы гипертрофии аденоидов и аденоидита не патогномоничны. Их отличают от острого и хронического риносинусита, аллергического, вазомоторного и гипертрофического ринита, искривления перегородки носа, инородных тел и новообразований полости носа и носоглотки. Гипертрофия аденоидов часто сопутствует острому и хроническому синуситу и аллергическому риниту.

У взрослых симптомы те же, что у детей.

2.5 Жалобы и анамнез

Уточняют, сколько длится болезнь, с чем пациент связывает её начало, как менялись жалобы и как они влияют на сон и повседневную активность ребёнка, какое было лечение, его эффект и нежелательные явления. Важно, есть ли симптомы вне эпизодов острых респираторных инфекций, и насколько они выражены сейчас по сравнению с прошлым. Из анамнеза жизни выясняют сопутствующие болезни, прежде всего аллергию: наблюдается ли по ним ребёнок у специалиста, как лечится, планируются ли операции. Большое значение имеют перенесённые операции и манипуляции в полости носа, включая назотрахеальную интубацию и любые назальные зонды.

---

3. Диагностика

Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин — не патология. Обследование оправдано, если есть жалобы, клинические проявления или сопутствующая болезнь, на течение которой могут влиять аденоидит, гипертрофия аденоидов или нёбных миндалин.

Гипертрофию нёбных миндалин диагностируют по жалобам, анамнезу и физикальному обследованию — фарингоскопии с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин. Для диагноза гипертрофии аденоидов, кроме этого, нужно инструментальное исследование: эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или компьютерная томография (КТ).

3.1 Осмотр

Всех пациентов осматривает оториноларинголог, чтобы оценить общее состояние, выраженность симптомов и сопутствующую патологию, — и амбулаторно, и при госпитализации в ЛОР-отделение.

Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей в амбулаторной практике не проводят: его результаты крайне субъективны, процедура неприятна ребёнку и может травмировать структуры глотки.

Лабораторные исследования для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин не используют; они нужны только для диагностики сопутствующих болезней.

3.2 Инструментальные исследования

При симптомах, характерных для гипертрофии аденоидов, проводят эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки.

Если эндоскоп гибкий и изображение можно сохранить на фото или видео, это наиболее предпочтительный метод. Эндоскопия носоглотки — метод первого выбора для дифференциальной диагностики и для оценки носоглотки после операции, в том числе в отдалённые сроки. Ригидный эндоскоп ребёнок, особенно дошкольник, переносит хуже, а осмотр без сохранения изображения значительно менее объективен для последующих консультаций.

Рентгенографию носоглотки в боковой проекции делают при симптомах, характерных для гипертрофии аденоидов, чтобы оценить размер глоточной миндалины.

Метод дешёвый, доступный и безболезненный. Минусы — небольшая лучевая нагрузка, необходимость правильной укладки с открытым ртом и невозможность отличить аденоиды от других объёмных образований носоглотки; результат не всегда соответствует выраженности симптомов. После аденотомии рентгенография малоинформативна: аденоиды нельзя отличить от компенсаторной гипертрофии трубных валиков и нельзя оценить рубцы.

КТ верхних дыхательных путей и шеи делают не всем, а по специальным показаниям — в сложных случаях, когда нужно отличить гипертрофию аденоидов от другой патологии носа с похожими симптомами или диагностировать их одновременно.

При гипертрофии аденоидов проводят тимпанометрию, чтобы объективно оценить состояние среднего уха.

3.3 Чего не делать

Мазки из глотки на микрофлору для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин у детей не берут. Условно-патогенные бактерии часто есть в глотке и у здоровых людей, поэтому ни рост, ни отсутствие роста при отсутствии признаков бактериальной инфекции не позволяют оценить риск и прогноз.

3.4 Консультации специалистов

По специальным показаниям пациента направляют к аллергологу-иммунологу, чтобы подтвердить или исключить сопутствующую аллергию и согласовать лечение. Направляют планово при клинических и анамнестических признаках аллергического ринита, атопической бронхиальной астмы или атопического дерматита.

В первую очередь консультация нужна при глазных симптомах или повторном чихании и зуде в носу; при ринологических симптомах, которые пациент связывает с цветением, животными или другими определёнными ситуациями; при повторных приступах кашля, свистящего или затруднённого дыхания и стеснения в груди, особенно ночью и рано утром; при кожных проявлениях атопического дерматита, крапивницы и других аллергических болезней кожи; при рецидивирующих острых средних отитах или риносинуситах.

При признаках повторяющихся обструктивных нарушений сна пациента по возможности планово направляют к специалисту по расстройствам сна для объективной диагностики и согласования лечения.

При врождённых или приобретённых изменениях челюстно-лицевой области пациента планово направляют к ортодонту.

По специальным показаниям пациента направляют к инфекционисту для диагностики персистирующих вирусных инфекций, прежде всего герпесвирусной.

Показание — хотя бы один из признаков, который держится 3 месяца и дольше: увеличение лимфоузлов в 3 группах и более (не меньше 3 узлов в каждой); увеличение печени и (или) селезёнки; снижение абсолютного числа нейтрофилов в анализе крови ниже возрастной нормы и (или) общего числа нейтрофилов ниже 5×10^9/л. Оториноларинголог только оценивает симптомы, а решение о лабораторном поиске вирусов принимает инфекционист.

4. Лечение

При наличии показаний гипертрофию аденоидов и нёбных миндалин лечат хирургически в плановом порядке. Если показаний нет или есть абсолютные противопоказания, пациента динамически наблюдает оториноларинголог. При хронической или врождённой сопутствующей патологии операцию проводят только по согласованию с профильным специалистом.

Абсолютные противопоказания к операции — шок, острая стадия инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения, поздние стадии тяжёлых инфекционных и онкологических болезней, тяжёлое, крайне тяжёлое или терминальное состояние из-за сопутствующих болезней. Относительные — неконтролируемое или плохо контролируемое течение сопутствующей соматической патологии и аномалии строения носа, резко повышающие риск серьёзных осложнений во время операции.

Консервативное лечение оправдано только при клинических и анамнестических признаках воспаления глоточной миндалины (аденоидита) или нёбных миндалин (тонзиллита), если есть соответствующие жалобы или осложнения.

4.1 Хирургическое лечение

Аденотомию при гипертрофии аденоидов делают по специальным показаниям, чтобы восстановить проходимость носоглотки, и только при отсутствии противопоказаний.

Показания у детей: частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, иногда с дневной сонливостью и вялостью); экссудативный средний отит, который не проходит 3 месяца, не поддаётся консервативному лечению и подтверждён тимпанометрией; рецидивирующие острые средние отиты или острые синуситы (3 эпизода и больше за 6 месяцев или 4 и больше за 12 месяцев), если исключены другие причины, прежде всего иммунодефицит, а медикаментозная профилактика не помогла; хронический синусит с выраженными симптомами или частыми обострениями, если не помогли 1–2 курса консервативного лечения; стойкое затруднение носового дыхания без других причин, которое ухудшает качество жизни или ведёт к деформации лицевого скелета по данным цефалометрии и заключению ортодонта или челюстно-лицевого хирурга; заключение других специалистов, что аденотомия нужна как этап лечения сопутствующей болезни, например перед кардиохирургической операцией.
Если обструктивные нарушения сна можно оценить объективно, ориентируются на индекс апноэ-гипопноэ: от 5 до 15 — среднетяжёлая форма, больше 15 — тяжёлая.
Детям аденотомию предпочтительно делать под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

Тонзиллотомию детям с гипертрофией нёбных миндалин делают по специальным показаниям, чтобы уменьшить миндалины. Основное показание — частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, иногда с дневной сонливостью и вялостью); при возможности ориентируются на индекс апноэ-гипопноэ, как при аденотомии.

Если у ребёнка одновременно есть показания и к тонзиллотомии, и к тонзиллэктомии, лучше сделать тонзиллэктомию. Тонзиллотомию предпочтительно проводить под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

Если увеличены и аденоиды, и нёбные миндалины, аденотомию делают вместе с тонзиллотомией по тем же показаниям, что и аденотомию.

Такую операцию проводят только под общим обезболиванием с обязательным визуальным контролем операционного поля, а в раннем послеоперационном периоде пациента наблюдают в ЛОР-отделении стационара.

Взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и синдромом обструктивного апноэ сна при отсутствии противопоказаний делают тонзиллэктомию, чтобы уменьшить симптомы апноэ.

> У рекомендации о тонзиллэктомии взрослым не указаны ни уровень убедительности, ни уровень достоверности доказательств. Кроме того, разделы о госпитализации, послеоперационном обезболивании и реабилитации говорят только об аденотомии и тонзиллотомии, а о тонзиллэктомии у взрослых не упоминают.

4.2 Консервативное лечение аденоидита

Консервативно лечат детей с гипертрофией аденоидов только при признаках аденоидита: продуктивном кашле из-за постназального затёка, выделениях из носа, периодическом затруднении носового дыхания. Если у ребёнка младше 7–9 лет нет заметного влияния на сон, еду и повседневную активность и нет осложнений, например средних отитов, это не патология, и врач ограничивается наблюдением.

Всем пациентам с аденоидитом назначают ирригационно-элиминационную терапию — промывание полости носа.

Нос орошают 1–2 раза в день изотоническими или гипертоническими (1,5–3%) солевыми растворами на основе морской воды: это облегчает туалет носа, уменьшает симптомы и улучшает условия для последующих местных лекарств. Детям дошкольного возраста не промывают нос большими объёмами раствора из-за высокого риска средних отитов.

По специальным показаниям при аденоидите назначают местные антибиотики, чтобы подавить условно-патогенную флору носоглотки.

Применяют назальный спрей фрамицетина, детям старше 2,5 года — комбинированный препарат дексаметазон + неомицин + полимиксин B + фенилэфрин, или раствор для ингаляций тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат. Курс короткий, до 7 дней. Показание — признаки бактериальной инфекции: слизисто-гнойные выделения из носа и по задней стенке глотки в течение всего дня или отсутствие улучшения за 7–10 дней противовоспалительной терапии.
Растворы антибиотиков для парентерального, внутриконъюнктивального или ушного введения в нос не вводят: они не предназначены для полости носа и могут нарушить мукоцилиарный транспорт.

Пациентам старше 2 лет с аденоидитом назначают отхаркивающие муколитики, чтобы уменьшить постназальный затёк. Подходят только препараты с преимущественно мукорегулирующим действием; оптимальным в КР назван карбоцистеин.

Карбоцистеин в сиропе, в том числе в виде карбоцистеина лизина моногидрата, назначают курсом от 1 до 3 месяцев. Он уменьшает постназальный затёк и повышает вероятность разрешения сопутствующего экссудативного среднего отита. При монотерапии отличие от выжидательной тактики становится заметным только ко 2–3-й неделе. Одновременно другие муколитики, в том числе местные, не назначают, чтобы не усилить затёк.

Детям старше 2 лет с аденоидитом и сопутствующим аллергическим ринитом назначают топические глюкокортикостероиды: #мометазон в виде назального спрея по 1 дозе (50 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в сутки (100 мкг в сутки) курсом от 1 до 3 месяцев.

Ни гипертрофия аденоидов, ни аденоидит, ни назофарингит не зарегистрированы в России как показание ни для одного местного глюкокортикостероида; знак # означает применение вне инструкции.

Масла, в первую очередь масло туи, при гипертрофии аденоидов и аденоидите не применяют: их эффективность не доказана, а в носу они угнетают работу ресничек, нарушают эвакуацию секрета и повышают риск бактериальной инфекции.

Ежедневно промывать нос растворами антисептиков не рекомендуется: эффективность не доказана, нарушается мукоцилиарный транспорт и возможны местные дисбиотические изменения.

4.3 Обезболивание после операции

При боли после аденотомии и (или) тонзиллотомии назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол. Обезболивают при жалобах на боль или других её проявлениях — отказе от еды и питья, повторной рвоте и тошноте.

Препарат	Доза у детей
Ибупрофен	8–10 мг/кг на приём, не больше 30 мг/кг в сутки, внутрь в форме по возрасту (таблетки, покрытые оболочкой, — с 6 лет); младшим детям — ректальные суппозитории.
Кетопрофен	С 6 лет — гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь (кетопрофена лизиновая соль), 40 мг на приём до 3 раз в день.
Парацетамол	10–15 мг/кг на приём, не больше 60 мг/кг в сутки, в любой форме по возрасту. Если принимать внутрь нельзя, а свечей нет, — парентерально 15 мг/кг на введение.

4.4 После операции

После аденотомии и (или) тонзиллотомии оториноларинголог осматривает пациента перед выпиской и амбулаторно через 7–14 дней после выписки, чтобы оценить состояние и исключить поздние послеоперационные осложнения.

В течение 5–7 дней после операции соблюдают охранительный режим.

Он включает ограничение контактов (без детского коллектива и людных мест), ограничение физической нагрузки и исключение перегрева, особенно головы и шеи, в том числе отказ от горячей еды и питья.

Если дисфония сохраняется больше месяца после операции, пациента направляют к логопеду-дефектологу.

Если симптомы обструктивных нарушений сна сохраняются больше 6–8 недель после операции, пациента направляют к специалисту по расстройствам сна.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

5.1 Профилактика

Специфической профилактики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин нет. Поскольку важную роль играют респираторные вирусы, соблюдают общие правила профилактики ОРВИ. Некоторые лекарства можно использовать для плановой и экстренной профилактики аденоидита у детей.

Детям старше 1 года из групп риска по респираторным инфекциям назначают стандартизированные растительные препараты для приёма внутрь из группы прочих антисептиков, чтобы предупредить эпизоды ОРВИ и сделать последующие эпизоды аденоидита короче и легче.

Это препараты с корнем алтея, цветками ромашки, хвощом, листьями грецкого ореха, тысячелистником, корой дуба и одуванчиком лекарственным. Их назначают и для лечения аденоидита при появлении симптомов ОРВИ — отдельно или в комплексе.

Детям старше 3 лет при появлении симптомов острого назофарингита назначают комбинированный препарат лизоцим + пиридоксин, чтобы последующий аденоидит был короче и легче.

Детям из групп риска по респираторным инфекциям назначают лизаты бактерий (другие иммуностимуляторы), чтобы эпизоды аденоидита и его осложнений были короче и легче.

Обычно это плановая профилактика курсами по инструкции 2–3 раза в год; подходят и формы для приёма внутрь, и местные.

Для профилактики аденоидитов и их осложнений у детей можно рассмотреть местные пробиотики на основе бактерий нормальной микрофлоры глотки.

В информации для пациента КР советует обратиться к врачу, если после простуды у ребёнка появились и в течение 2 недель не проходят заложенность носа, храп, снижение слуха или кашель (когда исключена патология нижних дыхательных путей).

5.2 Госпитализация и выписка

Госпитализируют для плановой аденотомии и (или) тонзиллотомии при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. Аденоидит лечат амбулаторно или в консультативно-диагностическом отделении. Выписывают после операции при удовлетворительном общем состоянии и отсутствии осложнений.

5.3 Что влияет на результат

При хронических соматических болезнях после аденотомии и (или) тонзиллотомии возможно их обострение в раннем послеоперационном периоде. Аллергический ринит повышает вероятность, что назальные симптомы — передняя и задняя ринорея, меньше заложенность — не пройдут полностью. Ожирение повышает вероятность сохранения обструктивных нарушений сна после операции. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь повышает вероятность сохранения назальных симптомов и риск инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде.

При гипертрофии нёбных миндалин лекарственное лечение аденоидита очень мало помогает избавиться от обструктивных нарушений сна.

Если у ребёнка есть сопутствующая болезнь, которая может повлиять на результат операции, врач должен сказать об этом пациенту или родителям до операции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	662_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Рекомендация о тонзиллэктомии взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и СОАС дана без уровня убедительности и уровня достоверности доказательств, а разделы о госпитализации, обезболивании и реабилитации упоминают только аденотомию и тонзиллотомию.
- Для хронического аденоидита в разделе 1.4 предложены два кода: J31.1 («как возможный вариант кодирования») и J35.8 («например, аденоидит»).
- Растительные препараты рекомендованы в разделе профилактики, но в комментарии к ним сказано, что их назначают и для лечения аденоидита при симптомах ОРВИ.

- В комментарии к ибупрофену фраза о суппозиториях оборвана: «ректальные суппозитории (у детей младше) 2 лет»; возрастная граница неоднозначна.
- В рекомендации об осмотре после операции пропущено слово: «через 7-14 после выписки» — по смыслу дней.
- Сведения о незарегистрированных показаниях для мометазона даны «на конец 2020 года», хотя КР утверждены в 2024 году.
- В разделе профилактики есть ссылка «см. КР 25» без пояснения, о каких рекомендациях речь.

Клинические рекомендации

Наружные отиты

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H60.0** — Абсцесс наружного уха **H60.1** — Целлюлит наружного уха **H60.2** — Злокачественный наружный отит **H60.3** — Другие инфекционные наружные отиты **H60.4** — Холестеатома наружного уха **H60.5** — Острый наружный отит неинфекционный **H60.8** — Другие наружные отиты **H60.9** — Наружный отит неуточненный **H61.0** — Перихондрит наружного уха **H61.8** — Другие уточненные болезни наружного уха **H61.9** — Болезнь наружного уха неуточненная **H62.0** — Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.1** — Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.3** — Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.4** — Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.8** — Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 13.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/663_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Наружный отит — воспаление ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.
- Неосложнённый наружный отит лечат местно: ушными каплями, а при бактериальном отите в первую очередь фторхинолонами. Всем нужны туалет слухового прохода и обезболивание.
- Системные антибиотики при неосложнённом отите не назначают. Они нужны при постлучевом отите, сахарном диабете, иммуносупрессии и хондроперихондрите.
- Эффект оценивают через 48–72 часа. Если его нет, уточняют диагноз: это может быть атопический или контактный дерматит, псориаз или экзема.
- При злокачественном наружном отите сильная боль, грануляции, в посеве синегнойная палочка, лечение не помогает больше недели; чаще болеют пожилые с сахарным диабетом. Нужны глюкоза крови, КТ, госпитализация и антибиотики не меньше 6 недель.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Наружный отит — воспалительные изменения ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.

Отит бывает острым и хроническим, если длится дольше 6–12 недель. Диффузный наружный отит включает экзему, дерматит, рожу, герпес, перихондрит, хондроперихондрит и злокачественный наружный отит. Ограниченный — это фурункул и абсцесс.

Воспаление начинается с повреждения кожи: травмы, долгого пребывания во влажной среде, сахарного диабета, дерматита или экземы. Предрасполагают узкий слуховой проход, экзостозы, слуховой аппарат, попадание воды, нарушение образования серы и облучение.

2.2 Жалобы

Пациенты жалуются на дискомфорт и боль в ухе, часто сильнее при надавливании и жевании; боль может отдавать в глаз, зубы, глотку. Слух снижается, если слуховой проход полностью закрыт. Иногда беспокоят зуд и выделения. Температура обычно субфебрильная.

2.3 Осмотр

При осмотре видны гиперемия, отёк, инфильтрация и лихенификация кожи слухового прохода, иногда ушной раковины и поверхностного слоя барабанной перепонки, а также патологическое отделяемое. При ограниченной форме находят абсцессы и инфильтраты, бывает регионарный лимфаденит.

2.4 Особенности форм

Фурункул слухового прохода в стадии инфильтрации вызывает дискомфорт, который усиливается при манипуляциях в ухе, а после формирования абсцесса на первый план выходит боль. При диффузном отите беспокоят боль, выделения и иногда снижение слуха.

При экзематозном отите видны желтовато-розовые очаги с чешуйками, беспокоит зуд, иногда сильный и появляющийся раньше высыпаний. Затем образуются микровезикулы, эрозии и мокнутие, причём элементы разных стадий видны одновременно.

При герпетическом поражении за 1–2 суток до высыпаний появляются жжение, зуд и покалывание, затем эритема, пузырьки и корочки. Обычно всё проходит за 10–14 дней, при вторичной инфекции — за 3–4 недели.

3. Диагностика

Диагноз ставят по характерным жалобам и клинической картине; при необходимости его подтверждают лабораторно и другими методами.

Отделяемое отправляют на посев на бактерии, на микроскопию и посев на грибы, делают цитологию; при подозрении на новообразование — биопсию.

Мазок берут до начала противомикробного лечения, под контролем отоскопии, тампоном на глубине до 0,3 см из просвета или со стенок слухового прохода, не касаясь его наружных отделов.

Если после стихания воспаления пациент жалуется на снижение слуха, проводят аудиометрию, чтобы исключить острую нейросенсорную тугоухость. При неосложнённом наружном отите возможна кондуктивная тугоухость.

КТ и МРТ нужны при осложнённой форме, когда есть костные секвестры или абсцессы, чтобы оценить распространённость процесса. При неосложнённом отите лучевая диагностика не нужна.

Если наружное ухо поражено на фоне системного, в том числе инфекционного, заболевания, пациента направляют к профильному специалисту и дообследуют.

3.1 Злокачественный наружный отит

При злокачественной форме определяют глюкозу крови, чтобы выявить сахарный диабет: в 90–100% случаев злокачественный отит сочетается с ним.

Основные признаки злокачественного наружного отита: боль в ухе и головная боль на стороне поражения, отёк стенок и выделения из слухового прохода, грануляции в нём, микроабсцессы в области уха и основания черепа, очаг воспаления на сцинтиграфии, отсутствие эффекта от лечения больше недели и синегнойная палочка в посеве.

Дополнительно учитывают сахарный диабет, поражение черепных нервов, истощение и пожилой возраст. Если сцинтиграфию сделать нельзя, назначают местное лечение на 1–3 недели: отсутствие улучшения говорит в пользу злокачественного отита.

4. Лечение

Всем пациентам устраняют предрасполагающие факторы, хорошо обезболивают и регулярно проводят туалет наружного слухового прохода.

4.1 Местное лечение

Неосложнённый наружный отит лечат местно, препаратами, которые действуют на золотистый стафилококк и синегнойную палочку. Эффект оценивают через 48–72 часа. Если симптомы держатся, уточняют диагноз: это может быть атопический или контактный дерматит, псориаз или экзема.

При бактериальном наружном отите ушные капли с фторхинолонами — препараты первого выбора.

Ушные капли назначают всем пациентам с бактериальным наружным отитом; варианты — в таблице ниже.

При любой форме применяют антисептики (бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид; йод с калия йодидом и поливиниловым спиртом) и противомикробные средства: фторхинолоны, аминогликозиды, противогрибковые. При местном лечении 65–95% пациентов выздоравливают на 7–10-е сутки.

При экзематозной форме назначают кортикостероиды вместе с противомикробными средствами.

4.2 Ушные капли

Препарат	Состав	Возраст
Офлоксацин	офлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (в КР — «Комбинил»)	антибактериальный — ципрофлоксацин; противовоспалительный — дексаметазон	с 18 лет
Норфлоксацин	норфлоксацин	с 15 лет
Рифамицин	рифамицин	без ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин B	антибактериальный — неомицин + полимиксин B; анестетик — лидокаин	с 1 года
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол	антибактериальный — хлорамфеникол; противогрибковый — клотримазол; противовоспалительный — беклометазон; анестетик — лидокаин	с 6 лет
Дексаметазон + неомицин + полимиксин B	антибактериальный — неомицин + полимиксин B; противовоспалительный — дексаметазон	без ограничений
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон	антибактериальный — фрамицетин + грамицидин; противовоспалительный — дексаметазон	без ограничений

> В этой КР капли с норфлоксацином разрешены с 15 лет, а в КР «Отит средний острый» — детям старше 1 года. Проверьте возраст по инструкции в ГРЛС.

4.3 Системные антибиотики

При неосложнённом наружном отите системные антибиотики не назначают: если добавить их к местному лечению, результат не улучшается.

Системные антибиотики нужны при постлучевом наружном отите, сахарном диабете и иммуносупрессии.

Злокачественный наружный отит лечат системными антибиотиками не меньше 6 недель; препараты должны действовать на синегнойную палочку и стафилококк.

При хондроперихондрите ушной раковины назначают системные антибиотики и противовоспалительные средства, чтобы снять боль и отёк.

4.4 Хирургия и другое

При ограниченном отите вскрывают и дренируют абсцессы слухового прохода. При злокачественном удаляют грануляции, костные и хрящевые секвестры и холестеатому в пределах зоны поражения.

Для повышения эффективности лечения применяют физиотерапию.

Посевы повторяют до тех пор, пока не подтвердится, что возбудитель исчез.

При сахарном диабете и нарушении толерантности к глюкозе контролируют уровень глюкозы крови.

5. Профилактика и госпитализация

Для профилактики советуют реже пользоваться ватными палочками и не чистить слуховой проход слишком часто, а также соблюдать гигиену берушей, слуховых аппаратов и наушников.

Лечат обычно амбулаторно, а при некротическом (злокачественном) наружном отите госпитализируют. Выписывают, когда воспаление в слуховом проходе стихло и гнойно-септических осложнений нет.

Медицинская реабилитация не рекомендована.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружные отиты»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 13.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее ноября 2027
Код в рубрикаторе	663_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые. Для детей — отдельная КР «Наружный отит» (21_3)

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Норфлоксацин в каплях: здесь — с 15 лет, в КР «Отит средний острый» — детям старше 1 года.
- В таблице 1 у фрамицетина с дексаметазоном антибактериальный компонент назван «Грамидин»; по названию препарата — грамицидин.
- Одна строка таблицы 1 дана торговым названием «Комбинил» (ципрофлоксацин + дексаметазон).
- Сокращение «зО» в разделе 2.5 — по смыслу злокачественный наружный отит.

Клинические рекомендации

Носовое кровотечение

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**R04.0** — Носовое кровотечение
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/977_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- При кровотечении из передних отделов носа сначала плотно прижимают крылья носа к перегородке на 5 минут и дольше.
- Если кровотечение не угрожает жизни, сначала его останавливают местно — прижатием, сосудосуживающим средством, коагуляцией или тампонадой, — и только потом корректируют свёртываемость или отменяют антикоагулянты.
- Если кровотечение продолжается, а источник не виден, ставят переднюю тампонаду.
- Всем пациентам измеряют артериальное давление: это помогает выявить гипертензию и оценить кровопотерю.
- Госпитализируют, если первичные меры не помогли, кровопотеря большая или кровотечение интенсивное, есть признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология или высокий риск рецидива, а также всегда при переливании крови, задней тампонаде, перевязке сосудов и эмболизации.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Носовое кровотечение — кровотечение из повреждённых сосудов полости носа, околоносовых пазух или носоглотки, а также из сосудов полости черепа при повреждении верхней стенки полости носа.

2.2 Причины

Кровотечения бывают посттравматическими, в том числе после операций, и спонтанными. Спонтанное кровотечение — симптом местной или общей болезни.

Сосуды слизистой носа страдают при её атрофии, специфическом воспалении (туберкулёз, сифилис), опухолях носа и пазух, сосудистых мальформациях и гранулематозе с полиангиитом.

У детей кровотечение чаще всего вызвано повреждением слизистой (инородное тело, травма, в том числе ятрогенная), острыми инфекциями верхних дыхательных путей и опухолями.

У детей до двух лет носовое кровотечение бывает очень редко, примерно у одного из 10 000. Если оно случилось в этом возрасте, нужно исключить болезни крови и врождённую патологию, например гемангиому полости носа и носоглотки.

2.3 Классификация

По механизму кровотечение бывает вызвано изменениями сосудов носа, нарушением свёртывания крови или сочетанием причин. По источнику — из передних или задних отделов полости носа, из околоносовых пазух, носоглотки или внутричерепных сосудов.

2.4 Клиническая картина

При переднем кровотечении кровь в основном течёт наружу, при заднем — стекает в носоглотку.

Пациенты жалуются на кровянистые выделения из носа, часто на стекание крови по задней стенке глотки и недомогание. Если кровь заглатывалась, бывают дискомфорт в животе, тошнота и чёрный стул.

2.5 Общие симптомы и объём кровопотери

Шок	Признаки	Кровопотеря
Не выражен	Признаков нет	до 10% объёма крови (до 500 мл)
Лёгкий	Пульс до 100, систолическое давление выше 100 мм рт. ст., холодные конечности, нормальный диурез	15–20% (750–1250 мл)
Средний	Пульс до 120, систолическое давление 90–100 мм рт. ст., сниженное пульсовое давление, беспокойство, потливость, бледность, диурез меньше 50 мл в час	25–35% (1250–1750 мл)
Тяжёлый	Пульс больше 120, систолическое давление ниже 60 мм рт. ст. или не определяется, ступор, резкая бледность, холодные конечности, сухие язык и кожа, анурия	больше 35% (больше 1750 мл)

2.6 Анамнез

Уточняют, когда началось кровотечение, сколько длится и как часто повторяется, с какой стороны были прошлые кровотечения, были ли из-за них госпитализации и переливания крови. Расспрашивают о приёме антиагрегантов, антикоагулянтов и других препаратов, о гипертензии, коагулопатиях, анемии, кровотечениях у родственников, травмах и операциях на носу и пазухах.

Носовое кровотечение может быть первым признаком коагулопатии, наследственной телеангиэктазии, опухоли носа или носоглотки, болезни печени или почек, особенно если оно повторяется. Синяки и петехии без причины и кровотечения из внутренних органов в анамнезе говорят в пользу системного нарушения свёртывания.

Кровотечение на фоне антикоагулянтов (варфарин, гепарин, дабигатран, апиксабан и другие) или антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел) может потребовать отмены или снижения дозы. У таких пациентов кровотечения чаще повторяются и чаще бывают больше 250 мл, требуя переливания крови. Риск повышают также многие спреи для носа, в том числе сосудосуживающие и гормональные, и некоторые наркотические вещества.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят, когда кровянистые выделения из носа подтверждены при риноскопии и фарингоскопии.

3.1 Осмотр

Каждого пациента осматривает оториноларинголог: оценивает состояние, ищет источник кровотечения и выбирает тактику.

Если госпитализация нужна, выбирают стационар с дежурным оториноларингологом. Если во время кровотечения ЛОР-врач пациента не осмотрел, в том числе потому, что кровотечение остановилось само, пациента направляют к нему планово.

Оценивают пульс, сознание, кожу и слизистые, чтобы не пропустить гиповолемию. Обморок, тахикардия, тахипноэ и бледность говорят о гемодинамических нарушениях из-за кровопотери. Кровоизлияния на коже и слизистых без травмы могут указывать на системное нарушение свёртывания.

При повторных кровотечениях из обеих половин носа или если они бывают у родственников, ищут телеангиэктазии на слизистой носа и рта, чтобы не пропустить наследственную геморрагическую телеангиэктазию (болезнь Рандю — Ослера — Вебера).

Всем пациентам измеряют артериальное давление, чтобы выявить гипертензию и оценить гиповолемию: гипотония может говорить о значительной кровопотере.

Если источник не виден при передней риноскопии, проводят эндоскопию полости носа и носоглотки.

Повторяющееся кровотечение с одной стороны может быть первым признаком опухоли, которую не видно при передней риноскопии, а у детей — инородного тела.

3.2 Анализы

Общий анализ крови назначают, чтобы оценить постгеморрагическую анемию и тромбоциты; для оценки кровопотери определяют гемоглобин и гематокрит.

3.3 Степень кровопотери у взрослого

Степень	Объём кровопотери	Гемоглобин, г/л	Гематокрит, %
I	до 500 мл	больше 120	больше 40
II	500–1000 мл	100–120	30–40
III	1000–1500 мл	80–100	20–30
IV	больше 1500 мл	меньше 80	меньше 20

При повторяющихся кровотечениях и при кровотечении, требующем госпитализации, исследуют гемостаз: МНО, фибриноген, АЧТВ и протромбиновое время. МНО особенно важно у пациентов на варфарине: значение выше 4,5 прогностически неблагоприятно.

При приёме прямых пероральных антикоагулянтов (дабигатран, ривароксабан и др.) эти показатели могут не отражать степень гипокоагуляции.

3.4 Консультации

Если есть гипертензия, анемия, коагулопатия или другие сопутствующие болезни, влияющие на кровотечение, пациента консультирует терапевт или педиатр.

При повторяющихся кровотечениях с признаками тромбоцитопатии или коагулопатии в анализах пациента консультирует гематолог.

---

4. Лечение

Цель — остановить кровотечение, устранить факторы риска и скорректировать последствия кровопотери, включая гиповолемию и анемию.

Если кровотечение не угрожает жизни, сначала его останавливают местно: прижатием крыльев носа, сосудосуживающим средством, коагуляцией или тампонадой. Только после этого корректируют свёртываемость или отменяют антикоагулянты и антиагреганты, потому что системная коррекция опасна, прежде всего тромбоэмболиями.

4.1 Остановка кровотечения

При кровотечении из передних отделов носа сначала плотно прижимают крылья носа к перегородке на 5 минут и дольше, обычно на 5–15 минут. Перед этим пациент сморкается, чтобы удалить сгустки; сидит или стоит, слегка наклонив голову вперёд. Это может сделать и сам пациент. Если кровь продолжает стекать, источник, скорее всего, находится глубже, и нужны другие методы.

Если кровотечение продолжается, а источник найден, взрослым на него накладывают турунду с сосудосуживающим средством, а взрослым и детям можно приложить гемостатик.

Однократно применяют #ксилометазолин или #эпинефрин на турунде; #оксиметазолин в спрее — по 2 впрыскивания в каждую ноздрю 3 раза в день 3–5 дней (знак # означает применение вне инструкции). Сосудосуживающие препараты осторожно применяют при гипертензии, ИБС и ишемии мозга.

На турунде можно однократно приложить к источнику #транексамовую кислоту (взрослым: 5 мл на кусочек ваты или марли на 10–30 минут) или этамзилат (взрослым и детям).

Если кровотечение продолжается, а источник найти не удаётся, ставят переднюю тампонаду.

Рассасывающиеся материалы, например коллагеновая гемостатическая губка, не нужно удалять, и это их преимущество: при удалении тампона кровотечение может возобновиться. Поэтому при высоком риске повторного кровотечения, например при наследственной телеангиэктазии или болезнях крови, по возможности используют их.
У детей источник обычно спереди, поэтому, если ребёнок позволяет, лучше обойтись без тампона; если он не готов к манипуляциям, предпочтительна передняя тампонада.

Если кровотечение из задних отделов не останавливается передней тампонадой, ставят переднюю и заднюю тампонаду с тампоном в области хоан и носоглотки.

Пациента с задним тампоном наблюдают и лечат в стационаре. Нитка или фиксатор не должны сильно давить на крыло носа, иначе образуется пролежень. Некоторые авторы назначают при задней тампонаде системные антибиотики.

Если кровотечение продолжается и источник найден, кровоточащий сосуд коагулируют.

Коагулировать можно химически (нитратом серебра), электрокоагулятором, лазером или радиоволной. Если перед этим приложить сосудосуживающее средство, коагуляция эффективнее.

Если коагуляция и тампонада не помогают, рассматривают эмболизацию сосудов или перевязку артерии.

В редких случаях перевязывают наружную сонную артерию на стороне кровотечения. Эмболизация эффективна до 87% случаев, но осложняется чаще, чем перевязка; её можно делать под седацией и при стоящих тампонах.

При повторяющихся кровотечениях из зоны Киссельбаха отслаивают слизистую перегородки носа.

Операцию не делают при субатрофии слизистой и выраженном искривлении перегородки.

4.2 Лекарства

При повышенном давлении назначают антигипертензивные препараты: так уменьшаются кровопотеря и риск рецидива.

Если первичные меры недостаточны, назначают гемостатики: транексамовую кислоту (внутривенно с 1 года, в таблетках с 3 лет), аминокапроновую кислоту, аминометилбензойную кислоту, этамзилат — в дозах по инструкции. При продолжающемся кровотечении лучше вводить внутривенно, таблетки подходят для профилактики рецидивов.

Этамзилат системно оправдан только при диапедезном кровотечении из мелких сосудов слизистой.

При травматическом кровотечении или риске тяжёлого кровотечения пациентам старше года как можно раньше, лучше в первые 3 часа после травмы, вводят транексамовую кислоту внутривенно.

Пациентов с коагулопатиями и переливание крови по возможности ведут вместе с гематологом, терапевтом или педиатром.

Детям с геморрагическим синдромом при дефиците витамина K вводят менадиона натрия бисульфит: новорождённым — до 4 мг в сутки, от месяца до года — 2–5 мг в сутки. Можно вводить и профилактически, не дожидаясь подтверждения дефицита.

После кровотечения или его остановки назначают увлажняющие и заживляющие средства для слизистой носа.

Они уменьшают сухость и корки, чтобы пациент не чистил нос сам; показаны и при субатрофическом рините.

5. Профилактика и госпитализация

Пациентам объясняют факторы риска повторного кровотечения, как останавливать его самому и когда обращаться к врачу.

Объясняют, что нельзя ковырять в носу, особенно детям, родителям и пожилым; пожилым — что риск связан с лекарствами и подъёмом давления. Слизистую сушат кислородные канюли и аппараты для дыхания под давлением. Пациентам на варфарине обязателен контроль МНО. Если кровотечения повторяются на фоне спреев для носа, дозу уменьшают и учат правильно ими пользоваться.

Если кровотечение связано с повышением давления, пациента консультирует терапевт, педиатр или кардиолог, чтобы подобрать антигипертензивную терапию.

5.1 Госпитализация

Нужна ли госпитализация после передней тампонады, решают по длительности кровотечения, объёму кровопотери, признакам гиповолемии, сопутствующим болезням, типу тампона и доступности амбулаторной помощи. При активном кровотечении или нестабильной гемодинамике пациента обследуют и лечат в приёмном или ЛОР-отделении.

При кровотечении на фоне гипертонической болезни ЛОР-врач останавливает кровотечение в приёмном отделении, затем пациента госпитализируют в терапевтический стационар, чтобы нормализовать давление.

При небольшом или уже остановившемся кровотечении пациента можно обследовать амбулаторно.

Госпитализируют, если первичные меры не помогли, кровопотеря значительная или кровотечение интенсивное, есть признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология или высокий риск рецидива. Всегда госпитализируют при переливании крови, задней тампонаде, перевязке сосудов и эмболизации, а также после передней тампонады нерассасывающимся материалом, если удалить тампоны амбулаторно нельзя.

Значительной считается кровопотеря больше 10% объёма крови (около 500 мл у взрослого), интенсивным — кровотечение больше 1 мл/кг в минуту. Риск тяжёлого кровотечения повышают госпитализации из-за кровотечений в анамнезе, особенно с переливанием крови, и больше трёх эпизодов за последние 3 месяца.

Выписывают, когда кровотечение стойко остановлено, признаков гиповолемии нет, гемодинамика нормальная, а сопутствующие болезни компенсированы.

Исход во многом определяют скорость и объём кровопотери: массивная кровопотеря больше 40% объёма крови может быть несовместима с жизнью.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Носовое кровотечение»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 08.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	977_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

6.1 Неточности в самом тексте КР

- У рекомендации о гемостатической терапии уровень доказательств записан как «уровень доказательств – 4» вместо принятого «уровень достоверности доказательств».
- В оглавлении PDF вместо номеров страниц нескольких разделов стоит «Ошибка! Закладка не определена».

Клинические рекомендации

Острый ларингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J04.0** — Острый ларингит **J04.2** — Острый ларинготрахеит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 01.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/309_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Ларингоскопия обязательна каждому пациенту. С 12 лет гортань осматривают зеркалом; если у маленького ребёнка это не удаётся, проводят видеофиброринофаринголарингоскопию.
- При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции антибиотики не назначают, пока симптомы держатся меньше 10 дней.
- При дисфонии назначают полный голосовой покой на 1–2 суток, затем ограничение голосовой нагрузки; пациент отказывается от острой, солёной, горячей и холодной пищи, алкоголя и курения.
- Флегмонозный, абсцедирующий и инфильтративный ларингит и хондроперихондрит гортани — показание к срочной госпитализации в стационар, где есть отделение интенсивной терапии и можно интубировать трахею.
- Ларингит без стеноза гортани на фоне ОРВИ госпитализации не требует; экстренно госпитализируют при дыхательной недостаточности выше I степени.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Острый ларингит (ОЛ) — острое воспаление слизистой оболочки гортани длительностью до 3 недель. Если болезнь длится дольше 3 недель, нужно исключать её аутоиммунную природу.

Абсцедирующий, или флегмонозный, ларингит — острый ларингит с образованием абсцесса, чаще на язычной поверхности надгортанника или на черпалонадгортанных складках. Он проявляется резкой болью при глотании и разговоре, отдающей в ухо, повышением температуры и плотным инфильтратом в тканях гортани. Острый хондроперихондрит гортани — острое воспаление хрящей гортани, при котором процесс захватывает надхрящницу и окружающие ткани.

Острый подскладочный ларингит (круп) — воспаление в подголосовом пространстве с отёком слизистой под голосовыми складками, затруднением дыхания и одышкой. Он встречается у детей от 6 месяцев до 6 лет.

2.2 Причины

Обычно острый ларингит — часть острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ): гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, при которых воспалены также слизистая носа и глотки, а иногда и бронхи и лёгкие. Воспаление гортани может быть и продолжением катарального воспаления носа или глотки.

Основные возбудители бактериального ларингита — S. pneumoniae (20–43%) и H. influenzae (22–35%); довольно часто высевают Moraxella catarrhalis (2–10%), разные стрептококки и стафилококки, значительно реже — Neisseria, Corynebacterium и других.

Кроме инфекции, ларингит вызывают наружная и внутренняя травма шеи и гортани, в том числе ингаляционная, инородное тело, аллергия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и большая голосовая нагрузка. Предрасполагают к нему хронические болезни бронхов и лёгких, носа и околоносовых пазух, сахарный диабет, гипотиреоз, болезни желудочно-кишечного тракта, хроническая почечная недостаточность, нарушение разделительной функции гортани, алкоголь, курение и перенесённая лучевая терапия.

2.3 Классификация

По форме различают катаральный, отёчный, флегмонозный (инфильтративно-гнойный, в том числе инфильтративный и абсцедирующий) и острый подскладочный ларингит. По возбудителю ларингит бывает вирусным, бактериальным, грибковым и специфическим.

2.4 Клиническая картина

Основные симптомы — нарушение голоса от лёгкой дисфонии до афонии, острая боль в горле и кашель; может затрудняться дыхание и ухудшаться самочувствие. Болезнь начинается внезапно, при удовлетворительном состоянии или небольшом недомогании. При катаральном ларингите температура нормальная или субфебрильная; фебрильная температура обычно говорит о том, что воспалились нижние дыхательные пути или катаральный процесс перешёл во флегмонозный.

При инфильтративной и абсцедирующей формах сильно болит горло, трудно глотать даже жидкость, усиливается слюноотделение, голова в вынужденном положении, выражена интоксикация, нарастают признаки стеноза гортани. Чем тяжелее воспаление, тем ярче симптомы; общее состояние становится тяжёлым. Без адекватного лечения возможны флегмона шеи, медиастинит, сепсис, абсцедирующая пневмония и стеноз гортани.

Картина острого стеноза гортани одинакова при любой причине и зависит от степени сужения: дыхание становится шумным, меняется его ритм, при вдохе западают надключичные ямки и втягиваются межрёберные промежутки, пациент запрокидывает голову, гортань опускается на вдохе и поднимается на выдохе.

При неполной обструкции появляется стридор. Если преобладает отёк, дыхание свистящее, если гиперсекреция — хриплое и клокочущее. В терминальной стадии стеноза дыхание становится всё тише, потому что уменьшается дыхательный объём.

При абсцессе надгортанника на фоне острой боли сначала становится невозможно глотать, а затем, по мере прогрессирования, затрудняется дыхание. Голосовая щель может закрыться очень быстро, и тогда нужны экстренные меры для спасения жизни.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу, жалобам, осмотру и ларингоскопии. Обычно болезнь начинается внезапно на фоне небольшого недомогания, пациента беспокоят изменение голоса, боль при глотании, кашель, повышенная температура. При тяжёлых формах ухудшается общее состояние, глотать больно даже жидкость, температура фебрильная, усилено слюноотделение, нарушено дыхание; шея и гортань болезненны при пальпации, подвижность хрящей гортани нарушена, голова и шея в вынужденном положении.

3.1 Осмотр

Пациента с подозрением на острый ларингит осматривает оториноларинголог, врач общей практики (семейный врач) или педиатр, чтобы поставить и уточнить диагноз.

При осмотре обязательно ищут признаки дыхательной недостаточности; главный из них — одышка. При I степени одышка возникает при физической нагрузке, при II — при малой нагрузке (неспешная ходьба, умывание, одевание), при III — в покое.

3.2 Стадии стеноза гортани

Стадия	Признаки
Компенсация	В покое одышки нет, при ходьбе появляется; просвет гортани сужен на треть.

Стадия	Признаки
Субкомпенсация	Инспираторная одышка при нагрузке с участием вспомогательных мышц, втяжение межрёберных промежутков, яремной и надключичных ямок, стридор, бледность кожи; давление нормальное или повышенное; просвет сужен наполовину и больше.
Декомпенсация	Дыхание поверхностное и частое, резкий стридор, вынужденное положение сидя, максимальные экскурсии гортани, бледно-синюшное лицо, потливость, акроцианоз, частый нитевидный пульс, давление снижено; просвет гортани щелевидный.
Асфиксия	Дыхание прерывистое или прекращается, голосовая щель резко сужена, сердечная деятельность угнетена, пульс частый, нитевидный, часто не прощупывается, кожа бледно-серая; потеря сознания, экзофтальм, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, остановка сердца.

Если стеноз нарастает быстро, состояние тяжелее, потому что компенсаторные механизмы не успевают развиться. Это учитывают, решая вопрос об экстренной операции.

3.3 Ларингоскопия

Всем пациентам с острым ларингитом проводят ларингоскопию, чтобы осмотреть гортань.

Непрямая ларингоскопия гортанным зеркалом обязательна при осмотре пациентов 12 лет и старше оториноларингологом и в поликлинике, и в стационаре. У дошкольников и младших школьников в поликлинике она часто невозможна из-за эмоциональной лабильности и сильного глоточного рефлекса; тогда проводят видеофиброринофаринголарингоскопию.

При ларингоскопии определяют характер процесса, его локализацию, уровень, протяжённость и степень сужения дыхательных путей. Для острого ларингита типичны гиперемия и отёк слизистой гортани с усиленным сосудистым рисунком; голосовые складки розовые или ярко-красные, утолщены, голосовая щель при фонации овальная или линейная, со скоплением мокроты. Процесс может захватывать подскладковый отдел; при подскладковом ларингите видно валикообразное утолщение слизистой под голосовыми складками.

При катаральной форме изменения видны в основном на голосовых складках, в межчерпаловидном или подскладковом пространстве: расширенные поверхностные сосуды и слизистый или слизисто-гнойный секрет, усиливающий охриплость. При отёчной форме гиперемирована и отёчна вся слизистая гортани, голосовые складки смыкаются не полностью. При ларингите на фоне гриппа или ОРВИ бывают кровоизлияния в слизистую — от петехий до небольших гематом (геморрагический ларингит).

Белый или беловато-жёлтый фибринозный налёт означает переход в более тяжёлую, фибринозную форму, а серый или бурый налёт может быть признаком дифтерии. Если налёт у взрослого не связан с интубационной травмой, его нужно срочно дифференцировать с системными заболеваниями и туберкулёзом.

При инфильтративном ларингите поражённый отдел гортани значительно инфильтрирован, гиперемирован, увеличен и малоподвижен, часто видны фибринозные налёты, а там, где формируется абсцесс, просвечивает гной. При тяжёлой форме и хондроперихондрите гортань болезненна при пальпации, хрящи малоподвижны, кожа над гортанью может быть инфильтрирована и гиперемирована на фоне боли и общей гнойной инфекции. Абсцесс надгортанника выглядит как шаровидное образование на его язычной поверхности с просвечивающим гноем; он сопровождается сильной болью и нарушением глотания.

3.4 Анализы

Пациентам с острым ларингитом делают развёрнутый общий анализ крови, чтобы оценить общее состояние и выявить воспалительную реакцию — лейкоцитоз и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

При флегмонозном ларингите всех пациентов при госпитализации комплексно обследуют клинически и лабораторно.

Гнойное отделяемое отправляют на посев на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением возбудителя и его чувствительности к антибиотикам и другим препаратам, чтобы выбрать адекватное лечение.

При поступлении в стационар проводят стандартное лабораторное обследование.

3.5 Другие исследования

Детям младшего и дошкольного возраста проводят пульсоксиметрию, чтобы оценить степень дыхательной недостаточности и решить, нужен ли кислород.

По показаниям и для дифференциальной диагностики проводят компьютерную томографию (КТ) гортани с внутривенным болюсным контрастированием.

КТ имеет смысл в стационаре, если подозревают гнойные осложнения или трудно отличить ларингит от других болезней гортани. Если у ребёнка с признаками стеноза КТ сделать нельзя, в сомнительных случаях делают рентгенографию шеи в прямой и боковой проекциях.

---

4. Лечение

Лечение выбирают по форме и тяжести воспаления.

4.1 Режим

Всем пациентам с острым ларингитом при любой дисфонии ограничивают голосовую нагрузку — не кричать и не шептать не менее 2 дней — и назначают лечебно-охранительный режим.

При дисфонии рекомендуют полный голосовой покой на 1–2 суток, затем ограничение любой голосовой нагрузки. Пациент отказывается от острой, солёной, горячей и холодной пищи, спиртного и курения.

> Сроки голосового покоя в КР расходятся: в рекомендации — не кричать и не шептать «не менее 2-х дней», в комментарии к ней — полный голосовой покой «на 1–2 суток».

При катаральном ларингите на фоне ОРВИ пить больше обычного не рекомендуется.

Польза обильного питья сомнительна, а повышенная во время болезни секреция антидиуретического гормона, напротив, задерживает жидкость.

4.2 Жаропонижающие и противокашлевые

Взрослым и детям с фебрильной лихорадкой назначают противовоспалительные и жаропонижающие препараты.

Детям с температурой выше 39–39,5 °C, кроме лекарств, применяют физическое охлаждение: ребёнка раскрывают и обтирают водой температуры 25–30 °C.

Препарат	Доза
Парацетамол	До 60 мг/кг в сутки. Детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не больше 60 мг/кг в сутки.
Ибупрофен	До 30 мг/кг в сутки. Детям — 7,5 мг/кг каждые 6–8 часов, не больше 30 мг/кг в сутки.

Детям с острым ларингитом и ларинготрахеитом противокашлевые и отхаркивающие препараты рутинно не назначают; исключение — мучительный кашель.

Прежде чем подавлять кашель, убеждаются, что нет состояний, при которых это опасно и которые требуют своего лечения, например бронхиальной обструкции, а у детей — ещё и острого обструктивного ларингита (крупа).

4.3 Местное лечение

Чтобы уменьшить воспаление слизистой гортани, назначают местную противовоспалительную терапию — вливания лекарств в гортань и ингаляции.

Для вливаний в гортань чаще всего используют антисептики из групп производных хинолина и четвертичных аммониевых соединений. Раствор подогревают до температуры тела и вливают по каплям, до 2 мл. Детям вливания в гортань не делают из-за угрозы ларингоспазма.

Применяют ингаляции через небулайзер аэрозолями средней и низкой дисперсности.

Ингаляция обычно длится 10 минут, между ингаляциями разных препаратов делают перерыв около 30 минут. Если в гортани есть корки, начинают с муколитика.

Препарат	Доза
Ацетилцистеин (раствор для инъекций и ингаляций)	Ингаляционно по 1 ампуле (3 мл) 1–2 раза в день, 5–7 дней.
#Будесонид	Ингаляционно 1000 мкг 1–2 раза в день, курс 5–8 процедур.

Можно использовать готовые аптечные смеси на основе растительных препаратов, с учётом противопоказаний и возраста — масло листьев эвкалипта прутовидного, а также 5–10% отвары цветков ромашки, листьев шалфея, травы тимьяна ползучего (чабреца), цветков календулы, листьев подорожника. Такие ингаляции бывают тёплыми и холодными; первая длится 1–2 минуты, следующие — 5–10 минут.

4.4 Антибиотики

При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции, если симптомы держатся меньше 10 дней, антибиотики не назначают.

Системные антибиотики назначают, если при неосложнённом течении симптомы сохраняются 10 дней, и при осложнённом течении.

Взрослым антибиотик целесообразен при затяжном ларингите — 10 дней и дольше, а также при выраженной инфильтрации голосовых складок и экссудации.
Взрослым антибиотик подбирают эмпирически и дают в таблетках: амоксициллин 500–1000 мг 3 раза в сутки 5–10 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой 875/125 мг 2 раза в сутки 5–10 дней; цефиксим 400 мг 1 раз в сутки 5–10 дней; цефдиторен 400 мг 1 раз в сутки 10 дней; кларитромицин 250–500 мг 2 раза в сутки 6 дней; джозамицин 1000 мг 2 раза в сутки 5–10 дней.

4.5 Антибиотики у взрослых

Препарат	Когда	Доза внутрь
Амоксициллин	Препарат выбора	500 мг 3 раза в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 1000 мг 3 раза в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернатива; при факторах риска бета-лактамаз	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	Альтернатива	400 мг 1 раз в сутки.
Цефдиторен	Альтернатива	400 мг; кратность в таблице зачёркнута, в тексте — 1 раз в сутки.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	250–500 мг 2 раза в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	1000 мг 2 раза в сутки.

Факторы риска устойчивости пневмококка к бета-лактамам — антибиотики в предшествующие 3 месяца, дети дошкольного возраста в семье, посещающие детские учреждения, проживание в «закрытых» учреждениях. Амоксициллин с клавулановой кислотой выбирают при риске возбудителя, продуцирующего бета-лактамазы (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis): при бронхиальной астме, сахарном диабете, хроническом бронхите, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет и при неудаче предшествующего лечения амоксициллином.

> В тексте КР цефдиторен назначают 400 мг 1 раз в сутки 10 дней, а в таблице 1 кратность у него зачёркнута целиком («2 раза в сутки 1 раз в сутки»). У джозамицина в тексте стоит код АТХ J01FA09 — тот же, что у кларитромицина, — а в таблице J01FA07.

4.6 Антибиотики у детей

В тексте КР детям предлагают амоксициллин 40–60 или 80–90 мг/кг в сутки 5–7 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой до 3 месяцев — 30 мг/кг в сутки в 2 приёма, с 3 месяцев — 25 мг/кг в сутки в 2 приёма или 20 мг/кг в сутки в 3 приёма, 5–10 дней; цефиксим в суспензии 8 мг/кг в сутки в 1–2 приёма 5–10 дней; цефтриаксон с 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, а при массе больше 50 кг — взрослые дозы; кларитромицин 7,5–15 мг/кг в сутки в 2 приёма не больше 14 дней; джозамицин 50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма 5–10 дней; тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат внутримышечно 10 дней.

Препарат	Когда	Доза
Амоксициллин	Препарат выбора	Внутрь 40–60 мг/кг в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернатива	Внутрь, суспензия 4:1 (125 мг + 31,25 мг в 5 мл или 250 мг + 62 мг в 5 мл) в 3 приёма каждые 8 часов; доза «45–60 мг/кг/сутки в 2–3 приёма» в таблице зачёркнута.
Цефиксим	Альтернатива	8 мг/кг в сутки 1 раз в сутки.
Цефтриаксон	Альтернатива	С 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; при массе больше 50 кг — дозы для взрослых.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	Внутрь 7,5 мг/кг в сутки в 2 приёма, не больше 1000 мг в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	Если нельзя ни бета-лактамы, ни макролиды	До 2 лет — по 125 мг 2 раза в сутки; 3–6 лет — по 250 мг 2 раза в сутки; 7–12 лет — по 250 мг 3 раза в сутки; взрослым — по 500 мг 2–3 раза в сутки; 10 дней.

> Детские дозы в тексте и в таблице 2 не совпадают. Кларитромицин в тексте — «для детей старше 12 лет разовая доза» 7,5–15 мг/кг/сут, в таблице — 7,5 мг/кг/сут в 2 приёма. Амоксициллин с клавулановой кислотой в тексте — 20–30 мг/кг/сут, в таблице доза 45–60 мг/кг/сут зачёркнута и указана только суспензия в 3 приёма. Цефиксим в тексте — в 1–2 приёма, в таблице — 1 раз в сутки. Для тиамфеникола возрастные группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет» оставляют без дозы детей от 2 до 3 лет.

4.7 Лечение в стационаре

В стационаре антибиотики взрослым и детям назначают эмпирически с учётом региональной резистентности основных возбудителей. Когда состояние улучшится, можно перейти на приём антибиотика внутрь (ступенчатая терапия).

Препарат	Детям	Взрослым (осложнённый флегмонозный ларингит)
Амоксициллин + клавулановая кислота	С 3 месяцев внутривенно 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов, 5–10 дней	Внутривенно 1,2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 150 мг/кг в сутки в 4 введения	Внутривенно 2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефтриаксон	С 15 дней до 12 лет внутримышечно или внутривенно 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, 5–10 дней	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки, 7–10 дней
Цефепим	При тяжёлом флегмонозном ларингите и осложнениях в отделении реанимации: больше 40 кг — 2 г каждые 12 часов, до 40 кг — 50 мг/кг каждые 12 часов, 7–10 дней	—
Меропенем	Там же: от 3 месяцев до 12 лет — 10–20 мг/кг 3 раза в сутки, больше 50 кг — доза для взрослых, 5–10 дней	—
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	До 2 лет — 125 мг 2 раза в сутки, 3–6 лет — 250 мг 2 раза, 7–12 лет — 250 мг 3 раза в сутки	500 мг 2–3 раза в сутки, 10 дней

При абсцедирующем и флегмонозном ларингите всем пациентам промывают полость абсцесса антисептиками — 0,01% раствором бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорида моногидрата или гидроксиметилхиноксалиндиоксидом.

Всем пациентам с дисфагией при тяжёлых формах ларингита проводят дезинтоксикационную терапию, корректируют гиповолемию, назначают глюкокортикостероиды и парентеральное питание.

Чтобы предупредить стеноз гортани, проводят консервативную противовоспалительную терапию; для дестенозирующей терапии вводят глюкокортикоиды парентерально.

> В комментарии о дестенозирующей терапии фраза оборвана: указана доза «60–120 мг», но не названо, какого именно глюкокортикоида, и не сказано, для взрослых она или для детей.

4.8 Другие лекарства

Противогрибковые препараты эмпирически не назначают. Только после подтверждения кандидоза взрослым назначают флуконазол 100 мг в сутки или итраконазол 100 мг 1 раз в сутки на 15 дней.

Пациентам с аллергией — аллергическим ринитом, крапивницей, поллинозом, аллергическим конъюнктивитом — назначают системные антигистаминные препараты.

Препарат	Доза
Лоратадин, цетиризин	Детям 3–12 лет с массой больше 30 кг — 10 мг 1 раз в день, меньше 30 кг — 5 мг 1 раз в день; взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в день.
Левоцетиризин	Детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки; старше 6 лет и взрослым — 5 мг 1 раз в сутки.
Дезлоратадин	От 6 до 12 месяцев — 1 мг, с 1 года до 5 лет — 1,25 мг, 6–11 лет — 2,5 мг, взрослым и детям старше 12 лет — 5 мг; всё 1 раз в день.

> Левоцетиризину и лоратадину в КР приписан один и тот же код АТХ — R06AX13.

4.9 Хирургическое лечение

При неосложнённом остром ларингите операция не нужна.

Детям с декомпенсированным стенозом гортани для обеспечения дыхания проводят неотложную интубацию.

Если интубировать трахею невозможно, делают трахеостомию или коникотомию.

Осложнённые формы острого ларингита лечат хирургически.

4.10 Иное лечение

Пациента с острым ларингитом консультирует физиотерапевт.

При дисфонии на фоне острого ларингита КР рекомендует добавлять комплексные гомеопатические препараты, чтобы уменьшить расстройства голоса. Приведённый в КР препарат зарегистрирован по показанию «ларингиты различной этиологии» и назначается взрослым и детям старше 6 лет с первых дней болезни на 6 дней.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациентов голосоречевых профессий после острого ларингита наблюдает оториноларинголог до полного восстановления голоса.

Нетрудоспособность у них продлевают до полного восстановления голоса. Неосложнённый ларингит проходит за 7–14 дней, инфильтративные формы — дольше 14 дней.

Чтобы ларингит не стал хроническим, его вовремя лечат, повышают сопротивляемость организма, лечат гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и инфекции верхних и нижних дыхательных путей, отказываются от курения и соблюдают голосовой режим.

Пациенту советуют ограничить голосовую нагрузку, отказаться от горячей, холодной и острой пищи, спиртного, курения и паровых ингаляций, постоянно увлажнять воздух в помещении увлажнителем; в составе комплексного лечения КР упоминает противовирусные препараты.

> В разделе 7 и в памятке для пациента паровые ингаляции запрещены, хотя в разделе 3.1 ингаляции отваров трав допускаются «тёплыми». Там же советуют противовирусные препараты, но в разделе о лечении такой рекомендации нет.

5.1 Госпитализация

Пациенты с острым ларингитом без стеноза гортани на фоне ОРВИ в госпитализации не нуждаются. Госпитализируют всех пациентов с осложнённым течением.

Пациентов с осложнёнными и тяжёлыми формами — флегмонозным, абсцедирующим, инфильтративным ларингитом и хондроперихондритом гортани — обязательно и срочно госпитализируют в учреждение, где есть отделение интенсивной терапии и возможность интубации трахеи.

Экстренно госпитализируют при острой дыхательной недостаточности выше I степени.

Выписывают, когда воспаление идёт на убыль, дыхательной недостаточности и осложнений нет.

При неосложнённом ларингите прогноз благоприятный. При осложнённых формах со стенозом гортани жизнь пациента спасают своевременная специализированная помощь и операция.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый ларингит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 01.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	309_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Союз педиатров России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Сроки голосового покоя расходятся: в рекомендации — «не менее 2-х дней», в комментарии — «1–2 суток».
- Цефдиторен: в тексте — 400 мг 1 раз в сутки, в таблице 1 кратность зачёркнута целиком.
- Джозамицину в тексте приписан код АТХ J01FA09 (код кларитромицина), в таблице — J01FA07.
- Детские дозы кларитромицина, амоксициллина с клавулановой кислотой и цефиксима в тексте и в таблице 2 различаются; у кларитромицина «разовая доза» дана в мг/кг/сут и «для детей старше 12 лет».
- Для тиамфеникола глицината ацетилцистеината нет дозы для детей от 2 до 3 лет: группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет».
- В комментарии о дестенозирующей терапии не назван глюкокортикоид, к которому относится доза «60–120 мг».
- Левоцетиризину и лоратадину приписан один код АТХ R06AX13.
- Раздел 7 запрещает паровые ингаляции и советует противовирусные препараты, а раздел 3.1 допускает тёплые ингаляции и не содержит рекомендации о противовирусных.
- В комментарии о меропенеме для детей авторы ссылаются на справочник Vidal.

Клинические рекомендации

Острый синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J01** — Острый синусит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/313_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Острый синусит — острое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, которое длится меньше 12 недель. Должны быть хотя бы два симптома: заложенность носа, выделения из носа или носоглотки, давление или боль в области лица, снижение или потеря обоняния.
- В 90–98% случаев синусит вызывают вирусы, бактерии — лишь в 2–10%.
- Системные антибиотики назначают при среднетяжёлом и тяжёлом синусите. При лёгком — только если синусит рецидивирующий и симптомы держатся 5–7 дней и дольше, при тяжёлой сопутствующей патологии или иммунодефиците.
- При впервые возникшем синусите начинают с незащищённого аминопенициллина — амоксициллина. Если за 3 дня заметного эффекта нет, препарат меняют.
- Сосудосуживающие капли назначают не дольше 5–7 дней, нос промывают солевыми растворами, пациентам старше 12 лет можно интраназальные глюкокортикостероиды.
- Госпитализируют при тяжёлом течении, орбитальных или внутричерепных осложнениях, если за 3–5 дней приёма системных антибиотиков нет улучшения и при ухудшении в любой момент.

2. Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый синусит — острое воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, которое длится меньше 12 недель. Должны быть хотя бы два симптома: затруднённое носовое дыхание, выделения из носа или носоглотки, давление или боль в области лица, снижение или потеря обоняния. Часть симптомов может заменить находка при риноскопии, эндоскопии или на КТ.

У детей внезапно появляются хотя бы два симптома: заложенность носа, бесцветные или светлые выделения, кашель днём или ночью. Симптомы должны полностью пройти за 12 недель.

Рецидивирующим синусит называют, если за последний год было 4 эпизода и больше, а между ними — не меньше 8 недель без симптомов и без лечения.

Об остром поствирусном синусите говорят, если симптомы держатся дольше 10 дней после ОРВИ, а признаков бактериального синусита нет. Обычно он протекает легче и проходит без антибиотиков.

2.2 Критерии диагноза

У взрослых синусит начинается остро, симптомов два или больше, и один из них — заложенность носа или выделения, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки. Могут быть боль или давление в проекции пазух, снижение или потеря обоняния. Длится не дольше 12 недель.

У детей синусит начинается остро, есть хотя бы два симптома: заложенность носа, выделения из носа, в том числе по задней стенке глотки, или кашель. Длится не дольше 12 недель.

Предварительный диагноз оториноларинголог подтверждает риноскопией или эндоскопией (гнойное отделяемое или отёк в области остиомеатального комплекса) либо КТ.

Боли может и не быть. При верхнечелюстном синусите она ощущается в проекции пазухи, реже в области переносицы и надбровья и может отдавать в верхние зубы. При сфеноидите болит в центре головы и в затылке, как будто надета каска.

У детей синусит часто сочетается с гипертрофией и хроническим воспалением глоточной миндалины и может проявляться упорным кашлем или сильно затруднённым носовым дыханием.

2.3 Тяжесть

Форма	Признаки
Лёгкая	Нет лихорадки. Умеренные симптомы, не влияющие или незначительно влияющие на качество жизни. Нет головной боли в проекции ОНП. Нет осложнений
Среднетяжёлая	Выраженные симптомы, умеренно или значительно влияющие на качество жизни. Тяжесть в проекции ОНП при движении или наклоне головы. Осложнение со стороны среднего уха (острый средний отит). Нет внутричерепных и орбитальных осложнений
Тяжёлая	Выраженные или мучительные симптомы. Болезненность в проекции ОНП, усиливающаяся при движении, наклоне головы, перкуссии. Внутричерепные или орбитальные осложнения

2.4 Классификация

По причине синусит бывает вирусным, бактериальным, травматическим, грибковым (как острый процесс — очень редко) и смешанным. Чисто бактериальный синусит встречается редко; обычно это сочетание вирусов или вирусов с бактериями.

По локализации различают гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит. Если поражены все пазухи одной половины носа, это гемисинусит, если обеих — пансинусит.

2.5 Дифференциальная диагностика

У взрослых синусит отличают от обострения хронического риносинусита, аллергического и хронических ринитов, у детей — ещё от аденоидита и инородного тела в носу.

Дошкольникам без осложнений и без признаков бактериального синусита основным диагнозом лучше ставить аденоидит или острый назофарингит.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Всем пациентам проводят общий осмотр и стандартный ЛОР-осмотр.

Эндоскопию полости носа и носоглотки проводят, чтобы оценить их состояние и провести дифференциальную диагностику.

Чаще всего она не даёт больше, чем передняя и средняя риноскопия, но помогает, например, отличить сфеноидит от аденоидита.

Спиральную КТ околоносовых пазух делают при подозрении на внутричерепные или орбитальные осложнения, при затяжном тяжёлом течении и в сложных диагностических случаях.

Рентгенографию пазух делают при среднетяжёлом и тяжёлом течении, а также в сложных случаях, если КТ сделать нельзя.

Рентгенография и КТ пазух совпадают только в 34% случаев, для верхнечелюстной пазухи — в 77%.

УЗИ пазух делают при подозрении на верхнечелюстной или лобный синусит, если рентгенография и КТ невозможны.

Развёрнутый общий анализ крови назначают при среднетяжёлом и тяжёлом течении.

Лейкоцитоз с нейтрофилёзом не доказывает бактериальный синусит, но если при повторном анализе он нарастает, это помогает решить вопрос об антибиотиках.

Гнойное отделяемое отправляют на посев с определением чувствительности в стационаре при среднетяжёлом и тяжёлом течении, при затяжном течении и если эмпирическая антибиотикотерапия не помогла.

Материал берут при пункции пазухи иглой Куликовского. Посев из носового хода делать бессмысленно: в него попадает посторонняя флора.

Другие исследования не нужны.

---

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Когда нужен антибиотик

Взрослым антибиотики назначают при среднетяжёлом и тяжёлом синусите. При лёгком — только если синусит рецидивирующий и симптомы держатся 5–7 дней и дольше, а также при тяжёлой сопутствующей патологии (например, сахарном диабете) и иммунодефиците.

О бактериальном синусите говорят три признака и больше: гнойные выделения или выделения только из одной половины носа 3 дня и дольше; головная боль или давление в проекции верхнечелюстных или лобных пазух; температура 38,0 °C и выше; «вторая волна» болезни; лейкоцитоз выше 15×10^9/л. О нём же говорят выраженные с самого начала симптомы, которые держатся 3–4 дня и угрожают орбитальными или внутричерепными осложнениями.

Детям антибиотики назначают при признаках бактериального синусита, среднетяжёлом и тяжёлом течении. При лёгком — если есть хотя бы одно из условий: орбитальные или внутричерепные осложнения; три и больше признака бактериального синусита; иммунодефицит, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, некомпенсированный сахарный диабет I типа; 4 эпизода синусита и больше за последний год.

Взрослым при наличии показаний назначают системные антибиотики.

Детям при наличии показаний назначают системные антибиотики.

При впервые возникшем синусите начинают с незащищённых аминопенициллинов.

Если высок риск устойчивого пневмококка, дозу амоксициллина повышают. При сопутствующих болезнях, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет и если амоксициллин уже не помог, начинают с защищённых аминопенициллинов.

Если за 3 дня заметного эффекта нет, препарат меняют, не дожидаясь конца курса. У детей эффект оценивают через 48–72 часа.

4.2 Дозы стартовой терапии

Взрослые

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	500 мг × 3 р/сут — без факторов риска[1] 1000 мг × 3 р/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[2]	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут
Цефуроксим	250–500 мг × 2 р/сут
Цефиксим	400 мг × 1 р/сут
Цефдиторен внутрь	200 мг × 2 р/сут

Препарат	Доза
Цефподоксим внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	250–500 мг × 2 р/сут
Левофлоксацин внутрь	500 мг × 1 р/сут
Моксифлоксацин внутрь	400 мг × 1 р/сут
Клиндамицин в/м (в КР — со знаком #)	400–900 мг × 3 р/сут, 7–10 дней

[1] Риск устойчивости пневмококка повышают антибиотики в предыдущие 3 месяца, дети-дошкольники в семье, которые ходят в детский сад, и проживание в закрытых учреждениях.

[2] Риск бета-лактамаз (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis) повышают бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит, иммуносупрессия, возраст старше 65 лет и неудачное лечение амоксициллином.

Неосложнённый синусит лечат 7 дней, осложнённый — 10–14 дней.

Макролиды — только запасной вариант при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов. Фторхинолоны можно только взрослым и только если других вариантов нет; детям и подросткам они противопоказаны.

Дети

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	40–60 мг/кг/сут — без факторов риска[1] 80–90 мг/кг/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь	45–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Цефуроксим	30 мг/кг/сут в 2 приёма, не более 500 мг в сутки
Цефиксим	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен, цефподоксим (старше 12 лет) внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	15 мг/кг/сут в 2 приёма, макс. 1000 мг/сут
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат в/м (стационар, если β-лактамы невозможны)	125–250 мг 2–3 р/сут в зависимости от возраста

Амоксициллин с клавулановой кислотой назначают, если за последние 3 месяца ребёнок получал антибиотики или ходит в детский коллектив, а также если амоксициллин не помог за 48–72 часа. При лёгкой аллергии на пенициллины назначают цефалоспорины III поколения внутрь.

Дозы на килограмм рассчитаны на детей с массой меньше 40 кг; при массе 40 кг и больше назначают взрослые дозы.

Неосложнённый синусит лечат 7–10 дней, при орбитальных и внутричерепных осложнениях или рецидивирующем течении — 10–14 дней.

> Внутри КР есть расхождение: в тексте раздела 3.1 стартовая доза амоксициллина для детей — 50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма, а в таблице 5 — 40–60 мг/кг в сутки (80–90 мг/кг при факторах риска). На сайте приведены данные таблицы.

4.3 Тяжёлое течение, парентерально

Взрослым при тяжёлом синусите вводят цефотаксим или цефтриаксон, внутривенно можно также амоксициллин с клавулановой кислотой. При риске анаэробов назначают клиндамицин вместе с цефалоспорином III поколения. Если стартовая парентеральная терапия не помогла, рассматривают цефоперазон с сульбактамом 2–4 г в сутки внутривенно в 2 введения, а при резистентных штаммах — препараты резерва по чувствительности.

Детям вводят ампициллин с сульбактамом 300 мг/кг в сутки в 3–4 введения, цефтриаксон 75 мг/кг в сутки в 2 введения или цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 4 введения. Если это не помогло, назначают цефоперазон с сульбактамом 75–160 мг/кг в сутки в 2–4 введения (в КР — со знаком #, то есть вне инструкции).

4.4 Местная и симптоматическая терапия

Нос промывают изотонической стерильной морской водой или солевыми растворами. Слабые гипертонические растворы используют только в остром периоде и не дольше 5–7 дней.

Сосудосуживающие капли КР называет абсолютно необходимыми, но ограничивает их 5–7 днями из-за риска медикаментозного ринита. Нафазолин не применяют.

Детям до 6 лет подходят фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет).

Интраназальные глюкокортикостероиды пациентам старше 12 лет назначают одни при затяжном поствирусном синусите или вместе с системными антибиотиками. Детям до 12 лет одни глюкокортикостероиды назначают только при сопутствующем аллергическом рините.

Для лечения синусита без признаков бактериальной инфекции одним препаратом в России зарегистрирован только спрей мометазона.

Местные антибактериальные препараты назначают вместе с системными или одни при лёгком синусите с признаками бактериального воспаления (гнойными выделениями). Эффект оценивают через 3–4 дня.

При синусите зарегистрированы фрамицетин (детям с первых лет жизни) и комбинация дексаметазона, неомицина, полимиксина B и фенилэфрина (с 2,5 лет). Растворы антибиотиков для инъекций вводить в нос и пазухи нельзя.

При температуре, головной и лицевой боли назначают НПВП. Детям до 6 лет — только парацетамол (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофен (до 30 мг/кг в сутки), взрослым можно кетопрофен.

Можно назначить мукоактивные препараты, например ацетилцистеин или карбоцистеин. Перед назначением проверьте инструкцию: не все они разрешены при ЛОР-болезнях и вместе с антибиотиками.

Применяют растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием: комбинации корня горечавки, цветков первоцвета, шалфея, цветков бузины и вербены, миртол, экстракт пеларгонии сидовидной.

Комбинированные препараты с парацетамолом без психотропных компонентов можно давать для облегчения симптомов с 12 лет.

Системные антигистаминные препараты назначают при сопутствующем аллергическом рините и в начале вирусной инфекции.

При вирусном синусите в комплексное лечение можно включить противовирусные препараты, в том числе растительного происхождения.

При лёгком синусите амбулаторно можно рассмотреть комплексные гомеопатические препараты по зарегистрированным показаниям.

Бактериофаги назначают взрослым с острым бактериальным синуситом; местно они оправданы при устойчивости к антибиотикам или их непереносимости.

4.5 Хирургия

Пункцию верхнечелюстной пазухи делают, если содержимое в пазухе подтверждено рентгенологически и течение тяжёлое или среднетяжёлое без эффекта от лечения с системными антибиотиками за 5–7 дней.

Детям пункцию и трепанопункцию делают только в стационаре; часто вместо них можно использовать синус-катетер.

Дренирование пазух, в том числе синус-катетером, проводят при затяжном экссудативном синусите без обструкции соустий. При впервые возникшем неосложнённом синусите оно не нужно.

При орбитальных или внутричерепных осложнениях оперируют в стационаре: вскрывают пазуху и дренируют абсцесс.

Другое лечение (раздел 3.3) и медицинская реабилитация (раздел 4) не нужны.

4.6 Профилактика

Детям из групп риска по респираторным болезням назначают местные и системные лизаты бактерий.

При рецидивирующем синусите и изменениях перегородки или латеральной стенки носа, которые к нему предрасполагают, проводят плановую операцию.

4.7 Особые случаи

Сопутствующий аллергический ринит затягивает синусит: нужны системные антигистаминные препараты и более высокая доза глюкокортикостероидов.

Одонтогенный синусит лечат хирургически, удаляя пломбировочный материал и секвестры. Из антибиотиков предпочтительны респираторные фторхинолоны, потому что преобладает анаэробная флора.

5. Госпитализация и осложнения

разделы 1.5, 3 и 6 текста КР
Экстренно в ЛОР-отделение госпитализируют при тяжёлом течении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями, если за 3–5 дней системных антибиотиков нет улучшения и при прогрессирующем ухудшении в любой момент.

Орбитальные и внутричерепные осложнения говорят о тяжёлом течении, острый средний отит — о среднетяжёлом.

Выписывают, когда состояние стабильно удовлетворительное не меньше 3 дней.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый синусит»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024

Статус	**Применяется** (карточка рубрикатора на 22.10.2026); год окончания действия не указан
Актуализация	По правилу из самой КР — «не реже чем один раз в три года» (прил. А2): следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	313_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети
Целевая аудитория	Оториноларингологи, терапевты, педиатры

6.1 Что исправлено после сверки с PDF

- Убрано предупреждение «пересмотр не позднее 2026»: в PDF и в карточке рубрикатора этой даты нет, она пришла из пересказа MedElement.
- Амоксициллин у взрослых: «500–1000 мг» заменено на две дозы с условием — 500 мг без факторов риска устойчивости пневмококка, 1000 мг при их наличии.
- Добавлены условия для амоксициллина/клавуланата и цефоперазона/сульбактама, тиамфеникол для детей в стационаре, предел цефуроксима «500 мг в сутки».
- Уточнены показания к пункции, ограничение ИГКС до 12 лет (только монотерапия), признаки степеней тяжести, критерии у детей («бесцветные или светлые выделения»).
- Убрана фраза «КТ рутинно не нужна»: в КР её нет.
- Добавлены разделы 5 «Профилактика» и 7 «Дополнительная информация».

6.2 Неточности в самом тексте КР

- Детская доза амоксициллина: текст раздела 3.1 — 50–60 мг/кг/сут, таблица 5 — 40–60 (80–90) мг/кг/сут.
- В таблице 5 у цефтриаксона указан код АТХ J01FA09 — это код кларитромицина; в тексте у цефтриаксона верный код J01DD04.
- Знак # у ряда препаратов в этой КР не расшифрован. ⚠ В российских КР им обычно отмечают применение вне инструкции — проверьте по инструкции препарата.

6.3 Шкалы доказательности

Шкала	Что означает
УУР А	Сильная рекомендация: все критерии эффективности важны, исследования высокого или удовлетворительного качества, выводы согласованы
УУР В	Условная рекомендация: не все критерии важны, не все исследования высокого качества и/или выводы не согласованы
УУР С	Слабая рекомендация: доказательств надлежащего качества нет
УДД 1–5	Для лечения: 1 — систематический обзор РКИ с метаанализом … 5 — только обоснование механизма действия или мнение экспертов. Для диагностики — отдельная шкала (табл. П1); точная расшифровка — по нажатию на бейдж

Клинические рекомендации

Острый тонзиллит и фарингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J02** — Острый фарингит **J02.0** — Стрептококковый фарингит **J02.8** — Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями **J02.9** — Острый фарингит неуточненный **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J03.0** — Стрептококковый тонзиллит **J03.8** — Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями **J03.9** — Острый тонзиллит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 31.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/306_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Чаще всего тонзиллофарингит вызывают вирусы, и антибиотик при нём не нужен. Из бактерий лечения требует только БГСА — бета-гемолитический стрептококк группы А; стафилококк, пневмококк и другие микробы в мазке из зева означают колонизацию.
- По клинике вирусный тонзиллофарингит от бактериального не отличить. Пациентам старше 3 лет делают экспресс-тест на БГСА; если у ребёнка он отрицательный, результат подтверждают посевом.
- Антибиотик назначают только при доказанной или очень вероятной стрептококковой природе. При вирусной инфекции он не помогает и не предотвращает присоединение бактерий.
- Препарат выбора — амоксициллин, курс 10 дней.
- Если через 48–72 часа приёма антибиотика улучшения нет, пересматривают диагноз: это может быть ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.
- Рутинно не нужны СРБ, прокальцитонин, общий анализ крови в поликлинике, АСЛ-О и контрольный мазок после лечения.

2. Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый тонзиллофарингит — острое инфекционное воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани ротоглотки: нёбных миндалин и фолликулов задней стенки глотки. Термин объединяет острый тонзиллит и острый фарингит, потому что чаще воспалены оба отдела.

По локализации различают тонзиллит, фарингит и тонзиллофарингит — по тому, какой отдел ротоглотки воспалён больше. По причине — стрептококковый и нестрептококковый (вирусный). Тактику определяет именно причина.

2.2 Клиническая картина

Болезнь начинается остро, обычно с температурой выше 38 °C (реже она нормальная или субфебрильная) и боли в горле, которая усиливается при глотании и может отдавать в ухо. Регионарные лимфоузлы бывают увеличены и болезненны, маленькие дети отказываются от еды. Состояние удовлетворительное или средней тяжести.

На стрептококк указывают увеличенные подчелюстные или переднешейные лимфоузлы, высокая температура, сильная боль в горле, «пылающий зев», налёт на миндалинах и отсутствие насморка, кашля и конъюнктивита.

На вирусную природу указывают насморк, конъюнктивит и кашель. При инфекции вирусом Эпштейна — Барр бывают генерализованное увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки. Петехии на мягком нёбе встречаются и при стрептококке, и при вирусе Эпштейна — Барр.

При тонзиллофарингите миндалины увеличены симметрично, и этим он отличается от паратонзиллярного абсцесса.

2.3 Что важно для выбора тактики

Все штаммы БГСА чувствительны к пенициллину и всем бета-лактамам. К макролидам устойчив примерно каждый пятый штамм, к клиндамицину — 3–4%.

Если при клинике тонзиллофарингита из зева высевают *S. aureus*, *S. pneumoniae* или другие бактерии, это колонизация, и антибиотики не нужны.

2.4 Дифференциальная диагностика

Инфекционным мононуклеозом чаще болеют подростки и молодые взрослые до 30 лет. Характерны слабость, увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки, атипичные мононуклеары в крови. Диагноз подтверждают ПЦР на ДНК вируса Эпштейна — Барр и IgM к капсидному антигену.

Синдромом «рука — нога — рот» болеют дети до 5 лет, обычно летом: во рту появляются пузырьки без налётов на миндалинах, а на кистях и стопах — сыпь.

При ангине Симановского — Плаута — Венсана на одной миндалине образуется некротическая язва с гнилостным запахом.

При дифтерии зева налёт плотный, снимается с трудом и оставляет кровоточащую поверхность.

Синдром Маршалла (PFAPA) — периодическая лихорадка до 39–40 °C с тонзиллитом или фарингитом, афтозным стоматитом и шейным лимфаденитом. Приступы повторяются каждые 1–2 месяца, средний возраст детей — 5 лет, приступ быстро снимают системные кортикостероиды.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Диагноз ставят по жалобам на сильную боль в горле при глотании, по осмотру (гиперемия, инфильтрация и отёк миндалин, увеличенные регионарные лимфоузлы) и по результату экспресс-теста на БГСА или посева.

Каждого пациента должен осмотреть оториноларинголог, педиатр, врач общей практики или терапевт.

У каждого пациента нужно отличить стрептококковый тонзиллофарингит от вирусного.

Экспресс-тест на БГСА делают пациентам старше 3 лет. Если он положительный, посев не нужен. Если отрицательный, взрослому посев тоже не нужен, а у ребёнка и подростка результат подтверждают посевом.

Детям до 3 лет тест обычно не делают; исключение — когда стрептококковый тонзиллит есть у кого-то рядом, например у старшего брата или сестры.

Мазок из зева на стрептококк группы А сеют пациентам старше 3 лет, если экспресс-тест не делали или он отрицательный. Результат готов в течение 72 часов.

Мазок берут до начала антибиотиков, до утренней гигиены рта, натощак или через 2 часа после еды, под контролем орофарингоскопии, не касаясь зубов и языка, из устьев крипт миндалин и с задней стенки глотки.

3.1 Что не нужно рутинно

В поликлинике СРБ и прокальцитонин не помогают отличить вирусное воспаление от бактериального. СРБ определяют при госпитализации, прокальцитонин — у тяжёлых пациентов в стационаре.

Общий анализ крови в поликлинике делают только при необходимости, например чтобы исключить мононуклеоз.

АСЛ-О годится только для ретроспективной диагностики, потому что повышается лишь на 7–9-й день. Его определяют при подозрении на ревматическую лихорадку, гломерулонефрит или PANDAS.

Контрольный мазок на БГСА после лечения не нужен, если пациент не относится к группе высокого риска ревматической лихорадки и симптомы не повторяются.

У детей старше 3 лет обращают внимание на насморк, кашель, охриплость и конъюнктивит: при стрептококковой инфекции они бывают не больше чем у 10% и только при сопутствующей вирусной инфекции.

3.2 Шкала Центора — МакАйзека

Признак	Баллы
Температура тела выше 38 °C	1
Отёчность и гиперемия миндалин, налёты на задней стенке глотки и миндалинах	1
Нет катаральных явлений и кашля	1
Переднешейный и/или подчелюстной лимфаденит	1
Возраст 5–14 лет / 15–44 года / 45 лет и старше	1 / 0 / −1

Баллы	Вероятность БГСА: ≥15 лет / 3–14 лет	Тактика
0–1	7–12% / 8–14%	Нет показаний к посеву и/или антибиотикам
2–3	21–38% / 23–37%	Антибиотик — по экспресс-тесту и/или посеву
4 и более	57% / 55%	Антибиотик по клинической картине

3.3 Шкала FeverPAIN

Один балл дают за каждый признак: температура за последние сутки, налёт на миндалинах, обращение в первые 3 дня из-за сильных симптомов, выраженные гиперемия и отёк миндалин, отсутствие кашля и насморка.

При 0–2 баллах вероятность стрептококка групп A, C или G — 16%, при 3 баллах — 43%, при 4–5 баллах — 63%.

Шкалы помогают найти пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции, но диагноз с абсолютной точностью не ставят.

---

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Антибиотики

При вирусной инфекции системные антибиотики не назначают: они не действуют и не предотвращают присоединение бактерий.

Назначать антибиотики при вирусном тонзиллофарингите «для профилактики» не рекомендуется.

Антибиотики назначают только при доказанной или очень вероятной стрептококковой природе.

При стрептококковом тонзиллите препарат выбора — амоксициллин.

При мононуклеозе может появиться сыпь на амоксициллин, но она бывает и от других антибиотиков, и без них, поэтому при мононуклеозе любых системных антибиотиков лучше избегать.

Пенициллины, цефалоспорины, линкозамиды и макролиды, кроме азитромицина, назначают на 10 дней.

При рецидивирующем стрептококковом тонзиллофарингите назначают амоксициллин с клавулановой кислотой или клиндамицин (детям старше 3 лет) на 10 дней. Пациента консультирует оториноларинголог, чтобы исключить хронический тонзиллит, а у детей — синдром PFAPA.

Если через 48–72 часа приёма антибиотика температура и боль не уменьшились, пересматривают диагноз: вероятнее всего, это ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.

При нетяжёлой аллергии на пенициллины назначают цефалоспорины II–III поколения: цефуроксим, цефиксим, цефдиторен или цефподоксим. Перекрёстная аллергия с пенициллинами бывает меньше чем в 2% случаев для II поколения и меньше чем в 1% для III.

Уровни доказательности у этих препаратов в КР разные: у цефуроксима — УУР С, УДД 5; у цефиксима — С и 5 для детей, В и 1 для взрослых; у цефдиторена — С и 2; у цефподоксима — В и 2. Курс — 10 дней.

При аллергии на цефалоспорины или тяжёлой реакции на бета-лактамы (анафилактический шок, отёк гортани, тяжёлая крапивница) назначают макролиды или линкозамиды, помня об устойчивости стрептококка к макролидам.

Бензатина бензилпенициллин вводят однократно внутримышечно вместо курса таблеток, только если есть сомнения, что пациент будет их принимать. Детям с массой до 27 кг — 600 тысяч ЕД, больше 27 кг — 1,2 миллиона ЕД.

4.2 Дозы внутрь

Препарат	Взрослые	Дети
Стартовая терапия — 10 дней		
Амоксициллин[1]	1,5 г/сут в 3 приёма или 1,0 г/сут в 2 приёма	50 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Альтернатива		
Бензатина бензилпенициллин[2] **в/м, однократно**	2,4 млн ЕД	менее 27 кг — 600 тыс. ЕД; более 27 кг — 1,2 млн ЕД
Цефалексин	старше 10 лет: 500–1000 мг/сут в 2 приёма	3–10 лет, только таблетки: 25–50 мг/кг/сут в 4 приёма, не более 1000 мг/сут
Рецидив и/или неэффективность амоксициллина		
Амоксициллин + клавулановая кислота[1] [3] **(во время еды)**	1750 мг/сут по амоксициллину в 2 приёма	50 мг/кг/сут по амоксициллину в 2–3 приёма
Нетяжёлая аллергия на пенициллины		
Цефуроксим (сразу после еды)	1,0 г/сут в 2 приёма	20 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1–2 приёма	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен (после еды)	400 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 400 мг/сут в 2 приёма
Цефподоксим (во время еды)	200 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 200 мг/сут в 2 приёма
Аллергия на цефалоспорины и/или тяжёлая реакция на пенициллины		
Кларитромицин	500–1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма

Препарат	Взрослые	Дети
Джозамицин (между едой)	1,0 г/сут в 2 приёма	40–50 мг/кг/сут в 2 приёма
Азитромицин (за 1 час до еды)	500 мг/сут в 1 приём, **3 дня**	20 мг/кг/сут в 1 приём, 3 дня
Мидекамицин (за 1 час до еды)	1,2 г/сут в 3 приёма	старше 3 лет: 50 мг/кг/сут в 2 приёма
Спирамицин	6 млн МЕ/сут в 2 приёма	старше 6 лет, более 20 кг: 300 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приёма
Клиндамицин (запивать большим объёмом воды)	0,6 г/сут в 4 приёма	20 мг/кг/сут в 3 приёма

[1] С осторожностью при подозрении на инфекционный мононуклеоз. [2] Если пациент может не соблюдать назначения, при ревматической лихорадке у него или у родственников, при неблагоприятных бытовых условиях и вспышках в коллективе. [3] Клавулановой кислоты — не больше 10 мг/кг в сутки из-за риска диареи.

> Текст КР и таблица 1 расходятся. Цефуроксим взрослым: в тексте — 250 мг 2 раза в сутки, в таблице — 1,0 г в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте — 40 мг/кг в сутки, в таблице — 50 мг/кг. Амоксициллин детям: в тексте — 50 мг/кг в сутки в 2 приёма, не больше 1000 мг в сутки, в таблице — в 2–3 приёма без ограничения. Клиндамицин: в тексте взрослым 300 мг 2 раза в сутки, детям 3–12 лет 20–30 мг/кг в сутки, в таблице — 0,6 г в сутки в 4 приёма и 20 мг/кг. Выбор за врачом; проверьте дозы по инструкции в ГРЛС.

4.3 Парентерально

Если пациент не может или не хочет принимать препарат внутрь, его вводят парентерально до стабилизации, а затем переходят на приём внутрь.

Препарат	Дети	Взрослые
Ампициллин	до 1 года 100 мг/кг/сут; 1–4 года 100–150 мг/кг/сут; от 4 лет 1–2 г/сут; в 4 введения	и дети более 40 кг: 250–500 мг каждые 6 ч
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в	90 мг/кг/сут в 3 введения	и дети старше 12 лет: 1,2 г каждые 8 ч
Ампициллин + сульбактам	до 12 лет или менее 40 кг: 150 мг/кг/сут в 3–4 введения	1,5–3 г каждые 6–8 ч
Цефазолин	1 мес — 18 лет: 25–50 мг/кг/сут (тяжёлые — 100) в 3–4 введения	2,0 г каждые 8 ч
Цефтриаксон	до 12 лет: 20–80 мг/кг/сут 1 раз (более 50 кг — до 2 г/сут)	и дети старше 12 лет: 2 г 1 раз в сутки
Цефотаксим	до 12 лет: 100–150 мг/кг/сут в 2–4 введения	и дети старше 12 лет или более 50 кг: 1–2 г каждые 6–8 ч
Клиндамицин (непереносимость β-лактамов)	20–40 мг/кг/сут в 3–4 введения	0,4–0,6 г каждые 6–8 ч

4.4 Симптоматическое лечение

При температуре и боли назначают ибупрофен, парацетамол или, старше 15 лет, ацетилсалициловую кислоту; детям — только парацетамол и ибупрофен. Здоровым детям старше 3 месяцев жаропонижающее дают при температуре выше 39,0 °C в прямой кишке или выше 38,5 °C в подмышке.

Ибупрофен взрослым — 200–400 мг, детям — 7,5 мг/кг, не больше 30 мг/кг в сутки. Парацетамол взрослым — 500–1000 мг, детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не больше 60 мг/кг в сутки.

Системные кортикостероиды при боли в горле рутинно не назначают.

Исключение — сильный дискомфорт и угроза асфиксии, например при мононуклеозе. Тогда однократно внутрь дают #дексаметазон 0,3 или 0,6 мг/кг или #преднизолон 1 мг/кг (УУР В, УДД 1).

При сильной боли назначают местные анестетики и НПВП в спреях, растворах и таблетках для рассасывания с учётом возраста. При стрептококковой инфекции местное лечение антибиотики не заменяет.

Бензидамин разрешён с 3 лет, бензокаин с хлоргексидином — старше 4 лет, флурбипрофен — старше 12 лет, кетопрофен — с 12 лет. Средства для горла вообще применяют с 3–4 лет из-за риска ларингоспазма. Миндалины не «смазывают» и налёт механически не снимают.

Дополнительно, в том числе курсами между рецидивами, можно применять растительные препараты: корень алтея, ромашку, тысячелистник, кору дуба, хвощ, листья грецкого ореха, одуванчик.

Пища должна быть щадящей и мягкой: не острой, не кислой, не солёной, не горячей и не холодной.

При неосложнённом тонзиллофарингите хирургическое лечение не рекомендуется.

---

5. Профилактика, госпитализация, осложнения

разделы 5–7 текста КР
После тесного бытового контакта со стрептококковой инфекцией антибиотики для профилактики назначают беременным со сроком 37 недель и больше, новорождённым и родильницам в первые 28 дней, а также людям 75 лет и старше.

Больных стрептококковым тонзиллофарингитом изолируют от организованных коллективов и ограничивают их контакты.

При рецидивирующем тонзиллофарингите для профилактики рецидивов назначают лизаты бактерий.

При рецидивирующем тонзиллофарингите применяют БАД с естественными бактериями ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

После стрептококкового тонзиллофарингита пациента наблюдают месяц: общий анализ крови и мочи делают через 7–10 дней и через 3 недели, а при жалобах со стороны сердца — ЭКГ.

Лечат обычно амбулаторно. На антибиотиках улучшение наступает через 12–24 часа. В детский коллектив ребёнок возвращается после полного выздоровления.

В инфекционное отделение госпитализируют при тяжёлом состоянии и если из-за отказа от еды и питья нужна инфузионная терапия. При подозрении на гнойное осложнение, атипичной картине или необходимости операции пациента консультирует оториноларинголог и его госпитализируют в хирургическое отделение.

Стрептококковая инфекция даёт гнойные осложнения — паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцессы, гнойный лимфаденит — и негнойные: острую ревматическую лихорадку, ревматическую болезнь сердца, постстрептококковый гломерулонефрит, стрептококковый токсический шок, PANDAS.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 31.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	`306_3` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Дозы цефуроксима, амоксициллина, амоксициллина/клавуланата и клиндамицина в тексте и в таблице 1 различаются — подробно в блоке «Текст КР и таблица 1 расходятся» на вкладке «Лечение».
- В таблице 1 у бензатина бензилпенициллина в колонке «Дети» написано «у пациентов старше 12 лет при m<27 кг 600 тыс. ед» — по смыслу это дозировка по массе тела, как в тексте КР.
- Таблицы доз в PDF извлекаются вперемешку: все строки сверены по изображениям страниц 19–21.

Клинические рекомендации

Отит средний острый

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.0** — Острый средний серозный отит **H65.1** — Другие острые негнойные средние отиты **H66.0** — Острый гнойный средний отит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/314_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Острый средний отит — воспаление всех трёх отделов среднего уха: барабанной полости, клеток сосцевидного отростка и слуховой трубы. Проявляется болью в ухе, температурой, снижением слуха, иногда гноетечением.
- Диагноз ставят, когда одновременно есть внезапное начало, воспаление барабанной перепонки и признаки выпота: выбухание или сниженная подвижность перепонки при пневмоотоскопии или тимпанометрии. Внезапная оторея при исключённом наружном отите тоже подтверждает диагноз.
- Детям до 2 лет с признаками острого среднего отита антибиотик назначают всегда. В любом возрасте он нужен при гнойной форме, при симптомах дольше 72 часов, рецидивирующем отите, отягощающей сопутствующей патологии и если повторно осмотреть пациента нельзя.
- Препарат первой линии — амоксициллин. Если за 3 дня эффекта нет, его меняют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим. Курс — 7–10 дней.
- Для обезболивания назначают НПВП или парацетамол; ушные капли с лидокаином и феназоном можно только при целой барабанной перепонке.
- Через 3–4 недели пациента осматривают повторно с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы не пропустить экссудативный средний отит.

2. Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определения

Острый средний отит — воспаление всех трёх отделов среднего уха (барабанной полости, клеток сосцевидного отростка и слуховой трубы) с одним или несколькими симптомами: болью в ухе, повышением температуры, снижением слуха, иногда гноетечением. Поражается только слизистая оболочка.

Рецидивирующим отит называют, если за 6 месяцев было 3 эпизода и больше или за 12 месяцев — 4 и больше.

Затянувшимся отит называют, если симптомы воспаления среднего уха сохраняются 3–12 месяцев после одного или двух курсов антибиотиков.

У детей бывают возбуждение, раздражительность, рвота и понос. Обычно болезнь длится не дольше трёх недель.

2.2 Стадии

1) острый евстахеит; 2) катаральное воспаление; 3) доперфоративная стадия гнойного воспаления; 4) постперфоративная стадия гнойного воспаления; 5) репаративная стадия.

В катаральной стадии барабанная перепонка гиперемирована и утолщена, опознавательные знаки едва видны или не видны.

В гнойной стадии боль резко усиливается, температура поднимается до фебрильной, перепонка ярко-красная и выбухает, опознавательных знаков нет; возможна перфорация.

В постперфоративной стадии через перфорацию в слуховой проход поступает гной.

В репаративной стадии жалоб почти нет, цвет и толщина перепонки восстанавливаются, перфорация чаще закрывается рубцом, но слизистая среднего уха ещё не восстановилась.

2.3 Тяжесть

Лёгкое течение	Тяжёлое течение
Нет осложнений	Интратемпоральные или внутричерепные осложнения
Нет выбухания барабанной перепонки	Выраженное выбухание барабанной перепонки
Недолгая боль в ухе, хорошо снимается лекарствами	Выраженная боль (у маленьких детей — изменения поведения), плохо или не снимается лекарствами
Общее состояние не изменено: сон, еда, активность в норме	Общее состояние изменено
Нормальная температура или субфебрилитет не более 3 дней	Субфебрилитет более 3 дней или температура выше 38,0 °C

2.4 Клиническая картина

У детей старше 2 лет главный признак — внезапная боль в ухе на фоне воспаления барабанной перепонки (гиперемия, выбухание, сниженная подвижность при пневмоотоскопии), а после перфорации — оторея. У маленьких детей важнее выбухание перепонки и поведение: беспокойство, отказ от еды, ребёнок дёргает и трёт ухо.

Взрослые чаще жалуются на заложенность уха, аутофонию и шум в ухе.

Тугоухость кондуктивная; сенсоневральный компонент присоединяется редко.

2.5 Возбудитель и выбор антибиотика

Возбудителя иногда можно предположить по клинике: отит с конъюнктивитом чаще вызывает H. influenzae; стремительное начало с лихорадкой, спонтанной перфорацией и симптомами со стороны дыхательных путей — S. pyogenes; нарастающая боль, температура и спонтанная перфорация — S. pneumoniae.

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Диагноз ставят, когда одновременно есть три признака: внезапное начало, воспаление барабанной перепонки (гиперемия, инфильтрация) и выпот в барабанной полости (выбухание, сниженная подвижность при пневмоотоскопии или тимпанометрии). Внезапная оторея при исключённом наружном отите тоже подтверждает диагноз.

Каждого пациента должен осмотреть оториноларинголог.

Если реактивных изменений барабанной перепонки нет, её подвижность оценивают при пневматической отоскопии.

Тональную аудиометрию проводят при затяжном течении (дольше 10 дней), рецидивирующем отите или чтобы исключить нейросенсорную тугоухость.

Развёрнутый общий анализ крови делают всем пациентам.

Прокальцитонин определяют при подозрении на тяжёлое течение или в сложных случаях, чтобы подтвердить бактериальную природу отита.

3.1 Маркеры бактериального воспаления

Показатель	Катаральный отит	Гнойный отит
Лейкоциты <10 / 10–15 / >15 ×10⁹/л	50% / 38% / 12%	12% / 29% / 59%
СРБ <15 / 15–60 / ≥60 мг/л	33% / 50% / 17%	14% / 36% / 50%
ПКТ <0,5 / 0,5–2 / 2–10 нг/мл	58% / 38% / 4%	4% / 32% / 64%

Пороги для гнойного отита: лейкоциты >15×10⁹/л — ППР 85%, ПОР 64%; СРБ >30 мг/л — ППР 79%, ПОР 52%; ПКТ >2 нг/мл — ППР 94%, ПОР 74%. Таблица в PDF — изображение; значения перенесены вручную и сверены по изображению страницы 13.

Гнойное отделяемое отправляют на посев с определением чувствительности, если проводят парацентез или есть отделяемое из барабанной полости, а также в стационаре при тяжёлом и рецидивирующем отите.

КТ височных костей нужна при затяжном течении (дольше 10 дней), выраженном ухудшении и при подозрении на мастоидит или внутричерепные осложнения.

Если КТ сделать нельзя, при тех же показаниях делают рентгенографию височных костей по Шюллеру и Майеру.

---

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Боль и температура

При боли и лихорадке назначают НПВП или парацетамол. Их дают разово: при боли в ухе или температуре выше 38,5 °C, а если в анамнезе были фебрильные судороги — уже при 38,0 °C.

Детям до 6 лет можно только парацетамол — до 60 мг/кг в сутки (10–15 мг/кг на приём) — или ибупрофен — до 30 мг/кг в сутки (8–10 мг/кг на приём).

Для местного обезболивания назначают ушные капли с лидокаином и феназоном, но только если барабанная перепонка цела.

4.2 Когда нужен антибиотик

Системные антибиотики назначают при наличии показаний.

Показание	Когда
Возраст до 2 лет	Во всех случаях при клинических признаках ОСО
Гнойная форма — в любом возрасте	Перфорация с гнойным отделяемым; или без перфорации — боль, не снимаемая анальгетиками, с выраженной гиперемией, отсутствием опознавательных знаков, выбуханием перепонки
Симптомы дольше 72 часов — в любом возрасте	Боль, лихорадка или интоксикация при отоскопических признаках ОСО 72 часа и более от начала
Рецидивирующее течение	3 и более эпизода за 6 месяцев или 4 и более за год

Показание	Когда
Сопутствующая патология	Сахарный диабет, иммунодефицит, муковисцидоз, синдромы цилиарной дискинезии, синдром Дауна, врождённые аномалии твёрдого и мягкого нёба
Нельзя повторно осмотреть	Нет возможности контрольного осмотра с отоскопией у ЛОР-врача или врача общей практики

4.3 Выбор антибиотика

Препарат первой линии — амоксициллин, если пациент не принимал его последние 30 дней, у него нет гнойного конъюнктивита и непереносимости аминопенициллинов.

Вторая линия — защищённые пенициллины или цефалоспорины III поколения. Если за 3 дня амоксициллин не помог, его меняют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим.

При затянувшемся и рецидивирующем отите сразу начинают с амоксициллина с клавулановой кислотой или цефиксима внутрь.

Макролиды у детей — третья линия, и только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов, потому что устойчивость пневмококка к ним выше 40%.

При лёгкой непереносимости пенициллинов назначают цефалоспорины III поколения: амбулаторно цефиксим, в стационаре при необходимости цефтриаксон парентерально.

Курс длится 7–10 дней. Дольше лечат детей до 2 лет, пациентов с отореей и сопутствующими болезнями; при затянувшемся и рецидивирующем отите курс обычно не меньше 14 дней. Антибиотик не отменяют, пока не прекратилась оторея.

Тетрациклины, линкозамиды, аминогликозиды и ко-тримоксазол не применяют: они плохо действуют на пневмококк и гемофильную палочку и дают много побочных эффектов.

В постперфоративной стадии системные антибиотики продолжают.

4.4 Суточные дозы

Препарат	Взрослые	Дети
Препарат выбора		
Амоксициллин (независимо от еды)	0,5 г × 3 р/сут без факторов риска[1]; 1,0 г × 3 р/сут при факторах риска[2]	50–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма[1]
Альтернативные препараты		
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[3] (в начале еды)	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут	40–45 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в[4]	3,6 г/сут в 3 введения	90 мг/кг/сут в 3 введения (4–40 кг); 60 мг/кг/сут (менее 4 кг)
Ампициллин + сульбактам в/в[3]	1,5–3 г/сут на 4 введения	150–300 мг/кг/сут на 3–4 введения
Цефтриаксон[4]	2,0–4,0 г/сут в 1 введение	50–80 мг/кг/сут в 1 введение
Аллергия на пенициллины (не анафилактическая)		

Препарат	Взрослые	Дети
Цефуроксим (сразу после еды)	500 мг/сут в 2 приёма (так в таблице КР)	до 3 лет: 30 мг/кг/сут в 2 приёма; старше 3 лет: 500 мг/сут на 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1 приём	8 мг/кг/сут в 1 приём
Аллергия на пенициллины и цефалоспорины		
Кларитромицин внутрь (показание «острый средний отит» зарегистрировано только для гранул для суспензии 125 и 250 мг/5 мл)	1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма

[1] [2] Без / при факторах риска устойчивости пневмококка: антибиотики за предшествующие 3 месяца; дети-дошкольники в семье, посещающие детские учреждения; проживание в «закрытых» учреждениях. [3] Факторы риска β-лактамаз: сопутствующие заболевания (бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит), иммуносупрессия, неудача терапии амоксициллином. [4] При высоком риске осложнений.

> Внутри КР есть расхождение. В комментарии к рекомендации об амоксициллине обычная доза для детей — 45–60 мг/кг в сутки, а при высоком риске устойчивого пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки, тогда как в таблице 4 для детей указано 50–60 мг/кг в сутки.

Детям до 3 лет амоксициллин дают только в виде суспензии или диспергируемых таблеток. Амоксициллин с клавулановой кислотой и цефиксим в таблетках и капсулах разрешены с 12 лет; детям младше 12 лет с массой меньше 40 кг назначают гранулы, порошок для суспензии или диспергируемые таблетки.

4.5 Местная и вспомогательная терапия

При перфорации назначают ушные капли с фторхинолонами или с дексаметазоном в комбинации с противомикробными средствами, чтобы оторея прекратилась быстрее. Капли с аминогликозидами и спиртом нельзя: они ототоксичны.

Норфлоксацин разрешён детям старше 1 года, ципрофлоксацин — с 15 лет. Офлоксацин и дексаметазон с противомикробными средствами можно детям старше 1 года при остром гнойном отите и установленной тимпаностомической трубке.

Сосудосуживающие капли в нос назначают во всех стадиях, чтобы восстановить проходимость слуховой трубы, но не дольше 5–7 дней. Нафазолин не применяют.

Детям до 6 лет подходят фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет). До года — только капли, после года по возможности дозированный спрей.

Детям промывают нос изотоническим раствором морской воды 1–2 раза в день. Дошкольникам большие объёмы не используют, потому что это повышает риск отита.

Муколитики можно детям старше 2 лет. Показания проверяют по инструкции: не каждый муколитик для бронхов подходит при отите.

4.6 Хирургия

Парацентез делают при выраженных симптомах и выбухании перепонки без перфорации, при боли, которую не снимают НПВП, и если через 48–72 часа приёма антибиотиков нет улучшения. В сомнительных случаях решают в пользу парацентеза.

При внутривисочных или внутричерепных осложнениях проводят экстренную антромастоидотомию.

5. После острого периода и госпитализация

разделы 4–6 текста КР

Через 3–4 недели оториноларинголог повторно осматривает пациента с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы исключить экссудативный средний отит.

Если после отита пациент жалуется на снижение слуха, его направляют к сурдологу-оториноларингологу.

В репаративной стадии продувают слуховые трубы и делают пневмомассаж барабанных перепонок. То, что аэрация восстановилась, подтверждают объективно, в том числе тимпанометрией.

В репаративной стадии пациента консультирует физиотерапевт.

Всех детей прививают от пневмококковой инфекции по национальному календарю.

При рецидивирующем отите планово шунтируют барабанную полость (тимпаностомия).

Экстренно госпитализируют при тяжёлом течении, при лёгком течении без улучшения на адекватном лечении за 3–5 дней и при прогрессирующем ухудшении в любой момент.

Выписывают, когда состояние стабильно удовлетворительное не меньше 3 дней.

Отит тяжелее протекает и чаще осложняется при иммунодефиците и сахарном диабете. Чаще болеют пациенты с ГЭРБ, аллергическим ринитом и курильщики, в том числе пассивные.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Отит средний острый»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	314_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Детская доза амоксициллина: в комментарии к рекомендации — 45–60 мг/кг/сут («стандартная») и 80–90 мг/кг/сут (при высоком риске устойчивого пневмококка), в таблице 4 — 50–60 мг/кг/сут.
- Цефуроксим взрослым в таблице 4 — «500 мг/сут в 2 приёма»; проверьте по инструкции в ГРЛС.
- У ушных капель с офлоксацином в одном месте указан код АТХ S01AX13 (ципрофлоксацин), выше по тексту у офлоксацина — S01AX11.
- Таблица 2 (маркеры бактериального воспаления) в PDF вставлена изображением — её значения перенесены вручную.
- Капли с норфлоксацином: здесь — детям старше 1 года, в КР «Наружные отиты» (663_2) — с 15 лет. Проверьте по инструкции в ГРЛС.

Клинические рекомендации

Паратонзиллярный абсцесс

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J36** — Перитонзиллярный абсцесс **J39.0** — Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс **J39.1** — Другой абсцесс глотки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/664_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Паратонзиллярный абсцесс лечит оториноларинголог в стационаре, и основа лечения — хирургическое вскрытие абсцесса.
- Чаще всего, более чем в 70% случаев, абсцесс располагается спереди и сверху — между капсулой миндалины и верхней частью передней дужки.
- Антибиотики широкого спектра, действующие и на анаэробы, назначают сразу, не дожидаясь посева; курс обычно 10–14 дней.
- При частых ангинах, повторном или затяжном абсцессе, плохом дренировании и кровотечении после вскрытия удаляют миндалины одновременно со вскрытием абсцесса.
- После простого вскрытия двустороннюю тонзиллэктомию делают планово через 3 месяца.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Паратонзиллярный абсцесс — гнойное расплавление клетчатки вокруг миндалины, между её псевдокапсулой и глоточной фасцией, покрывающей констрикторы глотки.

2.2 Причины

Чаще всего абсцесс развивается как осложнение ангины, реже — хронического тонзиллита. Возможен одонтогенный путь — от кариеса задних нижних зубов (вторых моляров, зубов мудрости) и периостита альвеолярного отростка, а также инфицирование инородным телом, например рыбной костью.

Возбудители — чаще всего бета-гемолитический стрептококк группы А и неспорообразующие анаэробы.

При обращении отёчная форма паратонзиллита встречается редко, инфильтративная — у 15–20%, абсцедирующая — у 80–85% пациентов. От начала болезни до абсцесса обычно проходит 4–6 дней, но иногда всего несколько часов.

2.3 Локализация

Передневерхний (супратонзиллярный) абсцесс — больше 70% случаев, между капсулой миндалины и верхней частью передней дужки. Задний — около 15%, между миндалиной и задней дужкой. Нижний — чуть больше 5%, между нижним полюсом миндалины и боковой стенкой глотки. Боковой — меньше 5%, между средней частью миндалины и боковой стенкой глотки.

2.4 Клиническая картина

Абсцесс обычно возникает на фоне ангины или через несколько дней после неё. Сначала появляется боль при глотании, которая становится постоянной, резко усиливается при попытке проглотить слюну и отдаёт в ухо и зубы. Беспокоят головная боль и разбитость, температура поднимается до фебрильной, пациенты отказываются от еды и питья. Почти всегда постепенно нарастает тризм, речь становится невнятной и гнусавой. Из-за боли при поворотах пациент держит голову набок и поворачивается всем корпусом.

При передневерхнем абсцессе верхний полюс миндалины вместе с дужками и мягким нёбом резко выбухает к средней линии, язычок смещён в противоположную сторону, миндалина оттеснена книзу и кзади.

При заднем абсцессе припухлость видна в области задней дужки, процесс может переходить на боковую стенку глотки; миндалина и передняя дужка мало изменены, язычок и мягкое нёбо отёчны.

При нижнем абсцессе в глотке видны лишь отёк и инфильтрация нижней части передней дужки, хотя жалобы выражены. Может вовлекаться корень языка, иногда отекает язычная поверхность надгортанника, и отёк, распространяясь на гортань, может привести к её стенозу.

Боковой абсцесс встречается реже всего, но протекает тяжелее всех: гною трудно прорваться в глотку. Выражены отёк и инфильтрация мягких тканей шеи на стороне поражения, кривошея и тризм, а в глотке видно лишь умеренное выбухание всей миндалины.

2.5 Жалобы и анамнез

Важно узнать о недавних ангинах, хроническом тонзиллите, прошлых паратонзиллитах и абсцессах и их лечении, о кариесе и возможном инородном теле, например рыбной кости.

Характерны сильная, обычно односторонняя боль в горле, усиливающаяся при глотании и отдающая в ухо и зубы, ощущение инородного тела, гнусавость, неприятный запах изо рта, боль в шее при поворотах головы, тризм и слюнотечение. Из общих жалоб — слабость, разбитость, фебрильная температура и головная боль; они неспецифичны и требуют дифференциальной диагностики.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу, осмотру с тщательной оценкой подчелюстной области и лимфоузлов, фарингоскопии и анализам.

Каждого пациента с подозрением на абсцесс осматривает оториноларинголог.

Местные признаки, наиболее выраженные при переднем абсцессе: яркая гиперемия, отёк и инфильтрация дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка, асимметрия мягкого нёба, смещение миндалины, ограничение открывания рта, регионарный лимфаденит.

Фарингоскопию проводят всем детям и взрослым; её данные решают диагноз.

Если есть подозрение, что воспаление распространилось на гортаноглотку, проводят непрямую ларингоскопию или фиброларингоскопию.

КТ и УЗИ шеи делают в тяжёлых случаях, когда нужно уточнить диагноз и локализацию абсцесса или отличить его от воспаления глубоких отделов шеи.

3.1 Анализы

Всем делают развёрнутый анализ крови, СРБ и анализ мочи. Высокий лейкоцитоз со сдвигом влево и высокий СРБ говорят о высоком риске осложнений и требуют коррекции лечения, в том числе антибиотиков.

Гной после вскрытия отправляют на посев на аэробы и анаэробы с определением чувствительности, а мазок с миндалин — на дифтерийную палочку, чтобы исключить дифтерию.

Лучше брать не сам гной, а смыв или мазок со стенок полости: ферменты гноя разрушают микробы. Материал доставляют в лабораторию в транспортной среде, оптимально за 40 минут.

3.2 Дифференциальная диагностика

Абсцесс отличают от дифтерии, скарлатины, абсцесса язычной миндалины, абсцессов подъязычной области, флегмоны дна полости рта, опухолей ротоглотки и перикоронита.

При дифтерии слизистая бледно-цианотичная, налёты сероватые и выходят за пределы миндалин, но тризма нет.

При скарлатине есть сыпь на коже, чёткая граница поражённой слизистой и «малиновый» язык. При абсцессе язычной миндалины нет тризма и типичных изменений в ротоглотке. При флегмоне дна полости рта боль и отёк в подчелюстной области, язык малоподвижен, а дужки и миндалины не изменены.

Опухоли миндалины развиваются медленно, без температуры, сильной боли и тризма, а лимфоузлы плотные, малоболезненные и малоподвижные.

Изредка припухлость в глотке вызвана близко расположенной сонной артерией или её аневризмой; диагноз подсказывает видимая пульсация.

---

4. Лечение

Пациента лечит оториноларинголог в специализированном учреждении; основа лечения — хирургическая санация полости абсцесса.

4.1 Хирургическое лечение

Впервые возникший абсцесс вскрывают и дренируют.

Правила при любой технике: убедиться, что в месте вскрытия нет пульсации; глубже 0,5 см продвигаться только тупым путём; вскрывать достаточно широко, до 4 см.

Разрез выбирают по локализации, под местной аппликационной анестезией. Передневерхний абсцесс вскрывают через переднюю дужку в типичном месте или в месте наибольшего выбухания, задний — через заднюю дужку, отступив 0,5 см от края, нижний — в нижней части передней дужки. Ткани рассекают вдоль сосудов на глубину 0,5–1 см, дальше раздвигают корнцангом.

Затем регулярно разводят края разреза, пока полость не начнёт заживать.

При частых ангинах в анамнезе, повторном паратонзиллите или абсцессе, затяжном течении, плохом дренировании и кровотечении после вскрытия удаляют нёбные миндалины одновременно со вскрытием абсцесса: так убирается и сам очаг инфекции.

Такую операцию делают в любом возрасте, от 3–4 до 70 лет и старше. Противопоказания — терминальное или крайне тяжёлое состояние из-за болезней внутренних органов, тромбоз сосудов мозга, разлитой менингит.

После операции осматривают нишу миндалины: выпячивание в ней — признак парафарингеального абсцесса.

4.2 Антибиотики

Системные антибиотики назначают сразу, не дожидаясь посева. Так как в абсцессе обычно есть анаэробы, нужны препараты широкого спектра, которые действуют и на них.

Препарат	Доза
Амоксициллин и клавулановая кислота	С 12 лет или с массой от 40 кг — 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки. Можно #амоксициллин с сульбактамом по 1 г 2–3 раза в сутки с 12 лет, до 10 дней. Детям до 12 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Цефтриаксон	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки; длительность в таблице КР указана так: «в течение 4–14 дней до 10 дней». Новорождённым до 2 недель — 20–50 мг/кг 1 раз в сутки, не больше 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки.
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 1 г 2 раза в сутки, до 10 дней. Новорождённым и детям до 12 лет — 50–100 мг/кг в сутки с интервалом 6–12 часов; недоношенным — не больше 50 мг/кг в сутки.

Препарат	Доза
Клиндамицин	300 мг 2 раза в сутки, при тяжёлом течении — до 1,2–4,8 г в сутки в 2–4 приёма. Детям при непереносимости цефалоспоринов III поколения — #20–40 мг/кг в сутки в 3–4 приёма.

Курс обычно 10–14 дней. Препараты выбора — пенициллины, в том числе с ингибиторами бета-лактамаз. Если глотать таблетки трудно, используют диспергируемые формы, суспензии или инъекции. При выраженном отёке тканей глотки и шеи, сильном тризме и высоком риске генерализации назначают парентеральные цефалоспорины III поколения, а при их непереносимости — клиндамицин. Детям предпочтительны ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой.

4.3 Другие лекарства

При выраженных воспалительных проявлениях назначают НПВП в обычных дозах.

Всем назначают системные антигистаминные препараты.

КР рекомендует и средства для повышения сопротивляемости — препараты кальция, витамины С и А, — избегая полипрагмазии.

При выраженной интоксикации проводят инфузионную дезинтоксикационную терапию.

Всем назначают местные противовоспалительные, обезболивающие и антисептические средства: полоскания, инсуффляции, ингаляции, таблетки для рассасывания. Системные антибиотики они не заменяют.

После операции, не раньше чем через 3 недели после стихания воспаления, пациента консультирует физиотерапевт.

4.4 После вскрытия

После вскрытия абсцесса двустороннюю тонзиллэктомию делают планово через 3 месяца.

После тонзиллэктомии месяц ограничивают физическую нагрузку.

---

5. Профилактика, госпитализация, осложнения

При диспансеризации выявляют факторы риска — хронический тонзиллит и рецидивирующие ангины; профилактика включает закаливание и своевременное лечение зубов и дёсен.

Лечат в хирургическом стационаре. Показание к госпитализации — необходимость вскрыть абсцесс или удалить миндалины со вскрытием абсцесса. После вскрытия состояние улучшается уже через 12–24 часа. После абсцесстонзиллэктомии без осложнений выписывают на 5–7-е сутки.

Без лечения или при неправильном лечении высок риск гнойных осложнений: флегмоны шеи, медиастинита, тонзиллогенного сепсиса, инфекционно-токсического шока. Риск выше при иммунодефиците — врождённом, на иммуносупрессорах и цитостатиках, при ВИЧ.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Паратонзиллярный абсцесс»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	664_2 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Для цефтриаксона в таблице 1 написано «в течение 4-14 дней до 10 дней» — сроки противоречат друг другу; на сайте указано «до 10 дней».
- Знак # у амоксициллина с сульбактамом и у детской дозы клиндамицина означает применение вне инструкции.

Клинические рекомендации

Травма носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S00.3** — Поверхностная травма носа **S01.2** — Открытая рана носа **S02.2** — Перелом костей носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/815_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Перелом костей носа ищут на рентгенограмме костей лицевого скелета в боковой проекции (взрослым и детям с 3 лет), но её чувствительность не выше 70%, поэтому нормальный снимок перелома не исключает.
- Гематому или абсцесс перегородки носа вскрывают и дренируют, затем ставят переднюю тампонаду и делают ежедневные перевязки, пока не прекратится отделяемое.
- Если травма привела к деформации носа, кости репонируют и фиксируют; раннее вмешательство делают в первые 7 суток, а при тяжёлом состоянии или выраженном отёке его можно отложить до 15 суток.
- При изолированном переломе, даже открытом, системные антибиотики рутинно не назначают; их назначают при загрязнённых и гнойных ранах, выраженном отёчно-токсическом синдроме, осложнённой гематоме или абсцессе перегородки, сочетанной и комбинированной травме и тяжёлой сопутствующей патологии.
- Если повреждены кожа или слизистая и рана загрязнена землёй, проводят экстренную профилактику столбняка — как можно раньше, но не позже 20-го дня после травмы.
- Госпитализируют при тяжёлом состоянии, кровотечении, выраженном отёке или боли, деформации носа со смещением перегородки, осложнениях травмы, тяжёлой сопутствующей патологии, приёме антикоагулянтов или антиагрегантов, а также когда нужна закрытая репозиция.

2. Клиника и классификация

2.1 Определения

Травма носа — повреждение носа прямым или опосредованным действием травмирующего фактора снаружи или изнутри, при котором нарушается целость тканей и структур наружного носа и полости носа и страдают функции носа.

Поверхностной называют травму наружного носа, при которой не повреждены кожа, кости носа и слизистая полости носа и нет неврологических симптомов.

Ушиб носа — закрытое повреждение тупым предметом без видимого нарушения кожи и слизистых, с разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием. При кровоподтёке кровь пропитывает мягкие ткани наружного носа, тогда как гематома — это скопление крови в ограниченной полости. Ссадина — повреждение поверхностного слоя кожи, при котором видно место размозжения кожных сосудов.

Перелом костей носа (ПКН) — частичное или полное нарушение целости носовых костей, лобных отростков верхней челюсти, перегородки носа или носовой ости. Перелом закрытый, если кожа носа цела, и открытый, если отломки сообщаются с внешней средой через рану.

Рана носа — повреждение кожи наружного носа на всю глубину, часто с обнажением хрящей и костей и более глубоких структур полости носа, иногда с отрывом крыла или кончика носа.

2.2 Механизм травмы

При ударе во фронтальной плоскости ломаются носовые кости и западает спинка носа. Удар сбоку может разъединить носовую кость и лобный отросток верхней челюсти и сформировать сколиоз наружного носа, но чаще линия перелома проходит выше шва между ними. Обычно одновременно ломается и перегородка носа, чаще всего её хрящевой отдел.

У детей младшего возраста кости наружного носа эластичны, поэтому переломы бывают редко, а гематома и абсцесс перегородки носа — чаще.

При переломе нередко рвётся и отслаивается надхрящница или надкостница перегородки, и между хрящом и надхрящницей скапливается кровь — так образуется гематома перегородки носа. Если она инфицируется, развивается абсцесс, четырёхугольный хрящ расплавляется, и нос деформируется, а его функции нарушаются.

Травма носа бывает изолированной или сочетается с повреждением околоносовых пазух, глаза, скуловой области, нижней челюсти, полости рта, ушной раковины, сотрясением или ушибом головного мозга.

2.3 Классификация

Общепринятой классификации переломов нет. По классификации Ю. Н. Волкова (1958) переломы бывают открытыми и закрытыми, без деформации и с деформацией наружного носа.

По классификации С. Б. Бесшапочного (1984) переломы делят на переломы без деформации и с деформацией наружного носа; последние бывают одно- и двусторонними, с боковым смещением отломков, со смещением кзади или с сочетанием обоих.

По классификации А. С. Лопатина (2019) переломы бывают изолированными и сочетанными, открытыми и закрытыми; переломы со смещением делят по направлению удара — латеральному, фронтальному, фронтолатеральному и базальному.

По распространённости переломы бывают изолированными (с деформацией наружного носа или без неё), комбинированными — с травмой кожи лица, внутриносовых структур или околоносовых пазух — и сочетанными — с челюстно-лицевой или черепно-мозговой травмой, травмой конечностей, туловища и внутренних органов.

Перелом со смещением проходит три стадии. Острая стадия — первые 14 дней: кости репонируют по стандартной методике. Застарелый перелом — от двух недель до двух месяцев: репозиция возможна только вместе с операцией на перегородке носа. Стойкая деформация — больше двух месяцев: отломки можно сопоставить только после остеотомии.

2.4 Клиническая картина

Поверхностная травма проявляется слабо: в месте удара есть боль, небольшая припухлость и умеренное покраснение кожи без её повреждения.

При ушибе пирамида носа увеличена и её контуры сглажены из-за отёка; при кровоподтёке и ссадине меняются цвет и целость кожи; при переломе пирамида смещена вбок или вдавлена; при гематоме перегородка утолщена, а носовые ходы сужены. Бывают носовое кровотечение, боль и болезненность при пальпации, нарушение дыхания и обоняния. При сочетанной травме добавляются отёки, кровоподтёки, гематомы и раны в других зонах, нарушения зрения и сознания.

Симптомы перелома — отёк, боль, деформация наружного носа, крепитация и подвижность отломков, носовое кровотечение и затруднённое носовое дыхание.

У детей с переломом деформацию носа удаётся увидеть только в 57,5% случаев из-за выраженного отёка. Кроме того, у 7,4% детей деформация была и до травмы.

При переломе нередко повреждены кожа носа и слизистая полости носа, бывают эмфизема мягких тканей носа и лица и экхимозы. Носовое кровотечение частое, но при неосложнённом изолированном переломе оно редко бывает сильным и повторяющимся.

Перелом часто сопровождается кровоизлиянием в веки и мягкие ткани орбиты — «симптомом очков», однако этот же симптом бывает при переломе переднего основания черепа и травме кавернозного синуса.

Крепитация и подвижность отломков встречаются меньше чем в половине случаев, поэтому их отсутствие перелом не исключает. Боль в области носа тоже не специфична: она бывает при ушибах и воспалительных болезнях носа.

2.5 Жалобы и анамнез

Выясняют обстоятельства и механизм травмы, направление удара, была ли потеря сознания. Уточняют, были ли раньше травмы носа с деформацией и операции на носу. При комбинированной травме с повреждением кожи узнают о прививках от столбняка. При общем осмотре оценивают артериальное давление, пульс и частоту дыхания.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по факту травмы со слов пострадавшего или очевидцев; по жалобам на боль, изменение формы носа, затруднённое дыхание, кровотечение и нарушение обоняния; по осмотру — повреждениям кожи, деформации, крепитации и подвижности отломков, кровотечению. Перелом подтверждают рентгенографией костей лицевого скелета, а при противопоказаниях — УЗИ костей носа. При сочетанной травме повреждения пазух, орбиты, скуловой кости, верхней челюсти и черепа ищут на рентгенограммах черепа и КТ.

3.1 Осмотр

Каждого пациента с травмой носа осматривает оториноларинголог, чтобы определить характер и выраженность повреждений.

Всем пациентам пальпируют челюстно-лицевую область, чтобы уточнить характер травмы и выраженность повреждений.

При осмотре фиксируют отёк, гематомы, ссадины и раны, оценивают, есть ли деформация и насколько она выражена. При пальпации ищут крепитацию отломков, подкожную эмфизему и гематому, оценивают область носового клапана, подвижность крыльев носа и подвижной части перегородки. Для врачебной и судебно-медицинской экспертизы важно сфотографировать повреждения.

3.2 Анализы

Если травма сопровождается кровотечением, исследуют коагулограмму: она нужна, чтобы оценить гемостаз и кровопотерю и подготовиться к операции, если она потребуется.

3.3 Лучевая диагностика

Взрослым и детям с 3 лет делают рентгенографию костей лицевого скелета, чтобы выявить костные повреждения.

Снимок в боковой проекции важен и для диагноза, и юридически: в 70,2% случаев он показывает перелом и характер смещения отломков. Обычно ломаются обе носовые кости, но бывают одиночные и множественные переломы, поэтому, чтобы уточнить сторону перелома, боковые снимки делают при положении головы на левой и на правой стороне.
Чувствительность рентгенографии при переломе костей носа не выше 70%, а смещение во фронтальной плоскости на боковом снимке не видно. У детей до 3 лет снимок малоинформативен из-за слабой оссификации и преобладания хрящей. Поэтому отрицательный результат перелома не исключает.

Если подозревают смещение отломков в переднезаднем направлении, а на боковом снимке изменений нет, взрослым и детям с 3 лет делают рентгенографию околоносовых пазух.

Смещение отломков снаружи внутрь, невидимое на боковых снимках, выявляют на рентгенограмме околоносовых пазух в носоподбородочной проекции.

При комбинированной и сочетанной травме черепа делают КТ лицевого отдела черепа или челюстно-лицевой области и (или) КТ головного мозга.

КТ нужна при комбинированных и сочетанных переломах, признаках черепно-мозговой травмы (ЧМТ), неинформативной рентгенографии при клинических признаках перелома, планировании расширенной операции, подозрении на назальную ликворею, тяжёлом состоянии, продолжающемся или повторяющемся носовом кровотечении. Зону исследования выбирают по сопутствующей патологии.

Чувствительность КТ при переломе приближается к 100%. Исследование проводят в режиме спирального сканирования с толщиной среза 3 мм; оно показывает положение отломков, перегородку носа, повреждения пазух, орбиты, мозгового черепа, мягких тканей и мозга. Перед операцией рекомендуют 3D-реконструкцию.

Если лучевые методы противопоказаны, делают УЗИ костей носа.

УЗИ просто, неинвазивно, не облучает пациента и его можно повторять, чтобы контролировать репозицию и сращение отломков. Исследуют в четырёх проекциях: передней продольной, передней поперечной, правой и левой боковой.

3.4 Консультации

При подозрении на повреждение органа зрения пациента консультирует офтальмолог.

Всех пациентов с травмой носа консультирует невролог, чтобы вовремя выявить сопутствующую патологию.

При массивном кровотечении и сочетанной травме регистрируют ЭКГ, чтобы оценить сердечно-сосудистую систему и спланировать лечение.

---

4. Лечение

Консервативное лечение уменьшает боль и отёк, предупреждает бактериальное воспаление в зоне повреждения, ускоряет заживление и восстановление функций носа.

4.1 Обезболивание

Всем пациентам при отсутствии противопоказаний назначают анальгетики.

Сильная боль и стресс от травмы способствуют развитию или утяжелению травматического шока.

Применяют анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) по отдельности или вместе; у взрослых и детей, в том числе после операции, рекомендуют сочетать НПВП с парацетамолом, а также метамизол натрия. У детей из НПВП можно ибупрофен с 3 месяцев и кетопрофен с 15 лет, а кетопрофен в гранулах для приготовления раствора — с 6 лет. Метамизол натрия детям амбулаторно не назначают, а в стационаре используют, только если нет других разрешённых детям анальгетиков, из-за риска серьёзных нежелательных явлений.

4.2 Анальгетики у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	1 г внутривенно, инфузия 15 минут	4 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 мг внутримышечно (в таблице КР — «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 суток
Кеторолак	30 мг внутривенно, внутримышечно	6 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Лорноксикам	8 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

> В таблице 2 разовая доза диклофенака записана как «75 мл в/м» — единица измерения указана неверно; по смыслу таблицы и суточному максимуму 150 мг речь идёт о 75 мг.

4.3 Анальгетики у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия 15 минут: меньше 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; больше 50 кг — 1000 мг	4 ч	Меньше 10 кг — до 30 мг/кг; 10–50 кг — до 60 мг/кг, но не более 2 г (для 33–50 кг в той же ячейке — не более 3 г); больше 50 кг — 4 г	5–7 суток
Парацетамол внутрь	10–15 мг/кг	6 ч	не более 60 мг/кг	3–5 суток
Парацетамол ректально	3–12 месяцев — 50–100 мг; 1–3 года — 100–150 мг; 3–5 лет — 150–200 мг; 5–10 лет — 250–350 мг; 10–14 лет — 350–500 мг	6 ч	до 60 мг/кг	до 5 суток
Ибупрофен внутрь	3–6 месяцев — 50 мг; 6–12 месяцев — 50 мг; 1–3 года — 100 мг; 4–6 лет — 150 мг; старше 6 лет — 200–400 мг	6–8 ч (в ячейке есть и «8 ч» без пояснения)	3–6 месяцев — 150 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 1–3 года — 300 мг; 4–6 лет — 450 мг; 6–12 лет — 800 мг; 12–17 лет — 1 г	4 суток
Ибупрофен ректально	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	3–9 месяцев — 8 ч; 9–24 месяца — 6 ч	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	не более 3 суток
Метамизол натрия	С 15 лет — 500–1000 мг внутривенно, внутримышечно; 2–14 лет — 50–100 мг/кг внутримышечно, внутривенно; от 3 месяцев до года — 50–100 мг на 10 кг внутримышечно	8–12 ч	с 15 лет — 2 г	1–5 суток; детям младше 15 лет — 3 суток

В таблице 3 есть несогласованности. Для внутривенного парацетамола диапазоны веса пересекаются: для 33–50 кг указан суточный максимум 3 г, а для 10–50 кг — 2 г. Для метамизола натрия детям 2–14 лет указано 50–100 мг/кг, а детям до года — 50–100 мг на 10 кг, то есть в 10 раз меньше на килограмм. Дозы стоит сверить с инструкцией.

4.4 Профилактика столбняка и антибиотики

Если повреждены кожа или слизистая и травма получена при ударе о землю или в рану попала почва, вводят вакцину для профилактики столбняка.

Экстренную профилактику проводят как можно раньше, вплоть до 20-го дня после травмы, учитывая инкубационный период столбняка. Она включает первичную хирургическую обработку раны и одновременное введение столбнячного анатоксина, противостолбнячного иммуноглобулина человека или столбнячного антитоксина по инструкции.

При изолированном переломе костей носа, в том числе открытом, системные антибиотики до и после операции рутинно не назначают.

Профилактические антибиотики не снижают риск инфекционных осложнений после репозиции костей носа ни у взрослых, ни у детей.

Системные антибиотики назначают при загрязнённых и гнойных ранах кожи и слизистой, выраженном отёчно-токсическом синдроме, осложнённой гематоме или абсцессе перегородки носа, сочетанной и комбинированной травме и тяжёлой сопутствующей патологии.

При явном бактериальном воспалении или высоком риске его развития назначают препараты широкого спектра — бета-лактамы: цефазолин, цефтриаксон, ампициллин с сульбактамом, амоксициллин с клавулановой кислотой. При аллергии на бета-лактамы применяют клиндамицин.

Ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой шире, чем цефазолин, действуют на грамотрицательные и анаэробные бактерии.

Препарат	Доза
Ампициллин и сульбактам	Внутримышечно и внутривенно. Взрослым по тяжести инфекции 3–12 г в сутки в 3 введения, детям — 150 мг/кг в сутки в 3 введения (новорождённым — в 2), 5–14 дней.
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутривенно. Взрослым и детям старше 12 лет — по 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки, детям младше 12 лет — 25 мг/кг 3 раза в сутки, 5–14 дней.

4.5 Отёк, кровотечение, уход за носом

При выраженном отёке взрослым и детям старше 15 лет назначают ангиопротекторы, чтобы раньше можно было репонировать отломки и предупредить осложнения.

На спинку носа местно наносят троксерутин (взрослым и детям старше 15 лет) или гель гепарина натрия на неповреждённую кожу 2 раза в день, пока отёк не пройдёт.

При обильном кровотечении, а также для профилактики кровотечения во время и после операции назначают гемостатические средства.

Кровотечение бывает из полости носа и из повреждённых мягких тканей при открытых ранах. Механическую остановку кровотечения обычно дополняют гемостатиками: этамзилатом, транексамовой или аминокапроновой кислотой.

Препарат	Взрослые	Дети
Этамзилат	Для остановки кровотечения — 250–500 мг внутривенно или внутримышечно, затем по 250 мг каждые 4–6 часов. При репозиции — 250–500 мг за час до операции, при необходимости 250–500 мг во время операции и 500–750 мг равномерно в течение суток после неё.	10–15 мг/кг в сутки в 3–4 приёма, 5–10 дней. Во время операции — 8–10 мг/кг внутривенно, затем 10–15 мг/кг в течение суток.
Транексамовая кислота	Внутривенно капельно или медленно струйно со скоростью 1 мл/мин (50 мг/мин), 10–15 мг/кг каждые 6–8 часов до остановки кровотечения.	Старше 1 года — 20 мг/кг в сутки до остановки кровотечения.
Аминокапроновая кислота	Внутривенно капельно: 4–5 г за первый час, при продолжающемся кровотечении — по 1 г в час не дольше 8 часов; при необходимости инфузии повторяют каждые 4 часа; не более 30 г в сутки. Курс 3–14 дней.	100 мг/кг за первый час, затем 33 мг/кг в час; не более 18 г/м² в сутки (до года — 3 г, 2–6 лет — 3–6 г, 7–10 лет — 6–9 г, старше 10 лет — как взрослым). При острой кровопотере: до года — 6 г, 2–4 года — 6–9 г, 5–8 лет — 9–12 г, 9–10 лет — 18 г.

> Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере больше указанных рядом максимальных суточных доз: например, до года — 6 г при максимуме 3 г, в 9–10 лет — 18 г при максимуме 6–9 г.

Всем пациентам для облегчения носового дыхания назначают деконгестанты и другие назальные препараты.

Сосудосуживающие спреи и капли уменьшают реактивный отёк слизистой после травмы и облегчают дыхание после операции.

Препарат	Доза
Фенилэфрин 0,125%	Интраназально: до года — 1 капля, 1–6 лет — 1–2 капли, старше 6 лет — 3–4 капли до 3 раз в сутки, до 7 дней.
Оксиметазолин	До года — 0,01%, 1–6 лет — 0,025%, старше 6 лет — 0,05%; по 1–2 капли интраназально 2–3 раза в сутки, до 5 дней.
Ксилометазолин	2–6 лет — 0,05%, старше 6 лет — 0,1%; спрей по 1 дозе 2–3 раза в сутки, до 5 дней.

При повреждении кожи или слизистой с признаками инфицирования раны или высоким риском инфицирования назначают местные антисептики.

Используют бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (спрей — не детям до 3 лет), повидон-йод и хлоргексидин. Как часто обрабатывать рану, зависит от воспаления и экссудата; обрабатывают до разрешения инфекции или начала заживления.

Всем пациентам промывают нос, чтобы ускорить заживление слизистой.

Уход за полостью носа после травмы и операции ускоряет заживление и предупреждает осложнения, например синехии. Используют стерильные изотонические растворы морской воды 2–3 раза в день, пока слизистая не эпителизируется и не стихнет воспаление.

4.6 Хирургическое лечение

Неотложно при травме носа останавливают кровотечение и проводят первичную хирургическую обработку открытых ран. При переломе операция нужна, чтобы восстановить форму наружного носа, устранить смещение внутриносовых структур и вернуть дыхание.

При открытых ранах и открытых переломах рану хирургически обрабатывают, иссекают инфицированные ткани и накладывают косметический шов.

Перед швом рану тщательно осматривают, удаляют инородные тела и зондируют раневой канал.

Если гемостатики и тампонада не помогают, кровотечение останавливают хирургически.

Метод выбирают по источнику. При кровотечении из передних отделов отслаивают участок мукоперихондрия с последующей тампонадой, выскабливают расширенный сосуд, применяют криокоагуляцию или электрокаустику. При обильном кровотечении перевязывают наружную сонную артерию, эндоскопически клипируют сосуды или выполняют эндоваскулярную эмболизацию. При кровотечении из решётчатых артерий делают этмоидотомию наружным, внутренним или эндоназальным доступом.

Гематому или абсцесс перегородки носа вскрывают и дренируют.

После вскрытия ставят переднюю тампонаду и делают ежедневные перевязки, пока не прекратится отделяемое.

Если травма привела к деформации наружного носа, кости репонируют и фиксируют отломки, чтобы восстановить форму носа и дыхание.

Операция бывает ранней — в первые 7 суток после травмы, отложенной — на 8–15-е сутки, и плановой — через 6 месяцев и позже.

Рано оперируют при минимальном или умеренном отёке, а также при комбинированной травме с повреждением внутриносовых структур или пазух и при гематоме перегородки. Ранняя операция помогает избежать септических осложнений и синехий.

При тяжёлом состоянии, выраженном отёке, комбинированных переломах костей и перегородки носа и ранениях лица операцию можно отложить до 15 суток.

> По классификации в разделе 1.5 острая стадия, когда кости репонируют по стандартной методике, длится 14 дней, а после двух недель репозиция возможна только с операцией на перегородке. В разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.

Планово (риносептопластикой) переломы оперируют при сочетанной травме с переломом основания черепа и назальной ликвореей и при тяжёлых функциональных нарушениях.

Кости репонируют наружным (пальцевым), эндоназальным (инструментальным) или экстраназальным (открытым) способом. У детей наружный способ эффективен лишь в 22% случаев, поэтому им лучше репонировать эндоназально элеваторами Манакова или Волкова с последующей передней тампонадой. Открытый способ применяют, когда одновременно оперируют по поводу внутричерепной травмы или травмы лобных пазух и верхней челюсти.

При комбинированных назосептальных переломах в остром периоде одновременно репонируют кости и выполняют септопластику. При сочетанной травме репозицию лучше делать вместе с другими хирургами, если они оперируют под наркозом.

При подозрении на черепно-мозговую травму вправление откладывают до осмотра невролога или нейрохирурга и нужных обследований.

4.7 Анестезия, тампонада, повязка

При операциях по поводу открытых и закрытых переломов и смещения внутриносовых структур проводят анестезию наружного носа и полости носа.

Взрослым при изолированной травме наносят местный анестетик на слизистую полости носа и вводят анальгетики внутримышечно или проводят проводниковую анестезию артикаином. Детям рекомендуют сочетанную анестезию.

При переломах костей наружного носа и внутриносовых структур ставят переднюю тампонаду, чтобы удержать сопоставленные отломки и остановить кровотечение при травме слизистой.

Тампон вводят на стороне деформации и удаляют на 2–3-и сутки после операции; срок зависит от подвижности отломков. Польза длительной тампонады (больше 3–5 дней) после репозиции не доказана.

При переломах, сложных травмах и после операций накладывают пращевидную повязку, чтобы отломки не сместились.

Наружную шину после закрытой репозиции рутинно не применяют, только при тяжёлых оскольчатых переломах.

При выраженных реактивных воспалительных явлениях пациента консультирует физиотерапевт.

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области и магнитотерапия уменьшают воспаление и отёк и ускоряют заживление.

На время лечения пациенту советуют ограничить физическую активность, избегать действий, которые могут сместить отломки, в том числе во сне, есть полноценную витаминизированную легкоусвояемую пищу и не ходить в горячую ванну, душ, сауну и бассейн.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

После операций по поводу деформации наружного носа или перегородки пациента в течение года наблюдает оториноларинголог; обязательные осмотры — через 1, 3 и 6 месяцев и через год после операции.

Травмы предупреждают общими социальными мерами профилактики травматизма.

Это соблюдение техники безопасности в детских учреждениях, на производстве и в быту, разъяснительная работа с родителями и пропаганда здорового образа жизни.

5.1 Госпитализация

Госпитализируют при тяжёлом состоянии, выраженном отёке, кровотечении, сильной боли; при комбинированных переломах костей и перегородки носа с повреждением пазух и ранениями лица; при травматической деформации носа со смещением перегородки или нарушением дыхания; при тяжёлой сопутствующей патологии; пациентов, принимающих антикоагулянты или антиагреганты; при осложнениях — гематоме и абсцессе перегородки, воспалении пазух и соседних областей; а также если нужна закрытая репозиция.

Выписывают при удовлетворительном состоянии и нормальных клинических показателях, улучшении формы носа и носового дыхания и отсутствии осложнений.

Прогноз благоприятный, если лечение проведено по рекомендациям и пациент выполняет назначения врача.

Пациенту объясняют, что при выраженном отёке лица, деформации носа, повреждении мягких тканей, кровотечении из носа или нарушении дыхания нужна экстренная консультация оториноларинголога: запоздалое лечение может привести к опасным осложнениям.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	815_1 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- В разделе 1.4 коды МКБ записаны с лишней точкой: «S.00.3», «S.02.2», «S.02.20», «S.02.21»; на титульном листе — правильно (S00.3, S02.2 и т. д.).
- В таблице 2 разовая доза диклофенака указана как «75 мл в/м» вместо миллиграммов.
- В таблице 3 для внутривенного парацетамола пересекаются весовые диапазоны с разными суточными максимумами (33–50 кг — 3 г, 10–50 кг — 2 г); для метамизола натрия доза у детей 2–14 лет (50–100 мг/кг) в 10 раз больше на килограмм, чем у детей до года (50–100 мг на 10 кг). Для ибупрофена внутрь в графе интервала стоят и «6–8 ч», и «8 ч» без пояснения.
- Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере (до года — 6 г, 9–10 лет — 18 г) превышают указанные рядом максимальные суточные дозы (3 г и 6–9 г).
- Острая стадия перелома в разделе 1.5 — 14 дней, а в разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.
- Критерии качества требуют рентгенографии или КТ у всех пациентов, тогда как рентгенографию рекомендуют только с 3 лет.
- В рекомендации о коагулограмме написано «система гомеостаза» вместо «гемостаза»; в оглавлении номера страниц разделов 6, 7 и критериев качества не совпадают с текстом.

Клинические рекомендации

Хронический синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J32.0** — Хронический верхнечелюстной синусит **J32.1** — Хронический фронтальный синусит **J32.2** — Хронический этмоидальный синусит **J32.3** — Хронический сфеноидальный синусит **J32.4** — Хронический пансинусит **J32.8** — Другие хронические синуситы **J32.9** — Хронический синусит неуточненный **J34.1** — Киста или мукоцеле носового синуса
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/955_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Хронический синусит у взрослого диагностируют, если два симптома или больше держатся 12 недель и дольше, причём один из них — заложенность носа или выделения из носа; диагноз подкрепляют эндоскопические признаки или изменения на КТ.
- Основа консервативного лечения — промывание носа солевым раствором всем пациентам и интраназальные глюкокортикостероиды с 12 лет; чтобы оценить эффект гормонов, их применяют не меньше 3 месяцев.
- Системные антибиотики назначают только при среднетяжёлом и тяжёлом обострении или осложнениях; стартовый препарат в амбулаторной практике — амоксициллин с клавулановой кислотой.
- Взрослым, которым не помогли 1–2 курса адекватной консервативной терапии, выполняют функциональную риносинус-хирургию.
- Случайно найденную бессимптомную кисту пазухи большинство экспертов не оперируют: многие кисты медленно уменьшаются сами или не меняются.
- Мукоцеле медленно растёт, растягивает и иногда разрушает стенку пазухи, поэтому его всегда лечат хирургически.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Хронический синусит (хронический риносинусит, ХРС) — воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух, которое держится больше 12 недель и сопровождается двумя симптомами или больше. Один из них — заложенность носа или выделения из носа (наружу или в носоглотку); к нему могут добавляться боль или давление в области лица и снижение или потеря обоняния.

Ретенционные (истинные, секретирующие) кисты пазух образуются, когда закупориваются выводные протоки желёз слизистой; изнутри и снаружи они выстланы мерцательным цилиндрическим эпителием. Лимфоэктатические (несекретирующие, ложные, интрамуральные) кисты лежат в толще слизистой, не имеют внутренней эпителиальной выстилки и возникают из-за хронического воспаления в пазухах или баротравмы.

Мукоцеле — доброкачественное, медленно растущее кистовидное образование пазухи. Оно возникает, когда естественное соустье стойко перестаёт дренировать пазуху, и часто растягивает, реже разрушает её стенки.

2.2 Причины

С развитием ХРС связывают аллергический ринит, первичную цилиарную дискинезию, муковисцидоз, бронхиальную астму, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), иммунодефицит и аутоиммунные системные болезни.

Важный фактор риска — анатомические особенности в области остиомеатального комплекса: искривление перегородки носа, буллёзная или парадоксально изогнутая средняя носовая раковина, гиперпневматизация решётчатой буллы, супрабуллярной или инфраорбитальной клетки, аномалии крючковидного отростка, добавочное соустье верхнечелюстной пазухи. Они нарушают вентиляцию носа и отток секрета из носа и пазух. У детей, гораздо реже у взрослых, ХРС бывает связан с гипертрофией аденоидов.

У детей, особенно дошкольников, главная причина ХРС — муковисцидоз, реже первичная цилиарная дискинезия. По отечественным данным, связи между ХРС и искривлением перегородки носа у детей не найдено.

Предрасполагать к ХРС может и аллергический отёк слизистой в области среднего носового хода; аллергический ринит и хронический синусит часто сочетаются.

Одонтогенный синусит связан с болезнями зубов и стоматологическим лечением. Хронический верхнечелюстной синусит может осложнять периодонтит или пародонтит; частая причина — эндодонтическое лечение, когда в пазуху через каналы попадают инфицированный детрит или пломбировочный материал. Воспаление в пазухе могут вызвать и дентальная имплантация с предшествующим наращиванием кости. При одонтогенном синусите среди возбудителей преобладают анаэробы.

ГЭРБ тоже может способствовать ХРС: рефлюктат, попадая на слизистую носа и носоглотки, вызывает воспаление и нарушает мукоцилиарный клиренс, а это может привести к блоку остиомеатального комплекса.

Важный фактор риска — курение: табак токсичен для слизистой носа, сушит её и меняет свойства слизи.

Связь ретенционных кист с воспалением в носу и травмами не доказана. Лимфоэктатические кисты чаще всего вызывает хроническое, прежде всего аллергическое, воспаление слизистой; риск повышают гипервентиляция верхнечелюстной пазухи и баротравма. Радикулярная одонтогенная киста растёт из эпителиальной гранулёмы у верхушки корня кариозного зуба, зубная киста может оттеснять дно верхнечелюстной пазухи или прорастать в неё, фолликулярная развивается очень медленно из зубного фолликула.

Мукоцеле в подавляющем большинстве случаев — следствие операций на пазухах; другие причины — травма, хроническое воспаление пазух, опухоли и лучевая терапия. Больше чем в трети случаев причину найти не удаётся; описаны и врождённые мукоцеле. У детей мукоцеле чаще всего возникает из-за вторичного хронического синусита при муковисцидозе.

2.3 Классификация

По локализации, с указанием стороны, синусит бывает верхнечелюстным, этмоидальным, фронтальным и сфеноидальным. Если воспалены пазухи только одной стороны, говорят о гемисинусите, если несколько пазух — о полисинусите.

В практике принято делить хронический синусит на полипозный риносинусит и синусит без полипов.

По возбудителю синусит бывает бактериальным, грибковым и бактериально-грибковым.

По тяжести течения, которую оценивают по суммарной выраженности симптомов на визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10, выделяют лёгкую форму (0–3 балла), среднетяжёлую (4–7) и тяжёлую (8–10).

> Классификация по тяжести ссылается на приложение Г1, но там описана ВАШ только для интенсивности боли и с другой градацией: до 2 см — слабая боль, 2–4 — умеренная, 4–6 — сильная, 6–8 — сильнейшая, до 10 — невыносимая. Как считать суммарную выраженность симптомов, в КР не сказано.

Классификация EPOS 2020 года построена на эндотипах и фенотипах. Первичный синусит бывает односторонним (локализованным) — с воспалением 2-го типа или не 2-го типа, сюда же относят аллергический грибковый и изолированный синусит одной пазухи — и двусторонним (диффузным) — с теми же двумя эндотипами, эозинофильным или неэозинофильным. Вторичный односторонний синусит связан с одонтогенным процессом, мицетомой («грибковым шаром») или опухолью. Вторичный двусторонний бывает механическим, воспалительным и иммунным; его фенотипы — первичная цилиарная дискинезия, муковисцидоз, гранулематоз с полиангиитом, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом и селективный иммунодефицит.

Кисты в России обычно делят по классификации М. И. Кадымовой на ретенционные, лимфоэктатические, одонтогенные (радикулярные) кисты верхнечелюстной пазухи и кисты, связанные с пороками развития.

Больше 90% кист находятся в верхнечелюстной пазухе, около 5% — в клиновидной, в лобной пазухе и клетках решётчатого лабиринта — крайне редко. Больше чем в 80% случаев киста односторонняя; несколько кист бывает лишь у четверти пациентов.

Мукоцеле чаще всего поражает лобные пазухи, реже клетки решётчатого лабиринта, верхнечелюстные и клиновидные пазухи; некоторые авторы считают самой частой лобно-решётчатую локализацию. Описаны и крайне редкие места — нижняя стенка орбиты, крыловидное пространство, средняя и нижняя носовые раковины.

2.4 Клиническая картина

Клиника ХРС неспецифична: заложенность носа, выделения спереди и по задней стенке глотки, головная или лицевая боль, снижение или отсутствие обоняния, ощущение неприятного запаха в носу. Главные симптомы, сильнее всего влияющие на самочувствие, — заложенность и выделения. У детей ключевым симптомом бывает и кашель, связанный со стеканием слизи по задней стенке глотки. От острого синусита хронический отличается тем, что симптомы держатся больше 12 недель, не проходя полностью.

Кисты пазух часто ничем себя не проявляют и находятся случайно на снимках головы. Большая киста чаще всего вызывает головную или лицевую боль, редко — внезапное истечение из носа янтарной жидкости при самопроизвольном разрыве, онемение верхней губы или зубную боль. Заложенность носа, выделения и кашель от стекания слизи у пациента с кистой, скорее всего, вызваны сопутствующим аллергическим ринитом или ХРС.

Проявления мукоцеле зависят от его локализации и размера. Основные симптомы — головная боль, давление в области лица, заложенность носа, выделения и боль вокруг глаза. Небольшое мукоцеле может протекать бессимптомно, но гораздо реже, чем киста.

2.5 Жалобы и анамнез

Взрослые жалуются на стойкую, одностороннюю или попеременную заложенность носа, слизистые или слизисто-гнойные выделения, необходимость сморкаться или стекание слизи по задней стенке глотки — сильнее после пробуждения или постоянно в течение дня, на неприятный запах в носу или носоглотке, снижение обоняния вплоть до аносмии. При хроническом сфеноидите бывает периодическая боль в темени и затылке.

Для хронического фронтита характерна сильная боль в проекции лобной пазухи на стороне поражения при обострении или при перемене атмосферного давления. Бывает ощущение давления позади спинки носа и глазных яблок, сильнее при обострении.

У маленьких детей жалобы узнают от родителей или опекунов: частые затяжные «насморки», заложенность носа, слизистые выделения, кашель, в основном ночью или лёжа на спине.

Если на снимках нашли кистоподобное образование, прежде всего выясняют, есть ли головная или лицевая боль, постоянна ли она и что её вызывает или усиливает. Расспрашивают о прошлых операциях на носу и пазухах и стоматологическом лечении.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

У взрослого хронический синусит диагностируют, если 12 недель и дольше есть два симптома или больше, причём один из них — заложенность носа, затруднённое носовое дыхание или выделения из носа (спереди или по задней стенке глотки); к ним могут присоединяться боль или распирание в проекции пазух и снижение или потеря обоняния. Диагноз подкрепляют эндоскопические признаки — полипы, слизисто-гнойные выделения или отёк и обструкция слизистой, в основном в среднем носовом ходе, — и изменения слизистой остиомеатального комплекса или пазух на КТ.

У ребёнка нужны два симптома или больше в течение 12 недель и дольше из четырёх: затруднённое носовое дыхание, боль или распирание в проекции пазух, выделения из носа или стекание по задней стенке глотки, кашель. Эндоскопические признаки и изменения на КТ те же, что у взрослых.

Кисту пазухи диагностируют по КТ или МРТ: округлое однородное мягкотканное образование на широком основании с чёткими границами, без разрушения кости и выраженной деформации стенок. Отличить ретенционную кисту от лимфоэктатической можно только гистологически, по оболочке удалённой кисты.

Одонтогенную кисту верхнечелюстной пазухи диагностируют по КТ — однородное образование на широком основании на нижней стенке пазухи, с чёткими границами, оболочкой костной плотности и связью с корнями верхних зубов — вместе с заключением стоматолога-хирурга или челюстно-лицевого хирурга о болезни соседних зубов.

Мукоцеле диагностируют по КТ: образование в пазухе с округлым ровным контуром и однородным содержимым без кальцинатов и включений; соседние кости могут истончаться, а образование — выпячиваться в соседние области.

3.2 Осмотр и консультации

Всех пациентов с хроническим синуситом и с подозрением на кисту или мукоцеле осматривает оториноларинголог: оценивает состояние, собирает жалобы и анамнез, планирует лечение.

Если аллергологический анамнез отягощён, пациента с хроническим синуситом, а взрослого — и с подозрением на кисту или мукоцеле, консультирует аллерголог.

При симптомах рефлюкса пациента консультирует гастроэнтеролог.

При признаках муковисцидоза или первичной цилиарной дискинезии пациента консультирует генетик.

При подозрении на одонтогенный синусит или кисту верхнечелюстной пазухи пациента консультирует стоматолог-хирург или челюстно-лицевой хирург, чтобы подтвердить или исключить зубную причину.

3.3 Посев

При среднетяжёлом и тяжёлом течении и при обострении гнойное отделяемое отправляют на посев на аэробы и факультативные анаэробы с определением чувствительности, чтобы подобрать или скорректировать антибиотик.

Лучший материал — аспират прямо из поражённой пазухи, полученный при пункции верхнечелюстной пазухи или во время операции.

3.4 Инструментальные исследования

Всем пациентам с предполагаемым хроническим синуситом проводят эндоскопию полости носа и носоглотки, чтобы осмотреть синоназальные структуры и подтвердить диагноз.

Спиральную КТ пазух делают при признаках осложнений во время обострения, перед операцией и когда нужна дифференциальная диагностика.

КТ — самый информативный метод и у взрослых, и у детей. Она показывает изолированное воспаление, блок соустья, инородное тело, диффузный грибковый процесс или мицетому, опухоль, аномалии пазух, позволяет заподозрить одонтогенную причину. Типичные признаки ХРС — утолщение слизистой и снижение пневматизации в области соустий.
Чтобы спланировать объём операции, КТ делают не раньше чем за 6 месяцев до неё.

Спиральную КТ пазух делают всем пациентам с подозрением на кисту, найденную другим методом и дающую постоянные или периодические симптомы, и всем с подозрением на мукоцеле.

Если мукоцеле трудно отличить от других образований, КТ делают с внутривенным болюсным контрастированием: контраст накапливают оболочка мукоцеле, но не его содержимое.

---

4. Лечение

Причин ХРС много, и они могут действовать одновременно, поэтому лечение подбирают каждому пациенту индивидуально.

Основа консервативного лечения — лекарства; по показаниям их можно назначать и после функциональной риносинус-хирургии.

Доказательств, что кисты и мукоцеле пазух поддаются консервативному лечению, нет; симптомы могут уменьшиться, только если лекарства помогают при сопутствующем ХРС или аллергическом рините.

4.1 Базовая терапия

Всем пациентам с ХРС назначают промывание носа гипертоническим или изотоническим солевым раствором: оно очищает полость носа и уменьшает нагрузку антигенами на слизистую.

Промывание важно и как часть лечения после операции.

Пациентам старше 12 лет назначают интраназальные глюкокортикостероиды (ИНГКС), чтобы уменьшить симптомы.

Единой схемы доз, кратности и длительности нет, допустимы и низкие, и высокие дозы. Чтобы оценить эффект, лечение продолжают не меньше 3 месяцев.
Носовые кровотечения из-за сухости слизистой чаще бывают при высоких дозах. Официально зарегистрированное показание при хроническом риносинусите есть только у назального спрея мометазона: взрослым и детям старше 12 лет — по 2 дозы (100 мкг) в каждую половину носа 2 раза в сутки, то есть 400 мкг в сутки.

4.2 Системные антибиотики

Системные антибиотики назначают при среднетяжёлом и тяжёлом обострении, в том числе с периорбитальными и внутричерепными осложнениями, а также при таком обострении у пациентов с болезнями, повышающими риск бактериальной инфекции.

Препарат	Когда и в какой дозе
Амоксициллин и клавулановая кислота	Стартовый препарат при обострении в амбулаторной практике у детей и взрослых. Детям от 3 месяцев до 12 лет или с массой меньше 40 кг — 40 мг/кг в сутки в 3 приёма каждые 8 часов (суспензии 125/31,25 мг и 250/62,5 мг в 5 мл); суспензию 400/57 мг в 5 мл дают по 45 мг/кг в сутки в 2 приёма. При высоком риске полирезистентного пневмококка — суспензия 600/42,9 мг в 5 мл, 90 мг/кг в сутки по амоксициллину в 2 приёма. С массой больше 40 кг и старше 12 лет — таблетки 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	При лёгкой аллергии на пенициллины. Детям младше 12 лет или с массой меньше 50 кг — 8 мг/кг в сутки 1 раз в день; старше 12 лет — 400 мг 1 раз в день.
Цефиксим, цефтриаксон, цефотаксим	Если не помог амоксициллин с клавулановой кислотой. Старше 12 лет или с массой от 50 кг: цефиксим внутрь 400 мг 1 раз в день, цефтриаксон внутривенно или внутримышечно 1–2 г 1 раз в сутки, цефотаксим внутривенно или внутримышечно 1 г каждые 12 часов. Детям младше 12 лет или с массой меньше 50 кг: цефиксим 8 мг/кг в сутки 1 раз в день, цефтриаксон 75–80 мг/кг в сутки 1 раз в день, цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 2–4 введения.
#Левофлоксацин, #моксифлоксацин	Только взрослым амбулаторным пациентам при непереносимости всех бета-лактамов или тяжёлой аллергии на пенициллины: #левофлоксацин 500 мг внутрь 1 раз в сутки или #моксифлоксацин 400 мг внутрь 1 раз в сутки, курсом 10–14 дней. Знак # означает применение вне инструкции.

Ребёнка с обострением, которому нужны системные антибиотики, но нельзя назначить пенициллины, лучше лечить в стационаре; препарат выбирают по тяжести, локализации и распространённости воспаления и чувствительности выделенного микроба.

Если стартовый антибиотик амбулаторно не помог, стоит решить вопрос о направлении пациента в ЛОР-отделение стационара по неотложному каналу. В стационаре при среднетяжёлом течении лучше давать препараты внутрь, а если это невозможно — парентерально; при тяжёлом, в том числе осложнённом, обострении антибиотики вводят внутривенно.

Если не помогли цефалоспорины III поколения или выделены устойчивые к ним штаммы, назначают препарат резерва — цефалоспорин IV поколения, карбапенем, оксазолидинон, гликопептид и другие — с учётом чувствительности возбудителя.

Эффект антибиотика должен появиться на третьи сутки; если он есть, препарат продолжают 10–14 дней.

4.3 Местные антибиотики

При лёгком обострении у пациента, которому раньше делали синусотомию, при появлении гнойных выделений назначают местные антибиотики.

Эффект оценивают через 3–4 дня; если его нет, решают вопрос о системных антибиотиках.

В России при ХРС зарегистрированы назальный спрей фрамицетина — для детей с первых лет жизни — и комбинированный спрей с дексаметазоном, неомицином, полимиксином B и фенилэфрином — с 2,5 лет. Разовую и суточную дозы соблюдают строго по инструкции. Фрамицетин при обострении применяют не дольше 7 дней, комбинированный препарат — не дольше 10 дней.

Растворы антибиотиков для внутримышечного и внутривенного введения в нос и пазухи вводить нельзя: они для этого не предназначены и повреждают мерцательный эпителий. В пазуху можно вводить тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат.

4.4 Другие лекарства

При обострении, если нет противопоказаний, назначают растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием, чтобы симптомы прошли быстрее.

Эффективны комбинированные препараты с экстрактами корня горечавки жёлтой, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины чёрной и травы вербены, а также миртол.

При обострении назначают сосудосуживающие капли или спреи в нос, чтобы облегчить отток секрета из пазух.

Нафазолин очень токсичен, в ЛОР-практике его применять нельзя. Предпочтительны оксиметазолин 0,01–0,05% и ксилометазолин 0,05–0,1%. Применяют их строго по назначению и под контролем врача, не дольше 5–7 дней, иначе возникает медикаментозный ринит.

Муколитики назначают, чтобы разжидить отделяемое и облегчить его отток.

Карбоцистеин дают коротким курсом, до 2–3 недель, при обострении с густым секретом в носу; возможны и курсы около 3 месяцев вместе с противовоспалительными средствами. Одновременно с другими отхаркивающими и муколитиками, в том числе местными, его не назначают, иначе усиливается стекание слизи по задней стенке глотки.

При температуре, головной или лицевой боли во время обострения назначают нестероидные противовоспалительные препараты или парацетамол.

Детям до 6 лет можно только парацетамол — до 60 мг/кг в сутки — или ибупрофен — до 30 мг/кг в сутки.

4.5 Хирургическое лечение

При тяжёлом обострении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями, оперируют в неотложном или экстренном порядке. При среднетяжёлом обострении, если консервативное лечение не помогает, можно неотложно провести малоинвазивные манипуляции. Остальных пациентов оперируют планово по показаниям; если показаний нет или есть противопоказания, лечат консервативно и наблюдают у оториноларинголога.

Под функциональной риносинус-хирургией КР понимает фронтотомию, этмоидотомию, сфеноидотомию, гайморотомию и вмешательства на структурах полости носа. У взрослых, если позволяет оснащение, предпочтительна эндоскопическая техника; у детей при плановой операции она обязательна.

Кисты и неосложнённые мукоцеле оперируют планово, обычно теми же методами функциональной риносинус-хирургии; при кистах верхнечелюстной пазухи и мукоцеле лобной пазухи иногда используют микрогайморотомию и фронтотомию через переднюю стенку.

При тяжёлом обострении хронического верхнечелюстного синусита, а при среднетяжёлом — если консервативное лечение не помогает, пазуху пунктируют, чтобы её дренировать.

Через пункцию пазуху промывают антисептиком, удаляют секрет и вводят антибиотик.

Пунктировать можно только при наличии снимков, которые исключают гипоплазию и ателектаз верхнечелюстной пазухи и показывают скопление в ней секрета.

При тяжёлом обострении пункция часто не заменяет санирующую операцию. Детям пункцию делают только в стационаре.

Для дренирования можно поставить синус-катетер или зондировать пазухи через естественные соустья.

Взрослым, которым не помогли 1–2 курса адекватной консервативной терапии, выполняют функциональную риносинус-хирургию, чтобы восстановить аэрацию пазух, убрать симптомы и предотвратить осложнения.

> Внутри КР есть расхождение: в рекомендации об операции у взрослых показанием служит неэффективность 1–2 курсов консервативной терапии, а в разделе 6 показанием к плановой госпитализации для операции названа неэффективность адекватной консервативной терапии в течение 6 месяцев.

Ребёнку с хроническим синуситом и гипертрофией аденоидов III степени, если консервативное лечение 3–6 месяцев не помогло, первым этапом удаляют аденоиды.

Операцию делают планово, если нет противопоказаний, предпочтительно под общим обезболиванием в ЛОР-отделении или стационаре кратковременного пребывания и, если есть оснащение, с эндоскопом.

Детям со среднетяжёлым и тяжёлым ХРС, если лечение 3–6 месяцев не помогло, а гипертрофия аденоидов исключена или аденоиды удалены больше 6 месяцев назад, выполняют функциональную эндоскопическую риносинус-хирургию.

Оперируют планово. Операция не мешает росту пазух и лицевого скелета, но у детей выше риск рубцов и повторного сужения, а маленькие структуры требуют современного оборудования.

Детям с изолированным поражением пазухи выполняют эндоскопическую операцию, чтобы её дренировать.

Её делают независимо от состояния аденоидов, если на КТ видно отграниченное тотальное или субтотальное затемнение одной пазухи или резкое снижение её пневматизации и есть типичные жалобы. У детей нужна онконастороженность в отношении любого образования на КТ, кроме кист с чёткими типичными признаками, которые не растут.

Кисту пазухи с постоянными или периодическими симптомами удаляют эндоскопически: опорожняют её и полностью или частично удаляют оболочку.

Случайно найденную бессимптомную кисту большинство экспертов оперировать не советуют: кисты, кроме одонтогенных, часто медленно уменьшаются сами или не меняются.

Всем пациентам с мукоцеле выполняют эндоскопическую операцию, чтобы его дренировать.

При лобной локализации лучшим методом считают эндоскопическую марсупиализацию с передней этмоидэктомией и фронтотомией по Драфу. При латеральном расположении, дефекте передней стенки лобной пазухи и большом мукоцеле, распространяющемся в полость черепа, используют наружный доступ.

4.6 Другое лечение

Пациенты со вторичным ХРС, у которых изменения в носу и пазухах — проявление другой болезни, наблюдаются и лечатся у профильного специалиста. Одонтогенные кисты верхнечелюстной пазухи лечат вместе со стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом.

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

5.1 После операции

После операции всех пациентов амбулаторно наблюдает оториноларинголог, чтобы оценить состояние полости носа и не пропустить поздние осложнения.

Первый осмотр — через 7–14 дней после выписки, затем ещё несколько раз в течение года, чтобы следить за течением болезни и вовремя менять лечение. Осмотры нужны, чтобы контролировать полость носа (при плохом уходе образуются корки и синехии), выявлять и предотвращать осложнения и при необходимости выполнять манипуляции.

Месяц после операции пациент соблюдает щадящий режим и избегает всего, что повышает давление и может вызвать кровотечение: интенсивных нагрузок, перегрева и переохлаждения. Чтобы не заразиться острой респираторной инфекцией, лучше не бывать в людных местах и больше оставаться дома.

5.2 Профилактика

Первичная профилактика защищает от вредных факторов среды, вторичная — выявляет болезнь как можно раньше. Хроническому синуситу помогают предотвратить своевременное лечение зубов и гастроэзофагеального рефлюкса, отказ от курения и техника безопасности при работе с веществами, вредными для дыхательных путей.

Мукоцеле предупреждает соблюдение принципов функциональной хирургии при операциях на носу и пазухах, лимфоэктатические кисты — своевременное лечение хронического воспаления в носу, радикулярные кисты — своевременное лечение верхних зубов.

Пациенту объясняют, что хронический синусит трудно вылечить, но его симптомы можно уменьшить; обычно нужен пожизненный контроль, а тактику определяет оториноларинголог, иногда вместе с другими специалистами.

Важно изменить образ жизни: бросить курить или хотя бы курить меньше, а при аллергии соблюдать гипоаллергенный быт. Важны и приверженность лечению, соблюдение доз, правильная техника введения лекарств и промывания.

5.3 Госпитализация

Пациентов с хроническим синуситом, кистами и мукоцеле лечит прежде всего оториноларинголог, при необходимости вместе с аллергологом-иммунологом, гастроэнтерологом, ревматологом, стоматологом-хирургом или челюстно-лицевым хирургом. Консервативное лечение и лечение лёгких обострений проводят амбулаторно.

В ЛОР-отделение экстренно госпитализируют при внутричерепных или внутриглазничных осложнениях, при тяжёлом обострении, а при среднетяжёлом — если амбулаторное лечение 5–7 дней не помогло или состояние прогрессивно ухудшается в любые сроки.

Планово для операции госпитализируют при подтверждённом хроническом синусите, не отвечающем на адекватную консервативную терапию 6 месяцев; при возврате симптомов после операции; у детей, у которых жалобы и признаки синусита сохраняются после удаления аденоидов; при изолированном воспалении с субтотальным или тотальным снижением пневматизации на КТ дольше 2 месяцев; при подозрении на новообразование пазухи неясной природы; при «синдроме молчащего синуса» верхнечелюстной пазухи на КТ; при кисте с постоянными или периодическими симптомами и при мукоцеле.

Выписывают, когда операция выполнена в нужном объёме, общее состояние удовлетворительное и нет местного или системного острого инфекционного воспаления.

5.4 Прогноз

Успех лечения зависит от анатомии носа и пазух у конкретного пациента, хронических системных болезней, активного и пассивного курения, профессиональных вредностей, климата и экологии, а также от того, насколько пациент соблюдает лечение.

Одонтогенные кисты сами не проходят, и их лечат несколько специалистов вместе.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический синусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	955_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Сроки операции у взрослых расходятся: в рекомендации о функциональной риносинус-хирургии — после 1–2 неэффективных курсов консервативной терапии, в показаниях к плановой госпитализации

(раздел 6) — после 6 месяцев неэффективной терапии.

- Классификация по тяжести (0–3, 4–7, 8–10 баллов суммарной выраженности симптомов) ссылается на приложение Г1, где описана ВАШ только для боли и с другой градацией.
- В определении симптомы должны держаться «более 12 недель», а в критериях диагноза — «12 недель и более» (≥12 недель).
- Удаление аденоидов в рекомендации названо «аденоидэктомией», а в комментарии к ней — «аденотомией».
- В комментарии об антибиотиках у детей повторяется оборот: «в случае невозможности применения при невозможности применения».
- В оглавлении разделы «Хирургическое лечение» и «Иное лечение» пронумерованы как «3.» вместо 3.2 и 3.3.

Клинические рекомендации

Хронический средний отит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.2** — Хронический серозный средний отит **H65.3** — Хронический слизистый средний отит **H65.4** — Другие хронические негнойные средние отиты **H66.1** — Хронический туботимпанальный гнойный средний отит **H66.2** — Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит **H66.3** — Другие хронические гнойные средние отиты **H72.0** — Центральная перфорация барабанной перепонки **H90.0** — Кондуктивная потеря слуха двусторонняя **H90.1** — Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.2** — Кондуктивная потеря слуха неуточненная **H90.6** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя **H90.7** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя, с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.8** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 29.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/698_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Основное лечение хронического гнойного среднего отита — хирургическое, и любой такой пациент — потенциальный кандидат на операцию. Оперируют в ремиссии, не раньше чем через 3–6 месяцев после последнего обострения.
- При диагностике всем делают тональную пороговую аудиометрию: она определяет степень и вид тугоухости и позволяет прогнозировать результат операции. Если пороги костной проводимости на разговорных частотах выше 30 дБ, качественного улучшения слуха не стоит ждать даже после безупречной операции.
- При подозрении на холестеатому или её рецидив назначают МРТ височных костей: в режимах T1, T2 и диффузионно-взвешенных изображениях она отличает холестеатому от секрета, грануляций и холестероловой гранулемы.
- В консервативном лечении главную роль играют местные средства — антисептики, ушные капли с противомикробными препаратами и кортикостероидами; топические фторхинолоны не ототоксичны и подходят при перфорации. Местное лечение работает только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.
- Неоперированных пациентов осматривают раз в 6 месяцев, а после тимпанопластики или санирующей операции — раз в год не меньше 5 лет, чтобы не пропустить рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) — хроническое воспаление полостей среднего уха со стойкой перфорацией барабанной перепонки, постоянным или периодическим гноетечением из уха и прогрессирующим снижением слуха дольше 3 месяцев.

Мукозит — хроническое катаральное воспаление слизистой среднего уха. Тимпаносклероз — необратимый исход неспецифического воспаления с тугоухостью из-за фиксации звукопроводящей цепи. Тимпанофиброз — незаконченный процесс, при котором фиброзирование в барабанной полости преобладает над воспалением. Холестеатома — белесовато-перламутровое эпидермальное образование с оболочкой (матриксом), покрытой многослойным плоским эпителием; матрикс плотно прилежит к кости и нередко врастает в неё.

2.2 Причины

У взрослых ХГСО развивается на фоне хронических болезней полости носа, околоносовых пазух и носоглотки, после перенесённых острых средних отитов, при системной и специфической патологии. Запускает процесс обычно острый средний отит, после которого остаётся стойкая перфорация или ретракция с атрофичной неомембраной, а также травматическая или ятрогенная перфорация: после врачебных манипуляций она сохраняется у 1,3–10,8% пациентов.

Хронизации способствуют анатомические особенности среднего уха и слуховой трубы, неадекватная антибактериальная терапия острого отита без дренирования среднего уха, устойчивые штаммы возбудителей, ретракция после острого отита, экссудативный средний отит, ослабление местной иммунной защиты, а также болезни носоглотки и носа, нарушающие мукоцилиарный клиренс слуховой трубы.

Главный возбудитель среди аэробов — синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), второй по значимости — золотистый стафилококк. Из анаэробов чаще высевают пептококки и пептострептококки, реже бактероиды; анаэробы чаще сопутствуют холестеатоме. В 1,4–20% случаев флора грибковая, обычно Aspergillus и Candida.

2.3 Классификация

По МКБ-10 различают две формы ХГСО: мезотимпанит (туботимпанальный отит) и эпитимпанит (эпитимпано-антральный отит). При мезотимпаните поражается в основном слизистая мезо- и гипотимпанума, при эпитимпаните процесс из эпитимпанума распространяется в клетки сосцевидного отростка и поражает костные структуры среднего уха.

По клинико-морфологической классификации хронический средний отит бывает неперфоративным — экссудативным, адгезивным (рубцовым), с тимпаносклерозом или тимпанофиброзом — и перфоративным: сухим, с мукозитом, с тимпаносклерозом или с холестеатомой.

Место перфорации отражает только преимущественную локализацию воспаления и не говорит о том, что происходит в среднем ухе: даже при мезотимпаните цепь слуховых косточек разрушена у 10–22%, а холестеатома в барабанной полости есть у 11,6–42% пациентов. Поэтому для планирования операции эти изменения нужно диагностировать.

По классификации Европейской академии отологии и нейроотологии и Японского отологического общества (EAONO/JOS) различают 4 типа холестеатомы — врождённую, ненатянутой части, натянутой части перепонки и вторичную при перфорации натянутой части — и 4 стадии: 1 — в одном регионе, 2 — в двух и более, 3 — с внечерепным осложнением, 4 — с внутричерепным. Регионы обозначают по системе STAM: труднодоступные зоны (надтубарный и тимпанальный синусы), барабанная полость, аттик и сосцевидный отросток.

2.4 Клиническая картина

Пациенты жалуются на снижение слуха и шум в ухе; при осмотре видна перфорация барабанной перепонки с выделениями или холестеатомой.

Мезотимпанит — форма с перфорацией в натянутой части барабанной перепонки, встречается у 48–69% больных ХГСО. Её считают относительно благоприятной, потому что признаков активной остеодеструкции нет.

Эпитимпанит встречается у 15–19% больных: перфорация находится в ненатянутой части перепонки, в среднем ухе идёт кариозный процесс, который может привести к лабиринтным и внутричерепным осложнениям. Кость в 79–97% случаев разрушает холестеатома. Ретракционный карман считают начальной стадией холестеатомы: в 80% случаев она развивается именно из него.

При эпимезотимпаните, который выявляют у 17–33% пациентов, есть признаки обеих форм.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по совокупности жалоб, анамнеза, осмотра, лабораторных и инструментальных исследований.

3.1 Жалобы и анамнез

Пациента расспрашивают, снижен ли слух на одно или оба уха.

Снижение слуха отмечают 93–99% пациентов, чаще с двух сторон. При долгом течении, когда формируются тимпаносклероз, тимпанофиброз и ретракционный карман, тугоухость становится выраженной.

Уточняют, как долго, как часто и какие бывают выделения из уха.

Оторея — вторая по значимости жалоба, она бывает у 76–100% пациентов. Около половины отмечают выделения 1–2 раза в год после переохлаждения, попадания воды в ухо или ОРЗ, почти треть — частые или постоянные выделения в последние годы. Выделения бывают от скудных слизистых до гнойных с ихорозным запахом.

Редкие обострения при выраженной тугоухости характерны для тимпаносклероза, тимпанофиброза и холестеатомы, постоянные выделения — для мукозита, гнойные выделения с неприятным запахом — для холестеатомы. Эпитимпанит опасен тем, что долго протекает бессимптомно.

Спрашивают о шуме в одном или обоих ушах.

Шум беспокоит 19–48% пациентов. Низкочастотный шум обычно связан с дефектом перепонки, высокочастотный — с поражением внутреннего уха. При тимпаносклерозе и тимпанофиброзе шум усиливается.

Спрашивают о заложенности, ощущении жидкости и дискомфорте в ухе.

Такие жалобы чаще бывают, когда натянутая часть барабанной перепонки сохранена.

Спрашивают о головокружении в прошлом.

Системное головокружение или неустойчивость бывают у 10–27% больных с холестеатомой — при обострении, нагрузке, наклонах и поворотах головы. В половине случаев это говорит о фистуле лабиринта. Если разрушена стенка канала лицевого нерва, возможен его парез.

Спрашивают о головной боли.

Головная боль разной локализации часто появляется при обострении. Для неосложнённого эпитимпанита боль в ухе и головная боль не характерны: обычно они означают, что возникло осложнение.

3.2 Осмотр

Всем выполняют отоскопию или видеоотоскопию: при ХГСО это определяющий метод диагностики вместе с отоэндоскопией.

Оценивают барабанную перепонку (тонкая, толстая, рубцовая, очаги тимпаносклероза), ретракционные карманы и их глубину, размер и место перфорации и её края, слизистую барабанной полости (мукозит, тимпаносклероз, полипы, грануляции, эпидермизация), видимые слуховые косточки (кариес, лизис), латеральную стенку аттика и адитус.

3.3 Степени мукозита при осмотре

Степень	Что видно
I	Слизистая медиальной стенки барабанной полости утолщена, свободного отделяемого нет
II	Подушкообразное утолщение слизистой медиальной стенки с большим количеством слизистых желёз и скудным слизистым отделяемым
III	Выраженная полиповидная гиперплазия слизистой мезогипотимпанума со слизистым отделяемым

Отоэндоскопия позволяет увидеть холестеатому в 61% случаев. При эпитимпаните перфорация бывает точечной, видна только при продувании, прикрыта серной коркой или временно отсутствует в стойкой ремиссии — тогда внимательно осматривают латеральную стенку аттика в поисках даже минимальной деструкции. Иногда болезнь маскируется под рецидивирующий экссудативный отит, а за прозрачным экссудатом виден холестеатомный мешок при небольшом ретракционном кармане в ненатянутой части. Глубокие карманы осматривают эндоскопами с углом обзора 0°, 30° и 70°.

Фистулу лабиринта помогает распознать фистульная проба.

Проходимость слуховой трубы проверяют пустым глотком, пробой Тойнби, приёмом Вальсальвы или продуванием баллоном Политцера. Чем сильнее мукозит, тем хуже вентиляционная и дренажная функции трубы. Дисфункция трубы может объяснять ретракцию перепонки до операции и в отдалённом послеоперационном периоде, её учитывают при хирургии и реабилитации. Если при хроническом серозном отите с трубой всё в порядке, нужно заподозрить спонтанную отоликворею.

Оценивают полость носа, околоносовые пазухи и носоглотку: искривление перегородки, гипертрофический ринит, хронические болезни пазух и носоглотки нарушают функцию слуховых труб и снижают эффективность лечения.

3.4 Слух: камертоны и аудиометрия

При подозрении на снижение слуха исследуют слух камертонами.

Количественные (камертоны С128–2048) и качественные (С128–512) пробы Ринне, Федериче и Вебера — скрининг, который показывает вид тугоухости, кондуктивной или сенсоневральной, и хуже слышащее ухо. По ним составляют слуховой паспорт; они же служат показанием к тональной пороговой аудиометрии.

При диагностике ХГСО выполняют тональную пороговую аудиометрию (ТПА).

ТПА точно определяет степень и вид тугоухости — кондуктивную, смешанную или нейросенсорную — и возможности реабилитации, позволяет прогнозировать результат операции и следить за ним в отдалённом периоде. Если пороги костной проводимости выше 30 дБ в диапазоне разговорных частот, качественного улучшения слуха нельзя ожидать даже после идеально выполненной операции. Динамику лучше оценивать на одном и том же аудиометре и одному и тому же исследователю.

Для ХГСО характерна кондуктивная и смешанная тугоухость; её степень зависит от дефекта перепонки, целости и подвижности цепи слуховых косточек и токсического действия воспаления на внутреннее ухо. Глухота при ХГСО часто связана с фистулой лабиринта из-за разрушения кости холестеатомой.

По аудиограмме холестеатому не распознать: костно-воздушный интервал не коррелирует с вариантом разрушения цепи, а холестеатома и грануляции сами могут проводить звук к внутреннему уху.

3.5 Лучевая диагностика

При ХГСО без холестеатомы для оценки сосцевидного отростка можно сделать рентгенографию височных костей в укладках по Шюллеру и Майеру.

Её делают, только если нет подозрения на холестеатому и осложнённого течения.

Пациентам с ХГСО выполняют компьютерную томографию (КТ) височных костей, чтобы оценить их структуры.

КТ — метод первичной диагностики. Она показывает распространённость процесса и анатомические особенности — низкое стояние дна средней черепной ямки, высокое стояние луковицы яремной вены, предлежание сигмовидного синуса, дегисценции лицевого канала и лабиринта, перегородку Кёрнера, — а также стенки барабанной полости и антромастоидального отдела, цепь косточек, слизистую и узкие пространства барабанной полости. Исследование проводят в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией; идеальная толщина среза — 0,5–0,8 мм.

КТ выявляет признаки ХГСО в 99% случаев, деструкцию стенок среднего уха — в 55–97%. Отличить холестеатому от фиброза, грануляций, экссудата и гноя по плотности нельзя: у всех она от +30 до +40 HU. Заподозрить холестеатому в 88% случаев позволяют расположение образования, разрушение стенок барабанной полости, косточек и антромастоидальной области, расширение входа в антрум, разрушение латеральной стенки аттика или адитуса, дефект задней стенки слухового прохода, разрушение лицевого канала и фистула лабиринта, чаще горизонтального полукружного канала.

При ХГСО без холестеатомы на КТ видны изменения слизистой, рубцы вокруг цепи косточек, иногда её дефект — чаще из-за лизиса длинной ножки наковальни. Антрум при мезотимпаните в ремиссии обычно пневматизирован, сосцевидный отросток, как правило, компактный, склеротический.

Оперированное ухо КТ оценивает плохо: рубцы, грануляции и пластический аутоматериал по плотности не отличаются от холестеатомы. Заподозрить её можно только по росту «подозрительного» образования в динамике.

Чтобы объективно оценить распространённость процесса, КТ делают не раньше чем через 3–6 месяцев после обострения. КТ в период обострения необоснованно расширяет объём операции и оправдана только при осложнённом течении.

При подозрении на холестеатому или её рецидив выполняют магнитно-резонансную томографию (МРТ) височных костей.

В режимах T1, T2, EPI DWI и non-EPI DWI МРТ надёжно выявляет холестеатому и её рецидив после операции: чувствительность 77–100%, специфичность 86–100%. За холестеатому говорят низкий сигнал в T1 и высокий или средний — в T2 и non-EPI DWI. На точность влияет размер холестеатомы; для поиска рецидива МРТ выгоднее ревизионной операции и служит ей альтернативой.

Некоторые авторы для поиска холестеатомы советуют сочетать или совмещать КТ и МРТ: чувствительность тогда 96%, специфичность 100%.

При ХГСО с холестеатомой, осложнённой фистулой лабиринта, проводят вестибулометрию.

Её назначают при системном головокружении, неустойчивости и признаках фистулы. Если фистулу найти до операции, можно предупредить послеоперационные кохлеовестибулярные расстройства.

3.6 Лабораторные исследования

Общие лабораторные анализы выполняют при подготовке к плановой операции.

Отделяемое из уха сеют на аэробную и факультативно-анаэробную флору и определяют чувствительность к антимикробным препаратам.

Посев нужен при любом ХГСО, чтобы подобрать этиотропную терапию.

При подозрении на грибковый процесс отделяемое из ушей сеют на дрожжевые и мицелиальные грибы.

Удалённые ткани уха исследуют цитологически и патоморфологически.

Патоморфологическое исследование делают всякий раз, когда удаляют патологическую ткань. При атипичном воспалении спектр анализов расширяют, чтобы исключить туберкулёз и гранулематоз Вегенера; если ответа нет, а стандартное лечение не помогает, исследования повторяют через 3 месяца.

3.7 Консультации

При сопутствующих болезнях и подозрении на осложнение пациента консультируют невролог, нейрохирург и терапевт.

При атипичном воспалении и осложнениях могут понадобиться также фтизиатр и ревматолог.

---

4. Лечение

Цель лечения — санировать среднее ухо, чтобы добиться стойкой ремиссии и предупредить осложнения и тугоухость.

4.1 Консервативное лечение

Консервативную терапию проводят при обострении и для подготовки к операции при неосложнённом течении.

Её назначают при обострении, чтобы добиться ремиссии перед операцией, и в раннем периоде после санирующей операции. Она включает бета-лактамные антибиотики, анальгетики, кортикостероиды и процедуры для улучшения функции слуховой трубы.
При неосложнённом течении лечат амбулаторно, при осложнённом — в стационаре. Как основное лечение консервативная терапия носит паллиативный характер и оправдана только у пациентов с тяжёлыми сопутствующими болезнями при регулярном наблюдении.

При сухом перфоративном среднем отите никакого лечения не проводят.

> Расхождение в КР: в разделе 3.1 сказано, что при сухом перфоративном отите лечения не проводят, а в разделе 3.2 — что при перфорации без возможности улучшить слух тимпанопластику нужно выполнять, чтобы предупредить рецидивы, и что лучшие результаты тимпанопластики бывают именно при сухих перфорациях. В алгоритме (приложение Б) от сухого перфоративного отита стрелки ведут к лечению. Вероятно, запрет относится только к консервативной терапии.

Антибиотик выбирают с учётом флоры, её чувствительности и способности препарата проникать через гематоэнцефалический барьер. Препараты выбора — бета-лактамы (пенициллины и другие бета-лактамные антибиотики), в некоторых случаях — респираторные фторхинолоны.

Системные препараты назначают, как правило, при выраженном обострении и при тяжёлых распространённых деструктивных формах. Периоперационная антибиотикопрофилактика должна соответствовать характеру и объёму операции.

При смешанной флоре КР советует сочетать 2–3 препарата, например цефалоспорины и фторхинолоны. Возможно сочетание местных противомикробных препаратов с противогрибковыми.

Главная роль в лечении принадлежит местным средствам: антисептикам, ушным противомикробным препаратам, местным противогрибковым средствам и кортикостероидам в комбинации с противомикробными. Самые эффективные и безопасные — топические фторхинолоны: к ним чувствительны 75,6% возбудителей, они не ототоксичны и подходят при перфорации. Местное лечение действует только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.

Грануляции в барабанной полости по возможности удаляют или прижигают соединениями серебра; они хорошо регрессируют и под действием топических кортикостероидов.

Кортикостероиды в каплях или в комбинированных препаратах назначают при вялотекущем воспалении слизистой (мукозите). Если местное лечение не помогает 1–3 месяца, что характерно для мукозита, выполняют операцию с дренированием.

При холестеатоме местно эффективны препараты борной кислоты: кроме антисептического действия, они подсушивают ткани и этим уменьшают воспаление.

При грибковой флоре противомикробные препараты и кортикостероиды в каплях противопоказаны. Таких пациентов ведут строго по алгоритмам применения местных противогрибковых средств; лечение часто долгое и требует участия миколога.

> Расхождение в КР: абзацем выше КР допускает сочетать противомикробные ушные препараты с противогрибковыми, а здесь при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны. Кроме того, «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом АТХ D01A, который относится к противогрибковым препаратам.

Дисфункцию слуховой трубы лечат по порядку. Сначала устраняют болезни носа и носоглотки — от деконгестантов и назальных кортикостероидов до операции. Затем улучшают проходимость трубы продуванием по Политцеру или курсом катетеризаций с введением лекарств. Наконец, налаживают её самостоятельное открытие и закрытие специальной гимнастикой или электростимуляцией мышц трубы.

4.2 Хирургическое лечение

Основное лечение ХГСО — хирургическое: только операция позволяет полностью санировать ухо и улучшить качество жизни, поэтому любой пациент с ХГСО — потенциальный кандидат на неё. Оперируют в ремиссии, не раньше чем через 3–6 месяцев после последнего обострения: так операция меньше по объёму, безопаснее и эффективнее.

Вынужденная операция при обострении или осложнении — это только санация среднего уха открытого типа, при внутричерепных осложнениях расширенная; из-за кровоточивости тканей она технически сложна и чаще даёт ятрогенные осложнения. Пациентов с осложнениями оперируют в ургентных отделениях, вне обострения — в специализированных отделениях и центрах, где владеют реконструктивной хирургией среднего уха. Ранняя операция на «сухом ухе» лучше санирует очаг, сохраняет слух и анатомию и сокращает реабилитацию.

При ХГСО с мукозитом II и III степени выполняют дренирующие операции.

Методику выбирают индивидуально: по форме ХГСО и распространённости процесса, анатомии височной кости, степени тугоухости, состоянию слуховой трубы, осложнениям и опыту хирурга.

Чтобы санировать среднее ухо и улучшить слух, выполняют тимпанопластику.

При мезотимпаните делают тимпанопластику разных типов и миринготомию в зависимости от разрушения цепи косточек, используя протезы из хряща, наковальни, кортикальной кости, титана и аутоматериалы для пластики перепонки. Доступ — через слуховой проход, эндауральный или заушный, под местной анестезией или наркозом, под эндоскопом или микроскопом, в один или два этапа.
Результат зависит от времени после последнего обострения, изменений в среднем ухе, места и размера перфорации, функции слуховой трубы и состояния слизистой, способа реконструкции, опыта хирурга и послеоперационного ведения. Обязательное условие успешной тимпанопластики — отсутствие выделений минимум 3–6 месяцев.

Тимпанопластика эффективна в 43–98% случаев; риск глухоты оперированного уха — 1–2%. Лучшие результаты, у 93,3%, бывают при сухих перфорациях, независимо от техники укладки трансплантата.

Мастоидотомия при тимпанопластике у пациентов без холестеатомы не улучшает ни анатомический результат, ни аэрацию сосцевидного отростка, но увеличивает объём и риск операции. Обязательной её считают при вялотекущем хроническом перфоративном отите без холестеатомы, если системные и местные антибиотики не помогли.

Эндоскоп как дополнение к микроскопу улучшает обзор барабанной полости, но преимущества операций только под эндоскопом перед микроскопом по данным систематического обзора не доказаны.

При тотальных и субтотальных дефектах перепонки с изменённой слизистой большинство хирургов сочетают аутофасцию, аутохрящ и кожные трансплантаты, чтобы не было реперфорации. Тонкие пластинки аутохряща препятствуют ретракции и не ухудшают акустику.

При мукозите тимпанопластика оправдана: после восстановления функции трубы и аэрации утолщённая слизистая становится нормальной. Слизистую удаляют инструментами или лазером. При выраженном мукозите лучше результаты, если оставить дренажную трубку под меатальным лоскутом или вскрыть антрум и дренировать через него барабанную полость до 2 недель.

Второй этап тимпанопластики выполняют через 8–12 месяцев. Если перфорация есть, а слух улучшить нельзя, тимпанопластику всё равно делают, чтобы предупредить рецидивы ХГСО.

Искусственные протезы и аутопротезы при оссикулопластике по слуху не различаются, но искусственный протез без прикрытия аутохрящом смещается в 6 раз чаще.

4.3 Холестеатома: санирующие операции

При ХГСО с холестеатомой выполняют санирующие операции.

Главный принцип — удалить холестеатому полностью и устранить причины рецидива.

При эпитимпаните и эпимезотимпаните с холестеатомой в зависимости от распространённости выполняют «открытые», «полуоткрытые» или «закрытые» санирующие операции с тимпанопластикой или без неё. Из-за объёма и длительности их делают под общей анестезией.

Если холестеатома ограничена аттиком или аттиком и адитусом, можно ограничиться аттикотомией через слуховой проход, но обязательно тщательно убрать процесс из синусов и карманов среднего уха.

«Открытая» техника (с удалением задней стенки слухового прохода) избавляет от повторных операций, но не от регулярного ухода за полостью у оториноларинголога. После «закрытой» обязательна ревизия через 8–12 месяцев или МРТ для исключения рецидива. «Закрытые» операции опаснее внутричерепными осложнениями, поэтому, если постоянное наблюдение после операции невозможно, предпочтительна «открытая» методика.

«Закрытые» методики (аттикоадитотомия, аттикоантротомия, раздельная антромастоидотомия) предпочтительны при ограниченной холестеатоме, «открытые» (модифицированная радикальная, консервативно-радикальная, общеполостная операция, антромастоидотомия с удалением задней стенки, радикальная мастоидэктомия) — при распространённой деструкции, активной холестеатоме или вялотекущем обострении.

Современная тенденция — «полуоткрытая» (гибридная) техника: аттикоантро- или мастоидотомия с облитерацией антрума и сосцевидного отростка аутотканями или инертными материалами и тимпанопластикой. Анатомия уха остаётся близкой к исходной, болезни послеоперационной полости нет, и пожизненное наблюдение не нужно.

> Неточность в КР: частота рецидивов холестеатомы напечатана с ошибками — «у 342%» после «закрытой» и «у 712%» после «открытой» техники, видимо, потеряно тире в диапазонах. Сразу после этого сказано, что при «открытой» технике рецидивов меньше, но «эта техника» повышает риск рецидива в 2,9 раза по сравнению с «закрытой» и поэтому рекомендуется только при повторных операциях. По приведённым цифрам чаще рецидивирует «закрытая» техника, так что фраза противоречива.

Если после «закрытой» операции найден рецидив холестеатомы, объём операции расширяют до антромастоидотомии с удалением задней стенки слухового прохода и формированием открытой полости.

После операции слуховой проход тампонируют с противомикробными препаратами: после тимпанопластики на 10–14 дней, после санирующей операции — на 14–21 день; дополнительно воздействуют на слуховую трубу и слизистую лекарствами и физиотерапией. Важно и квалифицированное наблюдение в отдалённом периоде.

4.4 Слухопротезирование

Если слух асоциальный (тугоухость больше II степени) и улучшить его нельзя, проводят электроакустическую реабилитацию.

Слухопротезирование показано при порогах костной проводимости выше 30 дБ на оба уха, в том числе в отдалённом периоде после операции.

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациентов, которым операция противопоказана, отложена или которые от неё отказались, наблюдает специалист поликлиники раз в 6 месяцев, а при обострении назначает консервативное лечение.

После тимпанопластики и санирующих операций пациент раз в год приходит к врачу поликлиники и к отохирургу клиники, где его оперировали, не меньше 5 лет после операции. Цель — вовремя найти рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

Для профилактики обострений санируют нос и носоглотку, объясняют пациенту характер болезни, учат беречь ухо от воды и предупреждать обострения при ОРЗ и своевременно обращаться к врачу поликлиники и в клинику, где была операция.

После операции, в зависимости от методики, назначают постельный режим с положением на противоположном ухе. Месяц нужно избегать физических нагрузок, 3 месяца — авиаперелётов, а ухо беречь от воды до конца реабилитации.

5.1 Госпитализация и выписка

Пациента первично осматривают оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

Экстренно госпитализируют при обострении ХГСО с внечерепными или внутричерепными осложнениями.

Планово госпитализируют для операции при ХГСО, в том числе с холестеатомой, в стадии вялотекущего воспаления или ремиссии не меньше 3–6 месяцев. Показания — снижение слуха с шумом в ухе, снижение слуха со скудными выделениями, которые не проходят от консервативного лечения, или любые клинические проявления ХГСО независимо от вида тугоухости, если нет общих противопоказаний и пациент обследован по требованиям стационара.

После экстренной госпитализации выписывают, когда угрозы жизни нет и жизнедеятельность восстановлена, после плановой — в зависимости от объёма операции и самочувствия: на 3–5-й день после окончания противовоспалительной и симптоматической терапии, с тампонами в слуховом проходе. Тампоны удаляют амбулаторно через 2–3 недели, а слух по ТПА проверяют амбулаторно через 3 и 12 месяцев.

Эффективность лечения оценивают по жалобам на снижение слуха и выделения, по отоэндоскопии (закрылась ли перфорация, нет ли отореи, эпидермизирована ли полость), по ТПА, по КТ или МРТ (санировано ли ухо, нет ли деструкции и холестеатомы) и по вестибулометрии при фистуле лабиринта.

ХГСО ведёт к прогрессирующей тугоухости и осложнениям: лабиринтиту, периферическому парезу лицевого нерва, менингиту, абсцессу мозга и тромбозу сигмовидного синуса.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический средний отит»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 29.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	698_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- При сухом перфоративном среднем отите раздел 3.1 запрещает любое лечение, а раздел 3.2 и алгоритм в приложении Б предусматривают при перфорации тимпанопластику.
- Сочетание противомикробных ушных препаратов с противогрибковыми допускается, но при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны; «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом противогрибковых препаратов D01A.
- Частота рецидивов холестеатомы напечатана с ошибками («у 342%», «у 712%», «4,28,4%»), а вывод о том, что «открытая» техника повышает риск рецидива в 2,9 раза, противоречит приведённым цифрам.
- Сроки тампонады после операции различаются: в разделе 3.2 — 10–14 дней после тимпанопластики и 14–21 день после санирующей операции, в разделе 6 — удаление тампонов через 2–3 недели.
- Название и коды МКБ охватывают и негнойные формы (H65.2–H65.4), но определение и весь текст КР посвящены только хроническому гнойному среднему отиту.
- В рекомендации о дренирующих операциях мукозит разделён на «стадии», хотя при осмотре описаны его «степени».
- В критериях качества у консервативного лечения указан УДД 4, а в самой рекомендации — УДД 5; критерия «хирургическое лечение при неэффективности консервативной терапии» в рекомендациях нет, по тексту КР операция — основное лечение.
- В оглавлении PDF номера страниц многих разделов искажены («100», «133», «232» и т. п.).

Клинические рекомендации

Хронический тонзиллит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.2** — Хронический фарингит **J35.0** — Хронический тонзиллит **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов **J35.9** — Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/683_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

1. Главное

- Диагноз ставят по фарингоскопии: решают местные признаки хронического воспаления миндалин, и важнее всего жидкий гной в лакунах. Размер миндалин для диагноза значения не имеет.
- Во время острого воспаления глотки хронический тонзиллит не диагностируют: признаки можно достоверно оценить только через 3–4 недели после него.
- По классификации Солдатова тонзиллит бывает компенсированным и декомпенсированным; форму определяют по анамнезу за последние три года.
- Консервативное лечение проводят курсами между обострениями: при компенсированной форме 2 раза в год, весной и осенью, при рецидивах ангин — до 4 раз в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемого обострения.
- Тонзиллэктомия показана при любой декомпенсации, а при рецидивирующих ангинах — если противорецидивное лечение не помогло.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Хронический тонзиллит — инфекционно-аллергическое заболевание всего организма с местными проявлениями: стойким воспалением нёбных миндалин с альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

2.2 Местные признаки

Выделяют пять групп местных признаков: гиперемия и валикообразное утолщение краёв нёбных дужек; рубцовые спайки между миндалинами и дужками; разрыхлённые или, наоборот, рубцово изменённые и уплотнённые миндалины; казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в лакунах; увеличенные регионарные лимфоузлы.

Признак Гизе — гиперемия краёв передних дужек. Признак Зака — отёк в месте соединения передних и задних дужек. Признак Преображенского — валикообразное утолщение краёв верхних отделов передних и задних дужек.

2.3 Классификация Солдатова

При компенсированной форме местные признаки видны, а общих симптомов почти или совсем нет. При декомпенсированной к местным признакам добавляется хотя бы один вид декомпенсации: рецидивы ангин; паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс; тонзиллогенная интоксикация — долгий субфебрилитет, недомогание, снижение трудоспособности без другой причины; тонзиллогенные функциональные нарушения внутренних органов; заболевания органов, связанные с тонзиллитом. Форму определяют по анамнезу за последние три года.

2.4 Классификация Преображенского — Пальчуна

При простой форме есть только местные признаки, и почти всегда в анамнезе были ангины.

При токсико-аллергической форме I степени периодически бывают субфебрилитет, слабость, быстрая утомляемость, боли в суставах, увеличенные и болезненные регионарные лимфоузлы, непостоянные функциональные нарушения со стороны сердца и нестойкие отклонения в анализах.

При II степени функциональные нарушения сердца подтверждаются на ЭКГ, бывают сердцебиение и нарушения ритма, боли в сердце и суставах во время ангины и вне её, функциональные нарушения почек, печени, суставов и сосудов, а также связанные с тонзиллитом болезни: паратонзиллярный абсцесс, парафарингит, тонзиллогенный сепсис, ревматизм, артрит, приобретённые пороки сердца, гломерулонефрит.

Описано около 100 болезней, связанных с хроническим тонзиллитом; чаще всего страдают сердце, суставы, почки, эндокринная система и кожа. В трудных случаях тактику выбирают вместе с профильным специалистом.

2.5 Жалобы и анамнез

Пациенты могут жаловаться на несильную боль, першение, ощущение инородного тела в горле, периодический сухой кашель и неприятный запах изо рта. Эти жалобы неспецифичны — они бывают и при хроническом фарингите, болезнях гортани, полости рта и зубов, — а у части пациентов их нет вовсе.

При декомпенсированной форме бывают общие жалобы: долгое недомогание, снижение работоспособности, затяжной субфебрилитет. Они тоже неспецифичны, поэтому нужно обследование, чтобы исключить другие причины.

У детей и взрослых, особенно часто и долго болеющих, выясняют местные и общие жалобы и уточняют, как часто были ангины. Ангины в анамнезе многие авторы считают самым надёжным признаком хронического тонзиллита, но сведения о них должны быть подтверждены.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу (ангины, долгая утомляемость, субфебрилитет, регионарный лимфаденит, болезни, связанные с тонзиллитом), осмотру, лабораторным данным и фарингоскопии.

3.1 Осмотр

Фарингоскопию проводят детям и взрослым, чтобы исключить острый тонзиллит и найти местные признаки хронического.

Пока есть острое воспаление глотки, хронический тонзиллит не диагностируют: его признаки можно достоверно оценить только через 3–4 недели.

Всем проводят осмотр верхних дыхательных путей с хорошим освещением, шпателем и зеркалами, фарингоскопию и эпифарингоскопию.

Решающее значение имеют фарингоскопические признаки, и важнее всего жидкий гной в лакунах, часто с неприятным запахом. Увеличение лимфоузлов может быть вызвано и другими воспалительными процессами головы и шеи. Размер миндалин для диагноза значения не имеет.

Осматривают при ярком направленном свете двумя шпателями, при необходимости зондом. За 20–30 минут до осмотра пациенту не стоит есть, пить горячее, холодное и газированное, курить и разговаривать на холоде, чтобы не было преходящей гиперемии. Вторым шпателем надавливают на дужку, чтобы увидеть содержимое лакун и спайки.

3.2 Анализы

Общий анализ крови и мочи, СРБ и ревматоидный фактор назначают, чтобы выявить связанное с тонзиллитом заболевание.

Антистрептолизин-О (АСЛ-О) определяют, чтобы отличить активную стрептококковую инфекцию от носительства.

Высокий АСЛ-О без стрептококка в посевах говорит о возможной внутриклеточной персистенции и считается подтверждением декомпенсации. Но высокий АСЛ-О без симптомов со стороны миндалин сам по себе не повод для лечения.

Возраст	Норма АСЛ-О, МЕ/мл
До 7 лет	до 100
7–14 лет	150–200
С 14 лет	до 250

Отделяемое с нёбных миндалин сеют на бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) или делают экспресс-тест.

Анализы крови и мочи, посевы и цитология содержимого лакун для самого диагноза значения почти не имеют. Они нужны, чтобы уточнить форму, роль микрофлоры, связь с болезнями других органов и эффект лечения.

Лазерная допплеровская флоуметрия, УЗИ и другие дополнительные методы пока не получили распространения, доказательств их эффективности нет.

---

4. Лечение

Хронический тонзиллит лечат между обострениями. Ангину лечат по рекомендациям по острому тонзиллофарингиту, а паратонзиллит и абсцесс — по рекомендациям по этим заболеваниям.

Перед любым лечением проверяют зубы, околоносовые пазухи и носоглотку и при необходимости санируют их.

4.1 Консервативное лечение

Консервативное лечение показано при компенсированной и простой форме — курсами 2 раза в год, весной и осенью. При декомпенсации в виде рецидивов ангин и при токсико-аллергической форме I степени — до 4 курсов в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемой ангины. При других видах декомпенсации и токсико-аллергической форме II степени — если операция противопоказана.

Лечение помогает, только если лакуны дренируются, а складки и карманы очищаются от экссудата и детрита.

Системные антибиотики назначают при обострении, если выделен стрептококк или появляются признаки осложнений, — это пенициллины. Вне обострения, при функциональных нарушениях внутренних органов, отрицательных посевах на БГСА и стойко высоком АСЛ-О, предпочтение отдают 14-членным макролидам, курсом до 2 недель.

Нужны ли антибиотики между обострениями, специалисты спорят, поэтому решение принимают индивидуально, по объективным данным и динамике симптомов и анализов.

Если подтверждена грибковая природа, назначают противогрибковые препараты внутрь с учётом чувствительности.

Между обострениями курсами назначают растительные препараты с корнем алтея, цветками ромашки, травой тысячелистника, корой дуба, травой хвоща и корнем одуванчика, чтобы реже были ангины.

4.2 Местное лечение

Между обострениями промывают лакуны миндалин: курс из 10 процедур ежедневно или через день. Промывать можно не раньше чем через 2–3 недели после острого воспаления.

Промывают стерильным раствором натрия хлорида или растворами антисептиков, соблюдая дозы и возрастные ограничения и помня об аллергии на препараты йода. Смазывание миндалин курсом 10–15 процедур проводят отдельно или сразу после промывания.

Детям дошкольного и младшего школьного возраста миндалины не промывают и не смазывают из-за риска рефлекторного ларингоспазма.

Назначают антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций и таблеток для рассасывания.

Взрослым при обострении назначают НПВП для местного применения.

Топические бактериальные лизаты в таблетках для рассасывания уменьшают число и длительность обострений.

В ремиссии пациента консультирует физиотерапевт; перед физиотерапией проводят курс промываний.

4.3 Тонзиллэктомия

Двустороннюю тонзиллэктомию делают между обострениями, чтобы радикально убрать очаг инфекции.

По классификации Солдатова операция показана при любой декомпенсации, кроме рецидивов ангин, если противорецидивное лечение не проводилось. При рецидивах ангин — если консервативное лечение не помогло и ангины продолжаются или появился другой вид декомпенсации.

По классификации Преображенского — Пальчуна — при токсико-аллергической форме II степени, а также при простой форме и форме I степени, если 2–3 тщательных курса консервативного лечения в год не помогли.

Детям операция показана при частых стрептококковых ангинах (не меньше 7 за последний год, не меньше 5 в год за последние 2 года или не меньше 3 в год за последние 3 года), при двух паратонзиллярных абсцессах и больше (иногда и после одного) и по заключению профильных специалистов, если операция нужна для лечения сопутствующей болезни.

Критерии Paradise: тонзиллэктомию рассматривают при 7 эпизодах боли в горле за год, 5 в каждом из двух лет или 3 в каждом из трёх лет. Эпизодом считается боль в горле хотя бы с одним признаком: температура 38,3 °C и выше, экссудат на миндалинах, шейные лимфоузлы больше 2 см и болезненные, БГСА в посеве или положительный экспресс-тест.

Абсолютные противопоказания: болезни крови (гемофилия, лейкозы, геморрагические диатезы), аномальные сосуды глотки (пульсация боковой стенки), тяжёлая сердечная недостаточность II–III степени, выраженная почечная недостаточность, тяжёлый сахарный диабет с кетонурией, тяжёлые болезни печени, тяжёлые нервно-психические болезни, злокачественные опухоли, активный туберкулёз.

Относительные противопоказания: острые инфекции и 3–4 недели после них, острые воспаления и обострения хронических, в том числе ЛОР-органов, эпидемии гриппа, менструация, неактивный туберкулёз, преходящая тромбоцитопения, нетяжёлый сахарный диабет, кариозные зубы.

Самое частое осложнение — кровотечение из ниши миндалины во время операции или в первые 5–7 дней, но оно возможно и на 8–15-е сутки. Поэтому первые 5–7 дней пациент лежит в стационаре, а после выписки ещё 5–7 дней наблюдается в поликлинике на больничном.

4.4 После операции

В первые сутки пациент соблюдает постельный режим и молчит; через несколько часов можно сделать несколько глотков воды. Дальше режим щадящий, пища жидкая или протёртая, не горячая и не холодная. Назначают местные и системные обезболивающие и предупреждают обострение сопутствующих болезней.

Для обезболивания и уменьшения воспаления назначают НПВП.

После тонзиллэктомии месяц ограничивают физическую нагрузку, соблюдают режим сна и отдыха.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

При компенсированной форме курсы лечения проводят 2 раза в год. Если 3 года не было ангин и других признаков декомпенсации, пациента снимают с диспансерного учёта.

При декомпенсации в виде рецидивов ангин курсы проводят 3–4 раза в год. Если за год лечение не помогло, ангины осложняются или появляется другой вид декомпенсации, пациента направляют на операцию.

После тонзиллэктомии пациент находится на диспансерном наблюдении 6 месяцев.

Для профилактики рецидивов и восстановления нормальной микрофлоры ротоглотки применяют БАД с естественными бактериями ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

Риск хронического тонзиллита повышают несбалансированное питание (особенно недостаток витаминов A, B, E), переутомление, плохая гигиена жилья и рабочего места, загрязнённый воздух, курение, в том числе пассивное, болезни зубов, носа и пазух, частые ОРВИ и их неправильное лечение.

Лечит обычно оториноларинголог амбулаторно.

В хирургическое отделение госпитализируют при неэффективности лечения, подозрении на гнойное осложнение (паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит) или новообразование и когда нужна операция. Тонзиллэктомию проводят в ЛОР-отделении планово и выписывают на 5–7-е сутки, если послеоперационный период протекает без осложнений.

Тонзиллит чаще переходит в декомпенсированную форму при иммунодефиците (врождённом, на иммунодепрессантах и цитостатиках, при ВИЧ). Аутоиммунные осложнения вероятнее при стрептококковом тонзиллите и ревматической лихорадке у пациента или близких родственников.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический тонзиллит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	683_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- В разделе 1.4 указан код J31.1 «Хронический назофарингит», а в карточке рубрикатора — J31.2 «Хронический фарингит». На сайте приведён код из текста КР.

- Бензидамин в комментарии отнесён к «пенициллинам, чувствительным к бета-лактамазам» (код АТХ J01CE) — это ошибка: бензидамин — нестероидный противовоспалительный препарат для местного применения.